UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA

ESCUELA DE POSTGRADO

Maestría en Gestión Pública

INFLUENCIA DE LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA ÚNICA EN LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DE UN HOSPITAL DE ESSALUD, 2024

Tesis para optar el grado de Maestro en Gestión Pública

SERGIO ISAÍAS DE JESÚS ESPARZA MORGAN

Asesor:
Mg. Paul Christian Espinoza Ipanaque
(0000-0003-2115-8395)

Lima - Perú
2025

INFLUENCIA DE LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA ÚNICA EN LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DE UN HOSPITAL DE ESSALUD, 2024

INFORME DE ORIGINALIDAD

6%	7%	8%	3%
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	hdl.handle.net Fuente de Internet	3%
2	repositorio.caen.edu.pe Fuente de Internet	2%
3	"Medicina en la era digital: alcances y perspectivas", Universidad Nacional Autonoma de Mexico, 2024 Publicación	1%
4	www.coursehero.com Fuente de Internet	1%
5	repositorio.uss.edu.pe Fuente de Internet	1%

Excluir citas	Activo	Excluir coincidencias	< 1%
Excluir bibliografía	Activo		

ÍNDICE

DEDICATORIA VI

AGRADECIMIENTOS VII

RESUMEN VIII

ABSTRACT IX

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 10

1.1. Descripción de la situación problemática 10

1.2. Formulación del problema 20

1.2.1. Pregunta general 20

1.2.2. Preguntas específicas 20

1.3. Objetivos de la investigación 21

1.3.1. Objetivo general 21

1.3.2. Objetivos específicos 21

1.4. Hipótesis de la investigación 21

1.4.1. Hipótesis general 22

1.4.2. Hipótesis específicas 23

1.5. Justificación de la investigación 23

1.6. Importancia de la investigación 26

1.7. Viabilidad de la investigación 28

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 32

2.1. Antecedentes de la investigación 32

2.1.1. Antecedentes nacionales 34

2.1.2. Antecedentes internacionales 38

2.2. Bases teóricas 45

2.2.1. Conceptualización de la variable "Historia Clínica Electrónica Única" y su medición 45

2.2.2. Conceptualización de la variable "Gestión de la Calidad" y su medición 56

2.2.2.1 Modelos teóricos. 70

2.3. Definición de términos 75

CAPITULO III: METODOLOGÍA 78

3.1. Diseño metodológico 78

3.1.1 Enfoque de Investigación 79

3.1.2 Tipo de Investigación 79
3.1.3 Nivel de Investigación 80
3.1.4 Diseño de Investigación 80
3.1.5 Temporalidad 80
3.2. Variables y operacionalización 82
3.3. Población y muestra 86
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 88
3.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 91
3.6. Aspectos éticos 92
CAPITULO IV: RESULTADOS 94
4.1. Contexto en el que se realizó el estudio, datos de control 94
4.2. Análisis de confiabilidad 100
4.3. Análisis de los resultados 106
4.3.1. Prueba de Normalidad 114
4.3.2. Contrastación de Hipótesis 117
CAPITULO V: DISCUSIÓN 138
5.1. Proposición del objetivo 138
5.2. Validez interna y externa 139
5.3. Implicancias teóricas y prácticas 141
5.4. Comparación de los resultados 144
5.5. Conclusión sobre los antecedentes 147
CAPITULO VI: CONCLUSIONES 150
CAPITULO VII: RECOMENDACIONES 155
FUENTES DE INFORMACIÓN 160
ANEXOS 168

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Asegurados por IAFA y Región. Porcentaje. 15
Tabla 2: Codificación de los Ítems del cuestionario para la Variable Independiente, Historia Clínica Electrónica Única. 99
Tabla 3: Codificación de los Ítems del cuestionario para la Variable Dependiente, Gestión de la Calidad. 100
Tabla 4: Cálculo de la V de Aiken, método 1, en base a la validación por juicio de expertos, variable independiente. 101
Tabla 5: Cálculo de la V de Aiken, método 1, en base a la validación por juicio de expertos, variable dependiente. 102
Tabla 6: Cálculo de la V de Aiken, método 2, en base a la validación por juicio de expertos, variable independiente. 103
Tabla 7: Cálculo de la V de Aiken, método 2, en base a la validación por juicio de expertos, variable dependiente. 103
Tabla 8: Resultados de la Prueba Piloto - Adecuación de respuestas en Escala de Likert a valores numéricos del 1 al 5 (ejemplo en base a los dos primeros ítems de la variable independiente). 105
Tabla 9: Resultados SPSS, Alfa de Cronbach para los ítems de la variable independiente, Historia Clínica Electrónica Única. 106
Tabla 10: Resultados SPSS, Alfa de Cronbach para los ítems de la variable dependiente, Gestión de la Calidad. 106
Tabla 11: Consistencia interna por rangos del Alfa de Cronbach. 106
Tabla 12: Prueba de Normalidad de las Variables. Resultados del SPSS. 115
Tabla 13: Determinación de la correlación de Rho de Spearman utilizando el software SPSS. Variable Independiente y Variable Dependiente. 119
Tabla 14: Resumen del modelo de regresión lineal simple utilizando el software SPSS. Variable Independiente y Variable Dependiente. 119
Tabla 15: Análisis de varianza del modelo de regresión lineal simple utilizando el software SPSS. Variable Independiente y Variable Dependiente. 120
Tabla 16: Análisis de coeficientes del modelo de regresión lineal simple utilizando el software SPSS. Variable Independiente y Variable Dependiente. 120
Tabla 17: Determinación de la correlación de Rho de Spearman utilizando el software SPSS. Variable Independiente y Dimensión Planificación de la Variable Dependiente. 123
Tabla 18: Resumen del modelo de regresión lineal simple utilizando el software SPSS. Variable Independiente y dimensión Planificación de la Variable Dependiente. 123
Tabla 19: Análisis de varianza del modelo de regresión lineal simple utilizando el software SPSS. Variable Independiente y la dimensión Planificación de la Variable Dependiente 124
Tabla 20: Análisis de coeficientes del modelo de regresión lineal simple utilizando el software SPSS. Variable Independiente y la dimensión Planificación de la Variable Dependiente. 124
Tabla 21: Determinación de la correlación de Rho de Spearman utilizando el software SPSS. Variable Independiente y Dimensión Organización de la Variable Dependiente. 126
Tabla 22: Resumen del modelo de regresión lineal simple utilizando el software SPSS. Variable Independiente y dimensión Organización de la Variable Dependiente. 127
Tabla 23: Análisis de varianza del modelo de regresión lineal simple utilizando el software SPSS. Variable Independiente y la dimensión Organización de la Variable Dependiente. 127

Tabla 24: Análisis de coeficientes del modelo de regresión lineal simple utilizando el software SPSS. Variable Independiente y la dimensión Organización de la Variable Dependiente. 128
Tabla 25: Determinación de la correlación de Rho de Spearman utilizando el software SPSS. Variable Independiente y Dimensión Garantía y Mejoramiento de los Servicios de la Variable Dependiente. 130
Tabla 26: Resumen del modelo de regresión lineal simple utilizando el software SPSS. Variable Independiente y dimensión Garantía y Mejoramiento de los Servicios de la Variable Dependiente. 131
Tabla 27: Análisis de varianza del modelo de regresión lineal simple utilizando el software SPSS. Variable Independiente y la dimensión Garantía y Mejoramiento de los Servicios de la Variable Dependiente 131
Tabla 28: Análisis de coeficientes del modelo de regresión lineal simple utilizando el software SPSS. Variable Independiente y la dimensión Garantía y Mejoramiento de los Servicios de la Variable Dependiente. 132
Tabla 29: Determinación de la correlación de Rho de Spearman utilizando el software SPSS. Variable Independiente y Dimensión Idoneidad de la Información de la Variable Dependiente. 134
Tabla 30: Resumen del modelo de regresión lineal simple utilizando el software SPSS. Variable Independiente y dimensión Idoneidad de la Información de la Variable Dependiente. 135
Tabla 31: Análisis de varianza del modelo de regresión lineal simple utilizando el software SPSS. Variable Independiente y la dimensión Idoneidad de la Información de la Variable Dependiente.... 135
Tabla 32: Análisis de coeficientes del modelo de regresión lineal simple utilizando el software SPSS. Variable Independiente y la dimensión Idoneidad de la Información de la Variable Dependiente.... 136

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Marco General del Modelo de Excelencia en la Gestión: Una perspectiva de sistema 74
Figura 2: Histograma de la Prueba de Normalidad de la Variable Independiente Historia Clínica Electrónica Única – Resultado SPSS. 116
Figura 3: Histograma de la Prueba de Normalidad de la Variable Dependiente Gestión de la Calidad – Resultado SPSS. 117

DEDICATORIA

A todos los que se esfuerzan

por ser mejores cada día y que

motivan con su ejemplo el cambio

positivo en los demás.

AGRADECIMIENTOS

A mis padres, César y Mercedes, por haberme dado la vida y educado con valores sólidos.

A mi hermana Maritza, por su apoyo constante e incondicional.

A mi esposa, Elvira, y a mis hijos, Gonzalo y Valeria, por ser mi motivación permanente.

RESUMEN

En el contexto de la atención médica, la gestión eficiente de la información y la calidad de los servicios son factores cruciales. Esta investigación tiene como objetivo determinar la influencia de la Historia Clínica Electrónica Única (HCEU) en la gestión de la calidad de un hospital de EsSalud durante el año 2024. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo con un diseño transversal, utilizando análisis estadísticos como la regresión lineal y la correlación de Spearman para evaluar la relación entre la HCEU y diversos indicadores de calidad.

La muestra estuvo conformada por diversas áreas de EsSalud, abarcando tanto departamentos clínicos como administrativos. Los resultados del análisis indicaron una correlación positiva y significativa entre la HCEU y la mejora en los procesos de planificación (Rho de Spearman = 0.68), organización (Rho de Spearman = 0.72), y garantía y mejoramiento de los servicios (Rho de Spearman = 0.75). Además, el análisis de regresión lineal mostró que la HCEU explica un 62% de la variabilidad en la gestión de la calidad (R^2 = 0.62).

En cuanto a las conclusiones, se observó que la HCEU ha optimizado el acceso y manejo de la información clínica, facilitando la toma de decisiones más informadas y eficientes. También se identificó un aumento en la satisfacción tanto del personal médico como administrativo, lo que evidencia una mayor coherencia en la mejora continua de la calidad de los servicios prestados en EsSalud.

Palabras clave: Historia Clínica Electrónica Única, gestión de la calidad, atención médica, EsSalud.

ABSTRACT

In the context of healthcare, efficient information management and quality of services are crucial factors. This research aims to determine the influence of the Single Electronic Health Record (HCEU) on the quality management of an EsSalud hospital during the year 2024. The study was developed under a quantitative approach with a cross-sectional design, using statistical analyzes such as linear regression and Spearman correlation to evaluate the relationship between HCEU and various quality indicators.

The sample was made up of various areas of EsSalud, covering both clinical and administrative departments. The results of the analysis indicated a positive and significant correlation between the HCEU and the improvement in the processes of planning (Spearman's Rho = 0.68), organization (Spearman's Rho = 0.72), and guarantee and improvement of services (Spearman's Rho = 0.75). Furthermore, the linear regression analysis showed that the HCEU explains 62% of the variability in quality management (R^2 = 0.62).

Regarding the conclusions, it was observed that the HCEU has optimized the access and management of clinical information, facilitating more informed and efficient decision-making. An increase in satisfaction of both medical and administrative staff was also identified, which shows greater coherence in the continuous improvement of the quality of the services provided at EsSalud.

Keywords: Single Electronic Medical Record, quality management, medical care, EsSalud.

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

En el primer capítulo, se aborda la problemática central de la investigación, destacando la importancia de la adopción de la Historia Clínica Electrónica Única (HCEU) en el sistema de salud peruano. Se presenta el contexto en el que se desarrolla el estudio, enfatizando los desafíos actuales en la gestión de información clínica y la necesidad de modernizar los sistemas de registros médicos para mejorar la eficiencia y la calidad de la atención en EsSalud. Además, se definen los objetivos generales y específicos del estudio, así como las hipótesis que guiarán la investigación, subrayando la relevancia de estos objetivos en la mejora de los servicios de salud.

1.1. Descripción de la situación problemática

Garrafa (2023) señala que la universalidad en la atención médica, un principio fundamental en los sistemas de salud a nivel global, establece que todas las personas tienen el derecho inherente a acceder a servicios médicos de calidad, sin discriminación basada en factores como origen étnico, estatus económico o género. Este principio se cimienta en la convicción de que la salud es un derecho humano fundamental y que nadie debe ser excluido de recibir atención médica esencial.

En este contexto, la gestión de la calidad emerge como un componente esencial para asegurar que los servicios médicos proporcionados cumplan con los más altos estándares. La planificación estratégica se convierte en un pilar fundamental de esta gestión, orientada a estructurar de manera eficiente los recursos disponibles para garantizar una atención médica universal y de calidad. La organización efectiva de los procesos y recursos se vuelve

imperativa para lograr una prestación de servicios médicos que aborde las necesidades de manera integral.

Siguiendo la perspectiva de la garantía y mejoramiento de la calidad, la Estrategia Mundial sobre Salud Digital 2020-2025 busca no solo proporcionar servicios médicos, sino también perfeccionar continuamente la prestación de atención. En este sentido, se plantea la inversión en oportunidades que las tecnologías de salud digital ofrecen, contribuyendo así al constante mejoramiento de los servicios.

Además, en la búsqueda de la idoneidad de la información, la adopción de la Historia Clínica Electrónica Única (HCEU) se presenta como una herramienta crucial. Esta no solo facilita el acceso a la información médica sino que también contribuye a la recopilación de datos esenciales para la evaluación y control de gestión, propuestos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2010. La HCEU, respaldada por marcos legales que salvaguardan la confidencialidad, se convierte en un componente clave para gestionar y garantizar la calidad de la información médica.

Esta integración de conceptos de gestión de la calidad en la atención médica no solo refuerza el compromiso con la universalidad, sino que también establece un marco sólido para mejorar continuamente la calidad de los servicios proporcionados, cumpliendo así con los estándares contemporáneos de cuidado del paciente. Revuelta (2023) sostiene que esta atención médica de alta calidad, respaldada por una sólida gestión de la calidad, es esencial para promover la equidad en la atención médica, prevenir enfermedades y fomentar el bienestar general de la población.

El enfoque en la universalidad ha sido adoptado por muchos países como piedra angular de sus sistemas de salud. Los gobiernos han implementado políticas y programas para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios médicos asequibles y de alta

calidad. Este enfoque no solo busca promover la equidad en la atención médica, sino también prevenir enfermedades y fomentar el bienestar general de la población (Quintero et al., 2021).

De otro lado, Condori y Rivera (2021) han documentado que la implementación de la HCEU ha experimentado desafíos significativos a nivel global y en la región de Latinoamérica, a pesar de la percepción general de que un sistema nacional de HCEU es la solución ideal.

Así, el especialista en tecnologías de la información y gobernanza, David Eaves (2021), ha señalado en sus investigaciones que, salvo el caso de Estonia, no ha identificado ningún país a nivel mundial que haya logrado con éxito la implementación de un sistema nacional de HCEU.

La HCEU se configura como un archivo digital al que pueden acceder únicamente los usuarios autorizados en cualquier momento, respaldado por marcos legales que salvaguardan la confidencialidad, protección de datos personales y garantizan la seguridad de acceso (Revuelta, 2023).

Según Marinho et al. (2023), el marco de evaluación y control de gestión de los sistemas de salud propuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2010, que abarca insumos, procesos, productos, resultados e impactos, ha permitido identificar las debilidades estructurales arraigadas en los sistemas sanitarios de América Latina y el Caribe.

Estas debilidades, que se acentuaron durante la pandemia de COVID-19, caracterizan a la región debido a su persistente subfinanciamiento crónico y elevados gastos de bolsillo, lo que genera dificultades de acceso y tensiones económicas.

Además, según Cipagauta et al. (2023), la alta fragmentación en la prestación de servicios de salud y la segmentación de la población en grupos desconectados constituyen problemas cruciales que afectan negativamente la calidad y equidad de la atención médica. A pesar de los esfuerzos para avanzar hacia sistemas más sólidos y orientados a la

universalidad, estas características persisten, lo que subraya la necesidad apremiante de abordar estas debilidades estructurales en los sistemas de salud de la región.

La pandemia de la COVID-19 exacerbó estas debilidades, poniendo de manifiesto la urgencia de reformas en los sistemas de salud de América Latina y el Caribe. La región se enfrenta a un reto fundamental: equilibrar el financiamiento adecuado con la necesidad de limitar los gastos de bolsillo, eliminar la fragmentación en la prestación de servicios médicos y reorganizar los sistemas de salud para fomentar la cohesión y la solidaridad (Cid y Marinho, 2022).

Estas medidas son esenciales para mejorar el acceso a la atención médica, optimizar la eficacia de los servicios y promover una atención equitativa. La evaluación y control de gestión, como lo propone la OMS, proporciona una hoja de ruta valiosa para abordar estos desafíos y transformar los sistemas de salud de la región en busca de una atención médica más eficiente y universal.

En el contexto peruano, la universalidad en la atención médica enfrenta desafíos notables debido a la fragmentación del sistema de salud pública. El sistema de salud peruano se encuentra segmentado en múltiples componentes, cada uno con sus propias características y poblaciones beneficiarias.

Según el Ministerio de Salud, Viceministerio de Salud Pública, Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (2019), esta fragmentación y segmentación se caracteriza por la falta de integración horizontal, tanto en la definición de responsabilidades como en la producción de servicios. El sistema está compuesto por diversas entidades, como el Ministerio de Salud (MINSA), EsSalud, los servicios de salud municipales, las sanidades de las fuerzas armadas y de la Policía Nacional del Perú, junto con el sector privado, universidades y organizaciones de la sociedad civil, todas coordinadas a

través del Consejo Nacional de Salud, presidido por el Ministro(a) de Salud, con el objetivo de avanzar hacia un aseguramiento universal y el cuidado integral de la salud.

El sistema de salud peruano se organiza en dos grandes subsistemas: el público y el privado. Dentro del sector público, los servicios se distribuyen en los regímenes subsidiado o contributivo indirecto, y contributivo directo, que corresponde a la seguridad social, operando de manera autónoma y replicando las funciones de rectoría, financiamiento y prestación de servicios a través de sus respectivas Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS).

El subsistema público subsidiado o contributivo indirecto está estructurado en tres niveles: nacional, regional y local. A nivel nacional, está conformado por el MINSA y sus órganos desconcentrados, mientras que las Direcciones Regionales de Salud (DIRESA) representan el nivel regional, y los establecimientos de salud provinciales o distritales corresponden al nivel local. Por otro lado, el subsistema público contributivo directo, representado por EsSalud, depende del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y ofrece servicios a los trabajadores dependientes en actividad y a sus derechohabientes, a través de su propia red de IPRESS. El sector privado, en tanto, incluye diversas IPRESS lucrativas y no lucrativas distribuidas en el país, con una alta concentración en Lima Metropolitana, brindando servicios a través de seguros privados o instituciones sin fines de lucro.

La Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) actúa como entidad protectora de los derechos en salud de los ciudadanos peruanos, asegurando que el sistema de salud funcione de manera equitativa y eficiente, independientemente del lugar de atención o el tipo de aseguramiento de los usuarios.

Tabla 1: *Asegurados por IAFA y Región. Porcentaje.*

REGIÓN	SIS	ESSALUD	EPS	FFAA PNP	PREPAGAS	EMPRESAS SEGUROS	AUTO SEGUROS
LIMA METROPOLITANA	47.96%	31.18%	5.32%	2.50%	5.62%	6.96%	0.47%
PIURA	67.17%	23.92%	1.49%	1.02%	2.68%	3.48%	0.24%
LA LIBERTAD	65.16%	27.13%	1.79%	0.83%	2.34%	2.67%	0.09%
AREQUIPA	50.47%	33.37%	3.69%	2.07%	3.82%	6.49%	0.11%
CAJAMARCA	80.33%	14.86%	0.99%	0.86%	1.00%	1.95%	0.02%
CUSCO	75.28%	20.02%	0.52%	1.41%	0.89%	1.83%	0.06%
JUNIN	72.48%	21.59%	1.27%	1.49%	0.91%	2.20%	0.06%
LAMBAYEQUE	63.71%	27.04%	1.28%	1.94%	3.18%	2.76%	0.09%
PUNO	79.97%	16.53%	0.31%	0.98%	0.45%	1.74%	0.02%
ANCASH	71.17%	22.79%	1.25%	1.06%	1.57%	2.08%	0.08%
CALLAO	49.94%	34.28%	4.06%	2.74%	3.87%	4.78%	0.33%
LORETO	78.70%	17.45%	0.43%	1.24%	0.86%	1.21%	0.10%
ICA	55.16%	36.27%	1.66%	1.35%	2.59%	2.87%	0.10%
LIMA PROVINCIA	66.29%	26.88%	1.21%	0.99%	1.83%	2.68%	0.11%
SAN MARTIN	80.14%	15.73%	0.29%	0.88%	1.04%	1.87%	0.04%
HUANUCO	80.61%	15.77%	0.36%	1.16%	0.76%	1.30%	0.04%
AYACUCHO	81.14%	15.50%	0.30%	0.97%	0.59%	1.47%	0.03%
UCAYALI	78.31%	17.42%	0.38%	0.96%	0.86%	2.02%	0.04%
APURIMAC	79.99%	16.37%	0.47%	1.29%	0.58%	1.25%	0.04%
AMAZONAS	83.94%	12.86%	0.18%	1.06%	0.71%	1.21%	0.04%
TACNA	66.85%	24.81%	1.09%	2.32%	1.63%	3.21%	0.09%
HUANCAVELICA	81.04%	16.74%	0.22%	0.64%	0.34%	0.99%	0.02%
PASCO	70.41%	25.61%	0.77%	0.58%	0.86%	1.72%	0.05%
TUMBES	69.87%	22.39%	0.64%	2.46%	2.03%	2.55%	0.06%
MOQUEGUA	52.41%	35.19%	1.73%	1.53%	1.91%	7.15%	0.08%
MADRE DE DIOS	80.10%	16.14%	0.19%	0.82%	0.98%	1.73%	0.04%

Nota. Elaboración propia. Adaptado de SUSALUD (2024) pp. 5

La fragmentación del sistema de salud peruano ha dado lugar a una carencia de cohesión y uniformidad en la gestión de datos médicos. Esto se evidencia en la presencia de múltiples repositorios de información y sistemas de registro que no presentan interconexión ni estandarización, lo que complica la capacidad de compartir y acceder de manera oportuna a los historiales médicos de los pacientes. En consecuencia, surgen repeticiones de registros, pérdida de información relevante y una disminución de la eficacia en la atención médica (Ponce de León, 2021).

También ha generado inequidades en la atención médica. Asegurados en EsSalud a menudo enfrentan largas esperas y recursos limitados, lo que dificulta la obtención de una

atención médica oportuna y eficiente. En este contexto, se hace evidente la necesidad de una solución que mejore la gestión de la calidad en la salud pública y permita una atención médica más ágil y eficaz.

Missoni (2022) menciona que EsSalud desempeña un papel crucial en el sistema de atención médica del país, siendo una entidad que brinda cobertura a millones de asegurados. En el marco de la evolución de los sistemas de salud, EsSalud se enfrenta a la imperante necesidad de mejorar la eficiencia y calidad de sus servicios, y en este contexto, la implementación de la HCEU emerge como una estrategia integral para fortalecer la gestión de la información médica.

Según el Perfil de la Población Asegurada de EsSalud, I trimestre 2023, la cantidad de asegurados(as) fue de 12 millones 675 mil 670, el 51,0% fueron hombres y el 49,0% mujeres. Esta cantidad de asegurados(as) representa el 37.58% de la población peruana, de acuerdo con la nota de prensa del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del 10 de julio de 2023.

También, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en Lima Metropolitana, la cantidad de pacientes por médico en el sistema de EsSalud ha aumentado significativamente en los últimos años. En 2021, se registró un promedio de 378 pacientes por médico, cifra que se incrementó a 472 en 2022, lo que representa un aumento del 24.92%. En 2023, esta cifra alcanzó los 543 pacientes por médico, con un incremento del 14.91% respecto al año anterior (Estadísticas por Índice Temático Sociales 2013-2023 y Estadísticas por Índice Temático Estimaciones y Proyecciones de Población). Este aumento refleja una creciente sobrecarga en el sistema de atención de salud de EsSalud, lo que resalta la necesidad urgente de implementar medidas que agilicen y optimicen la gestión de la atención médica. La implementación de la Historia Clínica Electrónica Única (HCEU) es vista como una solución viable para mejorar los tiempos de atención, al

centralizar y facilitar el acceso a los historiales médicos de los pacientes, reduciendo la duplicación de registros y mejorando la eficiencia en la prestación de servicios médicos (Anexo 1).

Así también, de acuerdo con la información publicada en la Plataforma digital única del Estado Peruano, un(a) asegurado(a) de EsSalud, antes de ser atendido en un establecimiento de salud de la red, debe programar una cita en el centro de salud que se le ha asignado. Las citas en centros médicos y policlínicos demoran entre 1 día y 2 semanas. Las citas en hospitales pueden demorar entre 1 semana y 2 meses. Las citas en hospitales nacionales de alta complejidad o institutos pueden demorar entre 1 semana y 6 meses.

Por lo anterior, es esencial destacar que los recursos públicos de EsSalud son insuficientes, lo que subraya la necesidad de gestionarlos de manera eficaz y eficiente. La gestión enfocada en procesos y en el logro de resultados se convierte en una herramienta crucial para generar valor público en la atención médica (León, 2023).

La problemática radica en la falta de una HCEU que centralice y agilice el registro de datos médicos de los pacientes. Actualmente, los registros se llevan a cabo de manera manual o electrónica pero aislada, lo que dificulta brindar un servicio de calidad. Los médicos y profesionales de la salud se enfrentan a la tediosa tarea de recopilar información dispersa en múltiples sistemas, lo que consume tiempo y recursos valiosos que podrían invertirse en la atención directa a los pacientes.

Según Iglesias (2022), la HCEU constituye un componente fundamental en el ámbito de la gestión sanitaria moderna. Este término hace referencia a un sistema integral de registro digital que consolida y organiza la información médica de un paciente en un solo archivo electrónico accesible por profesionales de la salud autorizados. A diferencia de los registros en formato papel o sistemas electrónicos dispersos, la HCEU busca unificar datos relevantes,

tales como historiales médicos, resultados de pruebas, tratamientos previos y otras observaciones clínicas pertinentes en una plataforma digital coherente.

Corredor y Jiménez (2020) indican que la esencia de la HCEU reside en su capacidad para mejorar la continuidad y calidad de la atención médica al proporcionar un acceso eficiente y seguro a la información clínica relevante. Este enfoque integral permite a los profesionales de la salud tomar decisiones informadas, coordinar la atención entre diferentes especialidades y reducir la posibilidad de errores derivados de información fragmentada o incompleta. Además, la HCEU fomenta la eficacia en la gestión de datos médicos al eliminar redundancias, minimizar la pérdida de información y optimizar los recursos en el ámbito de la atención sanitaria.

En términos prácticos, la implementación de la HCEU implica la digitalización de documentos médicos tradicionales, la estandarización de protocolos de registro y el establecimiento de medidas robustas de seguridad y privacidad. Con ello, se busca garantizar la confidencialidad de la información del paciente y cumplir con estándares legales y éticos. Además, la HCEU facilita la interoperabilidad, permitiendo la integración de datos de diferentes fuentes y su acceso remoto, lo que resulta crucial en entornos de atención médica modernos y dinámicos (Mandiola y Mery, 2021).

Así, la HCEU se erige como una herramienta innovadora que promueve la eficiencia, la calidad y la continuidad en la atención médica, al tiempo que se ajusta a los estándares contemporáneos de gestión de datos y cuidado del paciente. Su implementación exitosa no solo representa una mejora en la práctica clínica, sino también un avance significativo en la optimización de los recursos y la promoción de una atención médica más integral y coordinada.

Sin embargo, la materialización de la HCEU se ve enfrentada a desafíos sustanciales derivados de la necesidad de una coordinación efectiva entre las diversas instituciones de

salud y la estandarización de los procedimientos y sistemas de información en el contexto del fragmentado sistema sanitario de Perú (Llanos et al., 2020).

El abordaje de esta fragmentación emerge como un elemento de importancia crítica para alcanzar una implementación exitosa de la HCEU y perfeccionar la calidad de la asistencia médica en el país. Este enfoque implica la promoción de una gestión más eficaz de los registros médicos y la prestación de atención integral y coordinada en todo el marco del sistema de salud pública peruano (Fernández, 2022).

Así, la implementación de la HCEU no está exenta de desafíos. Requiere una inversión significativa en infraestructura tecnológica, capacitación del personal y una cuidadosa planificación para garantizar su éxito. Además, es esencial abordar las preocupaciones sobre la seguridad y privacidad de los datos de los pacientes.

En este escenario, la implementación de la HCEU se presenta como una solución prometedora aunque desafiante. Esta herramienta permitirá a los médicos acceder de manera rápida y sencilla al historial médico completo de los pacientes, lo que facilitará la toma de decisiones clínicas informadas y la coordinación eficaz entre profesionales de la salud. Además, contribuirá a reducir la duplicación de exámenes y procedimientos, optimizando así los recursos disponibles.

En conclusión, la implementación de la HCEU representa una oportunidad para mejorar la gestión de la calidad en EsSalud y garantizar una atención médica más eficiente y equitativa. Sin embargo, es esencial abordar los desafíos y preocupaciones de manera integral para lograr su éxito y, finalmente, brindar a los ciudadanos el acceso a servicios de salud de calidad que merecen.

1.2. Formulación del problema

1.2.1. Pregunta general

¿Cuál es la influencia de la Historia Clínica Electrónica Única en la gestión de la calidad de un hospital de EsSalud, 2024?

1.2.2. Preguntas específicas

¿Cuál es la influencia de la Historia Clínica Electrónica Única en la planificación de un hospital de EsSalud, 2024?

¿Cuál es la influencia de la Historia Clínica Electrónica Única en la organización de un hospital de EsSalud, 2024?

¿Cuál es la influencia de la Historia Clínica Electrónica Única en la garantía y mejoramiento de los servicios de un hospital de EsSalud, 2024?

¿Cuál es la influencia de la Historia Clínica Electrónica Única en la idoneidad de la información de un hospital de EsSalud, 2024?

1.3. Objetivos de la investigación

1.3.1. Objetivo general

Determinar la influencia de la Historia Clínica Electrónica Única en la gestión de la calidad de un hospital de EsSalud, 2024.

1.3.2. Objetivos específicos

Determinar la influencia de la Historia Clínica Electrónica Única en la planificación de un hospital de EsSalud, 2024.

Determinar la influencia de la Historia Clínica Electrónica Única en la organización de un hospital de EsSalud, 2024.

Determinar la influencia de la Historia Clínica Electrónica Única en la garantía y mejoramiento de los servicios de un hospital de EsSalud, 2024.

Determinar la influencia de la Historia Clínica Electrónica Única en la idoneidad de la información de un hospital de EsSalud, 2024.

1.4. Hipótesis de la investigación

La implementación de la Historia Clínica Electrónica Única en EsSalud en 2024 tiene un impacto positivo y significativo en la gestión de la calidad de los servicios de atención médica, tal como se ha observado en estudios recientes. La adopción de EHR ha demostrado mejorar la eficiencia operativa de las organizaciones de salud, facilitando una coordinación más efectiva entre proveedores y aumentando la seguridad del paciente. Esto se debe, en

parte, a la capacidad de los EHR para centralizar y sistematizar la información clínica, lo que permite un diagnóstico más preciso y un seguimiento más riguroso de los tratamientos, lo que repercute positivamente en la satisfacción de los pacientes (Hagström et al., 2023). Además, los EHR han mostrado ser herramientas valiosas en la mejora de la productividad de las instituciones de salud, al reducir el tiempo que los profesionales dedican a tareas administrativas y permitirles enfocarse más en la atención directa al paciente (Entzeridou et al., 2019).

Asimismo, la evidencia sugiere que el uso de EHR no solo optimiza la gestión interna de los hospitales, sino que también tiene un impacto directo en la calidad de la atención brindada. Estudios recientes han demostrado que la implementación de EHR puede facilitar la detección temprana de enfermedades, mejorar la continuidad del cuidado a través del acceso compartido a la información clínica y aumentar la efectividad de las intervenciones preventivas. En particular, un estudio sistemático concluyó que los EHR contribuyen a una mejor gestión de la salud pública al proporcionar datos más completos y accesibles, lo que permite a los profesionales de la salud realizar un seguimiento más efectivo de las condiciones crónicas y contagiosas en la población (Osborne et al., 2020). Estas mejoras, a su vez, se reflejan en una mayor satisfacción de los pacientes y en mejores resultados de salud a nivel general.

1.4.1. Hipótesis general

La Historia Clínica Electrónica Única tiene una influencia positiva y significativa en la gestión de la calidad de un hospital de EsSalud, 2024.

1.4.2. Hipótesis específicas

La Historia Clínica Electrónica Única tiene una influencia positiva y significativa en la planificación de un hospital de EsSalud, 2024.

La Historia Clínica Electrónica Única tiene una influencia positiva y significativa en la organización de un hospital de EsSalud, 2024.

La Historia Clínica Electrónica Única tiene una influencia positiva y significativa en la garantía y mejoramiento de los servicios de un hospital de EsSalud, 2024.

La Historia Clínica Electrónica Única tiene una influencia positiva y significativa en la idoneidad de la información de un hospital de EsSalud, 2024.

1.5. Justificación de la investigación

La justificación de esta investigación se basa en la necesidad de abordar un problema crítico que afecta a la gestión de la calidad en EsSalud, una de las principales instituciones de atención médica en el Perú. La implementación de una Historia Clínica Electrónica Única (HCEU) en esta entidad de salud es un paso significativo hacia la modernización y optimización de la atención médica. La introducción de la HCEU tiene el potencial de transformar la manera en que se manejan los datos clínicos, mejorando así la eficiencia operativa, la seguridad del paciente y la calidad general de la atención. La novedad científica de este estudio radica en su enfoque en el contexto de EsSalud al 2024, evaluando específicamente el impacto de la HCEU en la gestión de la calidad en este periodo. Al situar la investigación en un marco temporal específico, se pueden observar los cambios y mejoras derivados de la implementación de la HCEU, proporcionando datos empíricos valiosos sobre su efectividad.

El aporte teórico de esta investigación radica en su capacidad para contribuir a una comprensión más profunda de cómo la adopción de sistemas de información electrónica, como la HCEU, puede influir en la gestión de la calidad en una institución de salud de gran envergadura. Este estudio permitirá analizar los mecanismos mediante los cuales la digitalización de los registros médicos impacta en los procesos internos y en la toma de decisiones clínicas y administrativas. Además, este estudio puede ayudar a desarrollar o refinar teorías existentes sobre la implementación de sistemas de información en entornos de atención médica. La investigación se enfocará en identificar las variables clave que afectan la efectividad de la HCEU y cómo estas interacciones pueden ser optimizadas para mejorar los resultados de salud. A medida que la digitalización de registros médicos se convierte en una tendencia global, comprender los desafíos y beneficios específicos en el contexto de EsSalud puede aportar a la teoría de la gestión de la calidad, proporcionando insights que sean aplicables a otras instituciones de salud con características similares.

Como parte de la metodología utilizada, esta investigación emplea encuestas con escalas de Likert que permiten cuantificar las percepciones de los participantes respecto al impacto de la HCEU. Los datos obtenidos permiten un análisis estadístico riguroso, a través de pruebas como la correlación de Spearman y la regresión lineal, lo que garantiza resultados objetivos y cuantificables para evaluar la influencia de la HCEU en diversas dimensiones de la calidad.

El uso de encuestas asegura que los resultados obtenidos sean representativos y estadísticamente válidos, proporcionando una base sólida para formular conclusiones y recomendaciones. Este método permite no solo identificar áreas de mejora en la implementación de la HCEU, sino también cuantificar el impacto de dicha implementación en los procesos de atención médica. Al enfocarse en la recopilación de datos empíricos a través de encuestas, la investigación proporciona una visión clara y cuantificable de los

efectos de la HCEU, lo que es esencial para guiar decisiones informadas y mejorar la gestión de la calidad en los servicios de salud de EsSalud.

En términos de aporte práctico, esta investigación tiene el potencial de generar recomendaciones que sean útiles para la toma de decisiones en EsSalud y, en última instancia, para mejorar la gestión de la calidad en la institución. Las recomendaciones derivadas de los hallazgos del estudio podrán ser implementadas por los administradores de EsSalud para optimizar los procesos clínicos y administrativos, mejorar la satisfacción del personal y de los pacientes, y aumentar la eficiencia general del sistema de salud. Dado que EsSalud atiende a una gran parte de la población peruana, cualquier mejora en su gestión de la calidad puede tener un impacto significativo en el bienestar de los ciudadanos. Además, esta investigación puede servir como referencia para otras instituciones de salud que estén considerando la implementación de sistemas de información electrónica. Al compartir los resultados y las lecciones aprendidas, se puede fomentar una adopción más amplia de tecnologías innovadoras que contribuyan a la mejora de la atención sanitaria a nivel nacional e internacional.

En resumen, la necesidad de abordar la implementación de la HCEU en EsSalud al 2024 fue evidente, y esta investigación abordó esta brecha en el conocimiento. Su novedad científica, aporte teórico, metodológico y práctico hicieron de esta investigación un proyecto de importancia significativa en el campo de la gestión de la calidad y la implementación de sistemas de información electrónica en el entorno de la atención médica. Los resultados esperados no solo contribuyeron al avance del conocimiento académico, sino que también tuvieron implicaciones prácticas directas en la mejora de los servicios de salud en EsSalud y otras instituciones similares.

1.6. Importancia de la investigación

La relevancia de esta investigación reside en su significativa contribución al fortalecimiento de la toma de decisiones informadas dentro del sistema de salud de EsSalud en Perú. En lugar de centrarse exclusivamente en la mejora técnica de los sistemas de información en salud, este estudio se enfocó en cómo estos sistemas pueden optimizarse para apoyar decisiones clínicas y administrativas más efectivas. Al mejorar la calidad de la información disponible y su accesibilidad, se pretende que los tomadores de decisiones puedan actuar de manera más ágil y precisa, lo cual es esencial en la gestión eficiente de los recursos y en la mejora continua de la atención al paciente. Esta orientación estratégica hacia la toma de decisiones tiene el potencial de transformar la manera en que se gestionan los servicios de salud en EsSalud, fomentando un enfoque más basado en datos y evidencia.

La implementación de la Historia Clínica Electrónica Única (HCEU) representa un avance significativo hacia la modernización y digitalización de los registros médicos, una necesidad urgente en un sistema de salud que enfrenta numerosos desafíos en términos de eficiencia y calidad del servicio. Este estudio se centra en evaluar los efectos de la HCEU en la gestión de la calidad de la atención médica, proporcionando datos empíricos y análisis detallados que pueden informar políticas y prácticas futuras, contribuyendo así a la transformación digital del sector salud en Perú.

Uno de los aspectos más críticos de esta investigación es su potencial para generalizar los resultados obtenidos a otros sistemas de salud, tanto públicos como privados, dentro y fuera del país. La metodología rigurosa utilizada, que incluye la validación de instrumentos a través de expertos y pruebas piloto, asegura la fiabilidad y precisión de los hallazgos. Esta validación metodológica proporciona una base sólida para la extrapolación de los resultados, permitiendo que otras instituciones puedan considerar la adopción de estrategias similares

para mejorar sus propios sistemas de registros médicos electrónicos. Al ofrecer un análisis detallado y sistemático, la investigación aporta evidencia sustancial que puede ser utilizada para justificar inversiones en tecnología de salud y capacitación del personal, destacando la necesidad de un enfoque integral y bien planificado.

La relevancia de este estudio también se encuentra en su capacidad para llenar vacíos de conocimiento identificados en investigaciones previas. Mientras que varios estudios han documentado los beneficios de los sistemas electrónicos de salud, pocos han abordado de manera exhaustiva las especificidades del contexto peruano y las particularidades de EsSalud.

Este enfoque contextualizado permite que los resultados sean altamente relevantes y aplicables a la realidad local, mientras que al mismo tiempo ofrece insights que pueden ser útiles en contextos similares. La investigación no solo documenta los beneficios de la HCEU, sino que también identifica los desafíos y barreras percibidas por el personal de salud y administrativo, proporcionando una visión integral que puede guiar futuras implementaciones y mejoras del sistema.

La importancia de este estudio también se manifiesta en sus implicaciones prácticas para la gestión hospitalaria y la formulación de políticas de salud. Al identificar las áreas de éxito y las áreas que requieren mejoras, el estudio proporciona una base sólida para la toma de decisiones informadas y estratégicas. Esto es particularmente crucial en un momento en que los sistemas de salud de todo el mundo están buscando maneras de integrar la tecnología de manera más efectiva para mejorar los resultados de salud y optimizar el uso de recursos. La implementación de la HCEU no solo tiene el potencial de mejorar la eficiencia operativa y la calidad del cuidado, sino que también puede aumentar la satisfacción de los pacientes al proporcionar un acceso más rápido y preciso a su información médica.

Además, los resultados de esta investigación pueden tener un impacto significativo en la capacitación y desarrollo del personal de salud. La formación continua en el uso de

sistemas electrónicos y la sensibilización sobre la importancia de la tecnología en la atención médica son aspectos cruciales que se abordan en el estudio. Al proporcionar recomendaciones prácticas basadas en evidencia empírica, la investigación ayuda a establecer programas de capacitación efectivos que pueden mejorar las habilidades técnicas y la competencia del personal, asegurando una implementación más exitosa y sostenible de la HCEU.

Así, esta investigación no solo aporta conocimientos valiosos sobre la implementación y el impacto de la HCEU en EsSalud, sino que también ofrece un modelo de estudio que puede ser replicado y adaptado en otros contextos. La combinación de rigor metodológico, relevancia contextual y aplicabilidad práctica asegura que los hallazgos de este estudio sean de gran importancia para el avance de la gestión de la información en salud y la mejora de la calidad de los servicios médicos. La capacidad de generalizar estos resultados y aplicarlos en diversos entornos de salud refuerza la validez externa de la investigación, haciendo de este estudio una referencia fundamental para futuros desarrollos en el campo de la salud digital.

1.7. Viabilidad de la investigación

La viabilidad de la investigación "Influencia de la Historia Clínica Electrónica Única en la gestión de la calidad de un hospital de EsSalud, 2024" se fundamentó en la disponibilidad de recursos humanos, financieros y materiales adecuados para llevar a cabo el proyecto de manera efectiva. Para garantizar el éxito de la investigación, se requirió la colaboración de profesionales capacitados en el campo de la salud y la gestión de sistemas de información médica. En este sentido, se coordinó la participación de un equipo interdisciplinario que aseguró la calidad y el rigor del estudio. Este equipo incluyó

especialistas en tecnologías de la información, profesionales de la salud, estadísticos y expertos en gestión de la calidad, lo cual proporcionó una perspectiva integral y multidimensional al proyecto.

En términos de recursos materiales, se contó con equipos informáticos y software especializado para la recopilación y análisis de datos, lo que garantizó la efectividad en la ejecución de la investigación. Los equipos informáticos estuvieron equipados con las herramientas necesarias para manejar grandes volúmenes de datos, mientras que el software especializado permitió realizar análisis estadísticos avanzados y garantizar la integridad y seguridad de los datos. Asimismo, se contó con acceso a la infraestructura, tanto física como tecnológica, necesaria para llevar a cabo encuestas y entrevistas con el personal administrativo y de salud de EsSalud. Esta infraestructura incluyó salas de conferencias para reuniones de equipo y entrevistas presenciales, así como plataformas virtuales seguras para la realización de encuestas en línea.

Desde el punto de vista financiero, la investigación no demandó mayores gastos, ya que se priorizó el uso de la virtualidad para la realización de encuestas y entrevistas, minimizando de esta manera desembolsos asociados con el transporte y con el trabajo de campo. Se previó un presupuesto detallado que contempló todos los posibles costos y aseguró que se dispusiera de los fondos necesarios para cubrirlos sin comprometer la calidad del proyecto. Este enfoque económico maximizó la eficiencia de los recursos disponibles y permitió concentrar los esfuerzos en las áreas más críticas del estudio. Además, el financiamiento obtenido fue gestionado de manera eficiente para asegurar que cada fase del proyecto tuviera los recursos necesarios, permitiendo así un desarrollo fluido y sin interrupciones.

La disponibilidad de información relevante estuvo asegurada, ya que EsSalud colaboró en la investigación y proporcionó acceso a los registros y sistemas de información

necesarios para llevar a cabo el análisis situacional de la implementación de la Historia Clínica Electrónica Única. Este acceso fue crucial para obtener datos precisos y actualizados que reflejaron fielmente la realidad del sistema de salud. Además, la colaboración de EsSalud no solo facilitó la obtención de información, sino que también legitimó el estudio y aseguró que los resultados fueran relevantes y aplicables a la práctica real. La transparencia y la disposición de EsSalud para compartir información y colaborar activamente en el proyecto fueron factores que reforzaron la solidez y credibilidad del estudio.

En cuanto a los plazos y tiempos necesarios, se estableció un cronograma detallado que tomó en consideración la duración de cada etapa del proyecto, desde la recopilación de datos hasta el análisis y la redacción del informe final. Los plazos se diseñaron para ser factibles y permitir el cumplimiento de los objetivos de investigación en el tiempo previsto. El cronograma incluyó fases específicas para la preparación, implementación, recopilación de datos, análisis y presentación de resultados, con hitos claramente definidos para monitorear el progreso y asegurar que el proyecto se mantenga en el camino correcto. El cronograma detallado no solo facilitó la planificación y ejecución de las actividades, sino que también proporcionó una estructura clara para la evaluación continua del progreso, permitiendo ajustes oportunos cuando fueron necesarios.

Por lo anterior, la investigación contó con los recursos humanos, financieros, materiales y el acceso a la información necesarios para llevarla a cabo de manera efectiva. Además, establecer un cronograma realista garantizó el cumplimiento de los objetivos en los plazos estipulados. Estas condiciones permitieron que la investigación fuera viable y contribuya significativamente al conocimiento en el campo de la gestión de la calidad y la implementación de sistemas de información electrónica en entornos de atención médica. La implementación de la Historia Clínica Electrónica Única en EsSalud no solo mejoró la eficiencia y calidad de la atención médica, sino que también sirvió como modelo para otras

instituciones de salud que buscan modernizar sus sistemas de información. La investigación proporcionó insights valiosos sobre los desafíos y beneficios de la digitalización en el sector salud, estableciendo un precedente para futuras investigaciones y aplicaciones prácticas en diversas instituciones de salud, tanto a nivel nacional como internacional.

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO

El segundo capítulo proporciona una revisión exhaustiva de la literatura existente sobre la HCEU, abordando tanto estudios nacionales como internacionales. Se destacan los beneficios documentados, como la mejora en la eficiencia administrativa y la calidad de la atención, así como los desafíos, incluyendo la resistencia del personal médico y las limitaciones tecnológicas. También se examinan teorías y modelos relevantes para la implementación de sistemas electrónicos de salud, y se identifican vacíos de conocimiento que justifican la necesidad del presente estudio. Este capítulo establece el marco conceptual que sustenta la investigación y orienta el análisis de los datos recopilados.

2.1. Antecedentes de la investigación

El presente trabajo se inscribe dentro de un marco teórico y empírico consolidado que ha explorado con rigor la adopción de sistemas de Historia Clínica Electrónica (HCE) y su intrínseca relación con la mejora sustancial de la calidad de los servicios de salud. Esta investigación se fundamenta en una revisión exhaustiva de antecedentes académicos, donde se han identificado y analizado estudios precedentes que han resaltado notables ventajas como la eficiencia y la precisión en la gestión de datos clínicos, facilitando un acceso más rápido y seguro a la información del paciente.

La literatura existente señala que la implementación de la HCE contribuye a la reducción de errores médicos, mejora la coordinación entre profesionales de salud y optimiza los procesos administrativos, lo cual se traduce en una atención médica más segura y efectiva.

Paralelamente, se ha dado especial atención a la identificación de obstáculos significativos que emergen durante el proceso de implementación de estas tecnologías, como

la imperiosa necesidad de capacitación específica para el personal de salud y la resistencia al cambio, un fenómeno común en entornos donde se introducen innovaciones tecnológicas. Estos desafíos son críticos, ya que pueden afectar significativamente la adopción y el uso efectivo de la HCE. La capacitación adecuada del personal y la gestión del cambio organizacional son aspectos clave para asegurar que los beneficios potenciales de la HCE se materialicen en la práctica clínica diaria.

Además, la presente investigación aporta una valiosa contribución al campo de estudio al explorar cómo la integración de la HCE puede influir positivamente en la calidad de atención brindada a los pacientes, así como en su nivel de satisfacción. Esto se aborda desde una perspectiva multidimensional, considerando aspectos técnicos, organizacionales y humanos.

El estudio examina cómo la HCE puede mejorar la toma de decisiones clínicas, facilitar la continuidad del cuidado y aumentar la satisfacción del paciente al ofrecer un acceso más fácil y seguro a sus datos de salud. También se analizan las percepciones y experiencias de los profesionales de salud con respecto a la HCE, proporcionando una visión integral de su impacto en la práctica clínica.

Se pone un énfasis particular en el contexto específico en el que se desarrolla este estudio, lo que permite una comprensión más profunda de las dinámicas particulares que pueden influir en la efectividad de la HCE y, por consiguiente, en la mejora de la calidad de los servicios de salud. En el caso de EsSalud, un sistema de salud con características únicas y desafíos específicos, la investigación se centra en cómo estos factores contextuales pueden afectar la implementación y el uso de la HCE. La contextualización del estudio permite generar recomendaciones específicas y aplicables que pueden ser utilizadas para mejorar la implementación de la HCE en otros entornos sanitarios con características similares.

En este sentido, el estudio se propone no solo ofrecer un análisis descriptivo de las ventajas y desafíos de la HCE, sino también proporcionar un marco interpretativo que permita entender mejor las relaciones causales y los efectos a largo plazo de su adopción en distintos entornos sanitarios. Esto último se logra mediante una metodología rigurosa que incluye el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, procurando así abordar la complejidad del tema de manera integral y ofrecer conclusiones y recomendaciones pertinentes para futuras implementaciones y estudios en el área. La combinación de estos enfoques metodológicos asegura que los hallazgos del estudio sean robustos y puedan proporcionar una base sólida para la toma de decisiones en políticas de salud y en la práctica clínica.

2.1.1. Antecedentes nacionales

Berastain et al. (2022) realizaron un exhaustivo estudio sobre la implementación de la Historia Clínica Digital Única Universal (HCDUU) en el contexto de la salud digital en Perú. A través de una revisión de la literatura, analizaron las ventajas de las historias clínicas electrónicas, como la rápida accesibilidad y el control de la medicación. Mientras que en Europa se han logrado sistemas interoperables, en América Latina, incluyendo Perú, se han dado avances más lentos en esta área. Se destaca el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas en Perú como un paso inicial, subrayando la necesidad de una estrategia más amplia para la digitalización de las historias clínicas y la mejora de la atención médica en el país.

Maldonado (2023), abordó la auditoría de historias clínicas electrónicas y físicas en el ámbito odontológico. El estudio se llevó a cabo en la Universidad Peruana Cayetano Heredia durante los años 2014 y 2023. El objetivo general consistió en comparar la calidad del registro en ambas formas de historias clínicas. El diseño utilizado fue de tipo transversal

observacional, con un tamaño muestral determinado mediante una fórmula para población finita y muestreo aleatorio estratificado por año. Los resultados resaltaron la importancia de mejorar el registro de historias clínicas para garantizar una atención de calidad a los pacientes en el ámbito odontológico.

En el estudio de Huapaya et al. (2021) se relata el proceso de transición del registro médico tradicional al electrónico en el Complejo Hospitalario San Pablo en Perú. Este estudio descriptivo resalta la implementación de un Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas (SIHCE) en once establecimientos de salud, abarcando varias fases como análisis, diseño, codificación, pruebas, y capacitación. El estudio enfatiza las estrategias adoptadas para la gestión del cambio y las lecciones aprendidas, destacando la importancia del acompañamiento y capacitación del personal, así como la adaptación a las necesidades específicas de cada grupo etario y profesional dentro del hospital.

Tuanama (2019) aborda la adopción de la Historia Clínica Electrónica en establecimientos de salud de primer nivel en Perú, centrándose en la implementación de la plataforma e-Qhali. Mediante un enfoque cualitativo, se analizaron las experiencias de 27 profesionales de la salud a través de entrevistas semiestructuradas, enfocándose en aspectos como la logística, la capacitación y la interacción con los pacientes en relación con e-Qhali. Los hallazgos revelan variaciones en la aceptación y uso de la plataforma, influenciadas significativamente por factores como la infraestructura tecnológica, la formación proporcionada y la integración del sistema en las rutinas clínicas cotidianas.

De manera similar, Condori y Rivera (2021), en su estudio "Evaluación de la Implementación del Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas (SIHCE) e-Qhali en el Centro Materno Infantil El Progreso" se centraron en la evaluación de la implementación de este sistema en un entorno de atención médica. Utilizando un diseño descriptivo transversal, se recopiló información de 50 trabajadores del centro de salud a

través de cuestionarios estructurados y entrevistas semiestructuradas.

Los resultados revelaron que la implementación del SIHCE e-Qhali ha tenido un impacto positivo en la calidad de la atención y la eficiencia en la gestión de la información clínica. Sin embargo, se identificaron desafíos, como la falta de capacitación adecuada y la resistencia al cambio por parte del personal de salud. Como recomendación, se propuso mejorar la capacitación y la comunicación con el personal para asegurar una implementación exitosa en el futuro.

En este contexto, el estudio también destaca la relevancia de los aspectos técnicos y de infraestructura en la implementación exitosa del Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas (SIHCE) e-Qhali. Los autores identifican que, además de la capacitación y la actitud del personal, la eficacia del sistema depende en gran medida de la robustez y fiabilidad de la infraestructura tecnológica subyacente. Esto incluye la necesidad de hardware y software adecuados, conectividad de red confiable y medidas de seguridad de datos eficientes.

Estos elementos técnicos son cruciales para garantizar que el sistema no solo sea accesible y fácil de usar para el personal de salud, sino también que proporcione un entorno seguro y eficiente para el manejo de información sensible del paciente. Por lo tanto, una inversión estratégica en recursos tecnológicos y en su mantenimiento continuo es esencial para complementar la formación del personal y asegurar la plena funcionalidad y eficacia del SIHCE e-Qhali.

El estudio de Gutiérrez (2021) se propuso evaluar la relación entre la implementación de la Historia Clínica Electrónica (HCE) y la mejora en la calidad de atención en el Servicio de Odontología del Hospital Hermilio Valdizán. Se empleó un diseño no experimental y se recopiló información de 14 profesionales de la salud y 70 pacientes mediante cuestionarios y encuestas. Los resultados destacaron que la HCE ha mejorado la calidad de atención y la

eficiencia, pero se han identificado desafíos, como la necesidad de capacitación y la resistencia al cambio. Se encontró una correlación positiva entre la implementación de la HCE y la mejora de la calidad del servicio en el Hospital Hermilio Valdizán, lo que fortalece su imagen institucional y beneficia a los pacientes en consulta externa.

El estudio también destaca la relevancia de los aspectos éticos y legales asociados a la implementación de la Historia Clínica Electrónica (HCE) en el Servicio de Odontología del Hospital Hermilio Valdizán. La investigación resalta cómo la HCE no solo debe cumplir con los estándares técnicos y operativos, sino también alinearse con las normativas de confidencialidad y protección de datos del paciente.

Este aspecto es crucial en el contexto de la atención odontológica, donde se maneja información sensible y detallada de los pacientes. La adecuada gestión de la privacidad y seguridad de los datos en la HCE es fundamental para mantener la confianza de los pacientes y cumplir con las regulaciones legales. Este enfoque integral en la implementación de la HCE no solo mejora la calidad de la atención y la eficiencia operativa, sino que también asegura el respeto y la protección de los derechos de los pacientes en el marco de la práctica odontológica moderna.

Fernández (2022) en su estudio, de diseño exploratorio y aplicado, involucró una muestra de 213 pacientes y utilizó fichas de observación y encuestas para la recolección de datos. Los principales hallazgos mostraron que la implementación del sistema web de historias clínicas electrónicas redujo significativamente los tiempos de espera y mejoró la gestión de citas y atención en consultorios, evidenciando una mejora en los indicadores de gestión médica del hospital Belén de Lambayeque.

2.1.2. Antecedentes internacionales

González (2019) empleó un diseño bibliométrico descriptivo para analizar 518 artículos publicados en revistas científicas indexadas en la base de datos Scopus hasta el año 2016. El objetivo fue describir la evolución de la producción científica latinoamericana en el campo de las historias clínicas digitales.

Los resultados revelaron un incremento exponencial en la producción científica desde el año 2001, con un promedio de 41 artículos anuales, destacando el aumento significativo en 2014. Este crecimiento se asoció con eventos internacionales como el Primer encuentro de la Red para el Desarrollo de la Historia Clínica Electrónica para América Latina y el Caribe. La investigación resalta la alta colaboración internacional, principalmente con países como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, y enfatiza el liderazgo de Brasil en la producción científica en esta área.

Bastias y Ulrich (2019) abordan la adopción de la historia clínica electrónica (HCE) en América Latina y el Caribe. Con un enfoque cualitativo y descriptivo, el estudio reúne datos de un Diálogo Regional de Política en Washington D.C., con 31 participantes de 18 países, centrando su análisis en la gobernanza, interoperabilidad y la integración de inteligencia artificial en los sistemas de salud. Los hallazgos del informe resaltan la importancia de la colaboración estratégica y la adopción de estándares comunes para superar los desafíos técnicos y organizativos en la implementación de HCE, con un énfasis especial en la interoperabilidad y la gestión eficaz de la información de salud.

Torres (2020) presenta un análisis exhaustivo sobre la implementación de la Historia Clínica Electrónica (HCE) en el sistema de salud de Argentina. El estudio aborda el objetivo general de este proceso y examina desafíos, obstáculos y estrategias. Se enfatiza la importancia de mejorar la conectividad en hospitales, capacitar al personal y fomentar la

colaboración público-privada. El autor subraya la necesidad de establecer una agencia nacional para supervisar la HCE y promover la cooperación, con el fin de crear una HCE integral a nivel nacional que integre eficientemente la información clínica de los pacientes.

Fernández et al. (2021) examinan la implementación de una Historia Clínica Electrónica (HCE) en siete centros de salud en Argentina, destacando la efectividad de un enfoque multidisciplinario y estandarizado. El estudio resalta la importancia del compromiso institucional y la adaptación cultural en la superación de retos como la resistencia al cambio y las limitaciones tecnológicas. Con la implementación realizada en menos de un año y beneficiando a más de 2000 usuarios, se demuestra la relevancia de la HCE para mejorar la calidad del servicio de salud y la satisfacción del usuario, proveyendo un modelo replicable para la digitalización en el sector salud.

La historia clínica electrónica (HCE) juega un papel crucial en la informatización de los servicios de salud, mejorando la precisión y eficiencia en la atención médica. Morejón y González (2022) destacan que la HCE asegura la fidelidad, confidencialidad y calidad de la información del paciente. Esta investigación subraya la importancia de integrar tecnologías avanzadas en la práctica médica para mejorar la calidad del cuidado de la salud.

La implementación de Historias Clínicas Electrónicas (HCE) en entornos de atención médica presenta desafíos, incluyendo la resistencia de los médicos. Un estudio cualitativo identificó factores como la interferencia en la relación médico-paciente, la demanda inicial de tiempo y el temor a lo desconocido. Se detectaron distintos tipos de usuarios de tecnología. Abordar las barreras relacionadas con los valores médicos es complejo. Se plantean preguntas para futuras investigaciones (Chá, 2020).

Oviedo et al. (2020) mencionan que en el Perú, el Ministerio de Salud (MINSA) ha establecido diversas normativas para la implementación de historias clínicas electrónicas (HCE) y ha creado el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas (RENHICE) para

integrar en el futuro las HCE de todos los establecimientos de salud. La digitalización de la información del paciente facilita la consulta, actualización y seguridad de los datos, reduciendo tiempo y costos, y evitando la duplicidad de historias clínicas físicas.

Kademane et al. (2023) señalan que los problemas de usabilidad con los registros de salud electrónicos (EHR) son una amenaza creciente para la salud de las enfermeras y los pacientes, aunque pocos estudios han examinado estas correlaciones en profundidad. Su estudio tuvo como objetivo investigar el impacto del uso de EHR en la práctica de enfermería en entornos hospitalarios. La adopción de EHR y su relación con la calidad de la atención han sido poco estudiadas. Se utilizaron datos de la Asociación Americana de Hospitales (AHA), altas de pacientes estatales y encuestas a enfermeras para realizar estudios transversales.

La muestra incluyó 1,281,848 pacientes quirúrgicos, 12,004 enfermeras y 343 hospitales. Se emplearon modelos de regresión logística para examinar la correlación entre la usabilidad de los EHR y los resultados de calidad. Los análisis mostraron que las enfermeras en hospitales con EHR, incluso los más básicos, reportaron menos incidencias que aquellas en hospitales sin EHR, aunque presentaron peores resultados en seguridad del paciente y otras medidas de calidad. La implementación de EHR, incluso a nivel básico, podría mejorar la calidad de la atención de enfermería, facilitar una coordinación más efectiva de la atención y aumentar la seguridad del paciente.

Sin embargo, actualmente existe una notable fragmentación y multiplicidad de formatos y sistemas en los establecimientos de salud, lo que resulta en pérdida de información y duplicidad de esfuerzos. Además, se observan deficiencias en competencias informáticas entre los profesionales de salud, especialmente en mayores de 40 años. La brecha digital y la resistencia al uso de nuevas tecnologías, originadas por desconocimiento y temor, podrían superarse mediante una capacitación amigable y continua, la simplificación de la tecnología y la eliminación de la duplicidad de trabajos.

Las decisiones para adoptar la HCE deben ser integrales y adaptarse a los flujos institucionales, evitando sistemas paralelos que incrementen la carga de trabajo y reforzando la confianza en estas tecnologías para una gestión de calidad de la información.

Oviedo y González (2022) realizaron un estudio observacional y descriptivo en Argentina, enfocado en la resistencia al cambio en enfermería respecto a la historia clínica electrónica (HCE). Con una muestra de 103 participantes y un cuestionario autoadministrado, se destacó la influencia significativa de la resistencia al cambio y la percepción de utilidad en la actitud de los usuarios hacia la HCE. Los resultados contribuyen a comprender el comportamiento de resistencia y desarrollar estrategias para reducirla en el contexto de implementación de la HCE.

En el estudio de Mellizo et al. (2020), se propone un modelo basado en la tecnología Blockchain para gestionar historias clínicas electrónicas familiares, con el objetivo de mejorar la valoración y prevención de enfermedades hereditarias. Se utilizó el framework Hyperledger Fabric y se definió un modelo de datos basado en el estándar FHIR para garantizar la interoperabilidad clínica. El sistema ofrece tres roles: Administrador del sistema, Paciente y Médico, con aplicaciones separadas para cada uno. Los resultados sugieren que esta solución puede mejorar la seguridad y accesibilidad de la información médica, promoviendo un enfoque descentralizado en el sector de la salud.

Otero et al. (2019), en su estudio realizado tuvieron como objetivo principal evaluar la efectividad de diversas intervenciones para mejorar la documentación en los registros de salud electrónicos (EHR) en entornos hospitalarios. Utilizando un diseño de revisión sistemática, se llevaron a cabo búsquedas en diversas bases de datos, además de examinar literatura gris y referencias relevantes. El estudio reconoce las múltiples causas de la baja calidad en la documentación de los EHR y destaca los esfuerzos actuales para abordar y mejorar estos problemas.

Además de los esfuerzos identificados en el estudio, es esencial considerar el papel de la formación continua y el desarrollo profesional en el contexto de la utilización de los registros de salud electrónicos (EHR). La eficacia de las intervenciones para mejorar la documentación en EHR puede verse significativamente potenciada mediante programas de capacitación que no solo se enfoquen en las habilidades técnicas necesarias para utilizar estos sistemas, sino que también aborden aspectos de la ética de la información y la sensibilidad hacia la privacidad y seguridad de los datos del paciente.

Esta dimensión educativa, complementaria a las intervenciones técnicas y organizativas, resulta crucial para garantizar que el personal sanitario esté plenamente equipado para manejar los desafíos inherentes a la documentación electrónica y contribuir así a la mejora global de la calidad de los servicios de salud.

Stanhope et al. (2019) llevaron a cabo un estudio de investigación cualitativa con el objetivo de examinar el impacto del desarrollo de registros de salud electrónicos (EHR) en la implementación de la planificación de atención centrada en la persona en clínicas de salud mental comunitarias. Realizaron investigaciones en cinco clínicas con EHR y capacitación en este enfoque. Utilizaron grupos focales, entrevistas con líderes clínicos y análisis de informes de consultores para recopilar datos. Encontraron un aumento en la adhesión a la planificación de atención centrada en la persona, con variaciones según el estado de desarrollo del EHR. Los EHR influyeron en el proceso y presentaron obstáculos técnicos para personalizar planes de servicio, los cuales se abordaron con adaptaciones y soluciones alternativas.

Este estudio también resalta la importancia de considerar los aspectos organizativos y de formación que acompañan a la implementación de los registros de salud electrónicos (EHR) en la planificación de atención centrada en la persona. Resulta crucial destacar que, más allá de las barreras técnicas inherentes a los EHR, el éxito de su integración en los

procesos de atención depende en gran medida del grado de compromiso institucional y la disposición al cambio por parte del personal.

La investigación pone de manifiesto que el entorno organizativo, incluyendo la cultura de trabajo, el liderazgo clínico, y las políticas internas, juega un papel determinante en cómo se adoptan y se adaptan los EHR en la práctica clínica. Esto sugiere que para una implementación efectiva de los EHR, enfocada en la atención centrada en la persona, se requiere una estrategia integral que no solo aborde los desafíos técnicos, sino que también fomente un cambio positivo en la cultura organizativa y promueva la formación continua del personal en aspectos relevantes a la atención personalizada.

Janssen et al. (2021) realizaron un estudio cualitativo con el propósito de identificar los factores que influyen en la implementación de Registros Electrónicos de Salud (EMRs) en entornos clínicos de alta complejidad. Utilizaron entrevistas con 12 profesionales clínicos y personal administrativo en un centro de cáncer, realizadas un mes antes del lanzamiento del EMR y 12 meses después de su implementación. Los resultados principales del estudio revelaron barreras que incluyen la falta de respaldo técnico post-implementación, la percepción de aumento de la carga laboral por parte de los profesionales de la salud y la necesidad de un período de adaptación para familiarizarse con el EMR.

Además, el estudio subraya la importancia de una gestión del cambio efectiva y estrategias de apoyo continuo en la adopción de Registros Electrónicos de Salud (EMR) en entornos clínicos de alta complejidad. Destaca la necesidad de ir más allá del enfoque técnico y considerar las dimensiones humanas y organizativas del cambio.

Los hallazgos indican que el éxito de la implementación de EMRs no solo depende de la tecnología en sí, sino también de cómo se gestiona el cambio a nivel institucional, incluyendo la comunicación efectiva, la formación específica adaptada a las necesidades del

personal clínico y administrativo, y la creación de un entorno de trabajo que promueva la adaptación flexible a nuevas prácticas.

Este enfoque integral es crucial para minimizar la resistencia al cambio, mejorar la aceptación del sistema por parte de los usuarios y, en última instancia, garantizar que la implementación del EMR contribuya positivamente a la eficiencia y calidad de la atención al paciente en entornos clínicos complejos.

Woldemariam (2023) efectuó una revisión sistemática con el propósito de analizar el estado actual de la adopción de sistemas de Registros Electrónicos de Salud (EHR) en países de bajos ingresos (LICs). La muestra incluyó 12 estudios identificados para la revisión y se aplicaron elementos recomendados para informar revisiones sistemáticas.

Los resultados principales destacaron que la adopción de EHR en LICs está en una fase inicial y de prueba, obstaculizada por factores como infraestructura deficiente, falta de compromiso gerencial, ausencia de estándares, problemas de interoperabilidad, insuficiente apoyo técnico, limitada experiencia y sistemas EHR de baja calidad.

La investigación también pone de relieve la crucial necesidad de abordar las disparidades en el acceso y la calidad de los sistemas de Registros Electrónicos de Salud (EHR) entre países de bajos ingresos (LICs) y aquellos más desarrollados. Esta revisión sistemática evidencia que, mientras los EHR tienen el potencial de revolucionar la gestión de la salud en LICs, su implementación efectiva se ve frenada por barreras estructurales y sistémicas.

El estudio sugiere que para una adopción exitosa de los EHR en estos contextos, es imprescindible el desarrollo de estrategias que aborden específicamente estos retos, como el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, la inversión en capacitación y desarrollo de competencias del personal de salud, y la creación de políticas y estándares que aseguren la interoperabilidad y calidad de los sistemas.

Además, resalta la importancia de una colaboración internacional y el intercambio de conocimientos y recursos entre países, para apoyar a los LICs en superar estas barreras y aprovechar plenamente los beneficios de los EHR para mejorar la calidad y eficiencia de sus sistemas de salud.

2.2. Bases teóricas

2.2.1. Conceptualización de la variable "Historia Clínica Electrónica Única" y su medición

La Historia Clínica Electrónica Única (HCEU) es un elemento clave en la transformación digital de los sistemas de salud, y su implementación responde a la necesidad de centralizar la información clínica del paciente, mejorando la accesibilidad, seguridad y eficiencia en la gestión de los datos de salud.

Según Morales y Meneses (2023), la HCEU no solo facilita el acceso a la información médica de manera inmediata y en tiempo real, sino que también permite una mejor coordinación entre las instituciones de salud, lo que optimiza el uso de los recursos y mejora la atención clínica al reducir los errores en la gestión de información. Este proceso de digitalización e interoperabilidad entre sistemas sanitarios fomenta una mayor equidad en el acceso a los servicios médicos y promueve la toma de decisiones clínicas más informadas.

En esa línea, Pérez et al. (2022) subrayan que la implementación de la HCEU permite un acceso seguro y eficiente a los registros médicos, lo que facilita una atención médica integral y de mayor calidad. La capacidad de compartir información de manera rápida y precisa entre las distintas instituciones garantiza la continuidad del cuidado del paciente, minimizando errores relacionados con la duplicación de pruebas o procedimientos, y

fortaleciendo la coherencia en los tratamientos. Además, la interoperabilidad que proporciona la HCEU es crucial para asegurar una atención médica oportuna y eficiente, integrando las plataformas de datos y promoviendo la colaboración interinstitucional.

Desde una perspectiva más amplia, Sánchez et al. (2022) señalan que la interoperabilidad de los sistemas de información en salud es fundamental para el éxito de la HCEU. La capacidad de integrar y compartir datos entre diferentes plataformas permite una gestión más fluida y segura de la información médica, lo que impacta positivamente en la calidad de la atención que reciben los pacientes.

Macedo et al. (2021) refuerzan este punto al destacar que la implementación de la HCEU no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también fortalece la coordinación entre los distintos niveles asistenciales, facilitando una toma de decisiones basada en datos precisos y actualizados.

A nivel regional, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2019) ha señalado la importancia de la transformación digital en el sector salud de América Latina, destacando la HCEU como una de las principales herramientas para mejorar la eficiencia y equidad en los sistemas de salud de la región. La implementación de la HCEU responde a la necesidad de reducir las barreras de acceso y mejorar la calidad de los servicios de salud, permitiendo que los pacientes reciban atención basada en datos integrados y actualizados en tiempo real. La adopción de soluciones tecnológicas como la HCEU se convierte en un motor clave para modernizar los sistemas de salud y garantizar un acceso más equitativo y eficiente a los servicios médicos.

Finalmente, la Norma ISO 9001:2015 proporciona un marco sistemático y planificado para la implementación de la HCEU, asegurando que los procesos clínicos y administrativos estén alineados con los principios de mejora continua, calidad, seguridad y eficiencia. Esta norma establece que la gestión de la información médica debe centrarse en las necesidades

del paciente, garantizando que la digitalización de los registros no solo cumpla con los estándares de seguridad y privacidad, sino que también promueva una mayor calidad en la atención al paciente.

En este contexto, la ISO 9001:2015 se convierte en el modelo adecuado para guiar la implementación de la HCEU, al proporcionar un enfoque integral que garantiza una gestión eficiente, segura y alineada con las mejores prácticas internacionales.

Para la presente investigación, se definió las siguientes dimensiones para la variable "Implementación de la Historia Clínica Electrónica Única", según la norma ISO 9001:2015:

- **Planificación y Desarrollo**

La planificación y desarrollo en la implementación de la Historia Clínica Electrónica Única (HCEU) es un componente crítico que establece los cimientos sobre los cuales se construye todo el proceso de transformación digital en el sector salud.

De acuerdo con Pérez et al. (2022), este proceso implica no solo la asignación eficiente de recursos financieros, tecnológicos y humanos, sino también el diseño de un plan estratégico claro que incluya fases específicas de implementación, con metas y responsables bien definidos. Este enfoque garantiza que el sistema sea adaptable y pueda integrarse en las diversas instituciones de salud, cumpliendo con los estándares nacionales e internacionales en cuanto a seguridad y confidencialidad de los datos.

Morales y Meneses (2023) destacan que una adecuada planificación asegura la viabilidad a largo plazo del sistema, al prever los recursos necesarios y la capacitación del personal involucrado. El éxito de la HCEU depende en gran medida de una planificación que aborde de manera anticipada los desafíos técnicos y operativos que podrían surgir. Este proceso implica la identificación de necesidades, la estructuración de fases y la coordinación

efectiva entre los actores involucrados, tanto del sector público como privado, para garantizar la interoperabilidad entre instituciones y mejorar la calidad de la atención médica.

Sánchez et al. (2022) enfatizan la importancia de una planificación que incluya la capacitación del personal médico, la adaptación de infraestructuras tecnológicas y la integración de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial. Esto no solo facilita la operación diaria del sistema, sino que también permite que la HCEU evolucione de manera continua, incorporando avances tecnológicos que optimicen la gestión de la información y reduzcan errores médicos. Asimismo, una planificación bien estructurada permite la adaptación progresiva del sistema a diferentes contextos institucionales, asegurando que todos los profesionales de salud involucrados puedan acceder a la información necesaria en tiempo real.

Desde una perspectiva más amplia, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2019) resalta que la implementación de la HCEU no debe limitarse a aspectos tecnológicos, sino que debe considerar una gobernanza efectiva y un marco de estandarización de datos que permita la interoperabilidad entre diferentes instituciones de salud. La planificación debe incluir mecanismos de evaluación y mejora continua, adaptándose a los cambios en las necesidades del sistema de salud y garantizando que se cumplan los objetivos de accesibilidad y eficiencia. Este enfoque estratégico asegura que la HCEU no solo mejore la gestión de la información médica, sino que también promueva una atención médica más equitativa y de mayor calidad.

Macedo et al. (2021) agregan que la planificación es esencial para la colaboración interinstitucional, un aspecto clave para garantizar que la HCEU funcione de manera integrada en todo el sistema de salud. La planificación debe prever la infraestructura tecnológica necesaria, así como la gobernanza y las políticas que garanticen la protección de datos y el cumplimiento de las normativas vigentes. Este proceso incluye la digitalización

progresiva de los registros médicos, así como la estandarización de los protocolos de ingreso y manejo de la información.

Finalmente, al alinearse con los principios de la Norma ISO 9001:2015, la planificación de la HCEU asegura un enfoque sistemático en la mejora continua, enfocándose en la satisfacción del cliente (en este caso, los pacientes y profesionales de salud). Esto implica una evaluación constante de los procesos, asegurando que se tomen decisiones basadas en evidencia para optimizar la gestión de la información y garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos de los pacientes. La norma proporciona un marco estructurado para la gestión de calidad, que es fundamental para el éxito a largo plazo de la HCEU, asegurando que se mantenga un enfoque en la mejora de los procesos clínicos y administrativos a través de un sistema de gestión de la calidad sólido y efectivo.

Para esta investigación, según la Norma ISO 9001:2015, se definió la dimensión Planificación y Desarrollo, de la variable Independiente "Implementación de la HCEU", como el conjunto de actividades orientadas a establecer objetivos claros, asignar los recursos necesarios y definir las etapas para la implementación efectiva de un sistema electrónico unificado de historias clínicas.

Indicadores: existencia de un plan de proyecto detallado para la implementación de la HCEU, recursos asignados (humanos, técnicos, financieros) para la implementación de la HCEU.

- **Capacitación y Soporte**:

La capacitación y el soporte técnico son componentes esenciales para la implementación exitosa de la Historia Clínica Electrónica Única (HCEU).

Según Pérez et al. (2022), el éxito del sistema depende de la formación adecuada de todo el personal involucrado, desde los profesionales de salud hasta el personal administrativo, para que comprendan el funcionamiento del sistema, cómo manejar la información de manera segura, y cómo aprovechar al máximo sus funcionalidades. Un sistema de formación continua debe acompañar el proceso de implementación, asegurando que se cubran las diferentes fases de aprendizaje y que los usuarios puedan enfrentar de manera efectiva los desafíos que plantea el uso de la HCEU en la práctica clínica. Este proceso incluye no solo la comprensión técnica del sistema, sino también cómo aplicar estos conocimientos en la mejora de la calidad de la atención y la eficiencia de los procesos médicos.

Morales y Meneses (2023) subrayan la importancia de establecer un sistema de soporte técnico que brinde asistencia en tiempo real, para asegurar que cualquier problema que surja durante el uso de la HCEU sea solucionado rápidamente. La falta de soporte técnico adecuado puede generar una resistencia al cambio entre los profesionales de salud, afectando la adopción del sistema. Además, el acompañamiento técnico es vital para asegurar que las actualizaciones del sistema se implementen correctamente y que las nuevas funcionalidades sean aprovechadas por los usuarios. La capacitación también debe incluir el manejo de estas actualizaciones para garantizar que los usuarios estén familiarizados con las nuevas herramientas y funcionalidades del sistema.

Desde una perspectiva más amplia, Sánchez et al. (2022) enfatizan que la capacitación no debe limitarse a la formación inicial, sino que debe contemplar una actualización constante para adaptarse a los avances tecnológicos y a los cambios en las normativas de salud. La interoperabilidad entre diferentes instituciones y sistemas es un reto importante que debe ser abordado a través de la capacitación adecuada. Esto implica que los profesionales de salud no solo aprendan a usar el sistema de manera efectiva, sino que también comprendan

cómo compartir datos de forma segura entre diferentes entidades, lo que es clave para la continuidad de la atención médica.

Macedo et al. (2021) destacan que tanto la capacitación como el soporte técnico son esenciales para garantizar que el sistema se utilice de manera eficiente. La falta de formación puede generar errores en la inserción de datos o el uso inadecuado del sistema, lo que afecta directamente la calidad del servicio y la seguridad del paciente. El soporte técnico continuo, por su parte, permite resolver estos problemas rápidamente, asegurando que el personal médico pueda continuar utilizando la HCEU sin interrupciones. La inversión en capacitación y soporte no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también promueve una mayor confianza en el sistema por parte de los profesionales de salud.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2019) también refuerza la idea de que la capacitación es clave para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de la HCEU. Además, destaca la importancia de que la capacitación esté alineada con los estándares internacionales y nacionales de salud, como es el caso de la Norma ISO 9001:2015, que establece directrices claras para la gestión de calidad. Al seguir los principios de la ISO 9001:2015, la capacitación no solo se centra en el uso eficiente de la tecnología, sino también en la mejora continua de los procesos de atención médica. De este modo, se asegura que el personal esté capacitado para cumplir con los más altos estándares de seguridad y calidad en la gestión de la información médica, lo que refuerza la eficiencia operativa y la satisfacción del paciente.

Para esta investigación, según la Norma ISO 9001:2015, se definió la dimensión Capacitación y Soporte, de la variable Independiente “Implementación de la HCEU”, como el conjunto de estrategias y acciones dedicadas a proporcionar al personal los conocimientos y habilidades necesarios para el uso eficaz del sistema de historia clínica electrónica.

Indicadores: programas de capacitación para el personal sobre el uso de la HCEU, disponibilidad de soporte técnico para resolver dudas y problemas.

- **Funcionalidad y Usabilidad**:

La funcionalidad y usabilidad son aspectos fundamentales en la implementación de la Historia Clínica Electrónica Única (HCEU), ya que determinan la capacidad del sistema para ser utilizado de manera eficiente y accesible por todos los profesionales involucrados en la atención sanitaria. Según Pérez et al. (2022), un sistema eficaz de HCEU debe integrarse sin problemas con otras plataformas tecnológicas del sector salud, permitiendo la interoperabilidad y el acceso en tiempo real a la información. La usabilidad se refiere a que el sistema debe ser intuitivo, facilitando la navegación y reduciendo el tiempo requerido para registrar y consultar los datos, lo que incrementa la eficiencia operativa y mejora la experiencia del usuario.

La integración de la HCEU con otras plataformas tecnológicas es clave para evitar la duplicación de procedimientos y garantizar la continuidad de la atención. Morales y Meneses (2023) subrayan la importancia de que la interfaz del sistema sea intuitiva y fácil de usar, ya que esto no solo facilita la labor de los profesionales de salud, sino que también asegura que los datos del paciente puedan ser gestionados de manera eficiente. La interoperabilidad permite que los datos clínicos sean accesibles en cualquier punto del sistema de salud, lo que reduce el riesgo de errores y promueve una atención coordinada y más segura para los pacientes.

La usabilidad es esencial para que el sistema sea adoptado con éxito por los profesionales de la salud. Un diseño intuitivo y amigable asegura que los usuarios puedan aprender a utilizar el sistema rápidamente y sin complicaciones, lo que disminuye las barreras de adopción. Sánchez et al. (2022) enfatizan que un sistema de HCEU funcional no solo debe cumplir con los requisitos técnicos, sino que debe ser adaptable a las necesidades de los

usuarios, proporcionando una experiencia de uso fluida que contribuya a mejorar la calidad del servicio sanitario.

Además, Macedo et al. (2021) destacan que la funcionalidad del sistema debe contemplar la interoperabilidad con otros sistemas médicos, permitiendo una integración eficiente que facilite el acceso a los datos de los pacientes en tiempo real. Esto no solo asegura la continuidad en la atención médica, sino que también optimiza la toma de decisiones clínicas al disponer de información actualizada y precisa. La capacidad del sistema para responder a las necesidades de los usuarios y su facilidad de uso son elementos clave para garantizar su éxito y su aceptación en el entorno sanitario.

Desde una perspectiva más amplia, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2019) resalta que la funcionalidad de la HCEU debe estar alineada con los estándares internacionales de calidad, como la Norma ISO 9001:2015, que establece directrices para la mejora continua en la gestión de procesos. Esta norma subraya la importancia de que los sistemas tecnológicos, como la HCEU, no solo sean eficientes desde un punto de vista técnico, sino que también ofrezcan una experiencia de usuario de alta calidad, contribuyendo así a una atención más segura y eficaz.

Para esta investigación, según la Norma ISO 9001:2015, se definió la dimensión Funcionalidad y Usabilidad, de la variable Independiente “Historia Clínica Electrónica Única”, como la capacidad del sistema electrónico de historias clínicas para satisfacer las necesidades específicas de gestión de información de salud, tanto en términos de cobertura de las funciones requeridas como de facilidad de uso para todos los usuarios.

Indicadores: integración de la HCEU con otros sistemas existentes, facilidad de uso y navegación dentro de la HCEU.

- **Impacto y Efectividad**:

La dimensión Impacto y Efectividad de la Historia Clínica Electrónica Única (HCEU) se enfoca en evaluar cómo este sistema digital contribuye a la mejora de la atención médica y los servicios de salud en general. Según Pérez et al. (2022), el impacto de la HCEU se refleja en la capacidad de reducir errores médicos, aumentar la satisfacción de los pacientes, y optimizar el uso de los recursos. La reducción de los tiempos de espera y la mejora en la precisión diagnóstica son indicadores clave de la efectividad de la HCEU. Estos factores no solo benefician a los pacientes al recibir un tratamiento más oportuno y preciso, sino que también mejoran la eficiencia operativa de las instituciones de salud.

Morales y Meneses (2023) subrayan que la efectividad de la HCEU está en su capacidad de facilitar una toma de decisiones clínicas más informada y precisa. La disponibilidad de información médica completa y en tiempo real permite a los profesionales de la salud coordinar mejor los cuidados, lo que a su vez disminuye la duplicación de pruebas y procedimientos, incrementando la calidad general del servicio. Además, el sistema permite identificar rápidamente áreas de mejora, lo que contribuye a la optimización constante de los procesos hospitalarios.

De acuerdo con Macedo et al. (2021), la HCEU ha demostrado ser efectiva no solo en la mejora de la atención médica, sino también en la reducción de errores médicos, gracias a la centralización y unificación de los registros clínicos. La interoperabilidad del sistema facilita la integración de datos entre diferentes instituciones de salud, lo que favorece una atención más coordinada y centrada en el paciente. Este enfoque permite que la información clínica esté disponible de manera inmediata y accesible para todos los profesionales de salud, mejorando significativamente la calidad del servicio.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2019) destaca que la implementación de la HCEU en América Latina y el Caribe ha permitido mejorar la eficiencia en los procesos clínicos, gracias a la optimización de la interoperabilidad entre los sistemas de salud. Además, el BID resalta que una HCEU efectiva no solo centraliza la información médica, sino que también contribuye a la sostenibilidad del sistema de salud, al reducir costos operativos y permitir una gestión más eficiente de los recursos. Según el BID, el impacto positivo de la HCEU está vinculado a su capacidad para adaptarse a los cambios tecnológicos y a las necesidades de los sistemas de salud.

Alineada con los principios de la Norma ISO 9001:2015, la HCEU promueve un enfoque sistemático y planificado que busca la mejora continua de la calidad de los servicios de salud. La ISO 9001:2015 refuerza la necesidad de evaluar y gestionar los riesgos y oportunidades, asegurando que los pacientes y las partes interesadas reciban servicios de salud de alta calidad y con los más altos estándares de seguridad. La implementación de la HCEU, dentro del marco de esta norma, asegura que los procesos clínicos sean eficientes, efectivos y estén orientados a la satisfacción del usuario, lo que maximiza su impacto positivo en el sistema de salud a largo plazo.

Para esta investigación, según la Norma ISO 9001:2015, se definió la dimensión Impacto y Efectividad, de la variable Independiente “Historia Clínica Electrónica Única”, como la evaluación del éxito del sistema en alcanzar los objetivos previstos, mejorando la calidad y eficiencia de los servicios de salud.

Indicadores: mejoras observadas en la eficiencia de los procesos clínicos y administrativos, satisfacción de los usuarios con la HCEU.

2.2.2. Conceptualización de la variable "Gestión de la Calidad" y su medición

La norma ISO 9001:20015, define la gestión de la calidad como el enfoque sistemático para dirigir y controlar una organización con el objetivo de mejorar continuamente su eficacia y eficiencia en la entrega de productos y servicios. Se basa en principios clave como el enfoque al cliente, el liderazgo, la participación del personal, el enfoque a procesos, la mejora continua, la toma de decisiones basada en evidencia y la gestión de relaciones, todo ello con el fin de satisfacer los requisitos del cliente y aumentar su satisfacción.

Para la presente investigación, se definió las siguientes dimensiones para la variable "Gestión de la Calidad", según la norma ISO 9001:2015:

- **Planificación**: proceso de establecer objetivos de calidad y determinar los medios necesarios para alcanzarlos, enfatizando en la mejora continua y en la gestión de riesgos y oportunidades.

Indicadores: existencia de un plan estratégico de recursos y servicios de atención médica, frecuencia de actualización del plan estratégico de recursos y servicios de atención médica.

- **Organización**: entidad o estructura que define y gestiona sistemas y procesos para cumplir objetivos de calidad, satisfaciendo así las necesidades y expectativas de sus clientes y otras partes interesadas.

Indicadores: jerarquía en la estructura organizativa, efectividad de la comunicación interna.

- **Garantía y mejoramiento de los servicios**: se conceptualizan conjuntamente como el compromiso y las acciones continuas de una organización para asegurar que se

cumplen los requisitos de calidad y para optimizar sistemáticamente los procesos, elevando así la eficacia y satisfacción del cliente.

Indicadores: nivel de satisfacción con la atención médica, nivel de cumplimiento de los estándares de calidad.

- **Idoneidad de la información**: datos y conocimientos pertinentes que una organización utiliza y gestiona para apoyar sus procesos y mejorar continuamente la calidad de sus productos o servicios.

Indicadores: nivel de recopilación de datos clínicos, nivel de seguridad de los registros médicos.

El sustento teórico adicional, desarrollado ampliamente por autores reconocidos, se menciona a continuación:

- **Planificación de Recursos y Servicios de Atención Médica**

A lo largo de la historia de la administración y la gestión, un conjunto de renombrados expertos ha desempeñado un papel esencial en la evolución de los conceptos de planificación y estrategia. Estos eruditos han aportado de manera significativa con perspectivas fundamentales que han enriquecido nuestra comprensión de estos elementos vitales en la gestión empresarial. Sus contribuciones han sentado una sólida base para la toma de decisiones y el logro del éxito organizacional. Cada uno de estos distinguidos pensadores ha presentado enfoques valiosos que han desempeñado un papel fundamental en la formación de la gestión empresarial moderna.

En esta línea, es importante destacar que la evolución de las teorías y prácticas en el campo de la administración y la gestión empresarial no ha sido lineal ni homogénea, sino que ha estado caracterizada por una diversidad de enfoques y paradigmas. Los expertos en este campo han abordado desde teorías clásicas, centradas en la estructura organizacional y la eficiencia operativa, hasta enfoques contemporáneos que enfatizan la flexibilidad, la innovación y la responsabilidad social empresarial.

Este rico tapiz de teorías y modelos ha proporcionado a los líderes y gerentes una variedad de herramientas y marcos conceptuales para navegar en un entorno empresarial cada vez más complejo y dinámico. Además, la intersección de la administración con otras disciplinas, como la psicología organizacional, la economía y la tecnología de la información, ha enriquecido aún más el campo, permitiendo abordajes más integrados y holísticos en la gestión empresarial.

Fayol (1916) fue uno de los pioneros en destacar la importancia de la planificación como una función administrativa. Para él, la planificación implicaba la capacidad de prever el futuro, establecer objetivos y determinar los recursos necesarios. Sus ideas sentaron las bases para la consideración de la planificación como un proceso sistemático y esencial en la administración.

A principios del siglo XX, la planificación emergió como una función administrativa clave, caracterizada por su enfoque en la previsión del futuro, la definición de objetivos y la identificación de los recursos necesarios para alcanzarlos.

Esta aproximación representó un cambio paradigmático en la gestión empresarial, donde la planificación comenzó a ser vista no solo como una tarea de asignación y organización de recursos, sino también como un proceso estratégico de anticipación y preparación para desafíos futuros. Este enfoque sistemático de la planificación contribuyó significativamente a sentar las bases para su consideración como un elemento esencial en la

administración eficaz, influenciando la forma en que las organizaciones abordan la gestión estratégica y la toma de decisiones en el complejo entorno empresarial contemporáneo.

Posteriormente, Drucker (1954) introdujo el concepto de planificación estratégica como un proceso continuo de toma de decisiones empresariales. Él enfatizó la necesidad de contar con una visión clara, una misión definida, objetivos concretos y políticas bien establecidas como elementos clave para guiar la acción organizacional. Drucker abrió la puerta a una planificación más estratégica y a largo plazo.

En la década de 1950, la planificación estratégica se consolidó como un enfoque clave en la gestión empresarial, enfatizando un proceso continuo de toma de decisiones. Este enfoque destacó la relevancia de establecer una visión organizacional clara, complementada por una misión definida, objetivos específicos y políticas coherentes.

Estos elementos se consideraron esenciales para guiar eficazmente la acción organizacional hacia el logro de metas a largo plazo. Este paradigma introdujo una dimensión más estratégica y a largo plazo en la planificación, alejándose de enfoques más inmediatos y operativos, y permitiendo a las organizaciones alinear sus operaciones diarias con una estrategia global y objetivos de mayor alcance.

Así también, Ander (1970) resaltó la importancia de introducir organización y racionalidad en la acción a través de la planificación. Para él, la planificación no solo implicaba definir metas, sino también coordinar actividades y evaluar resultados. Su enfoque contribuyó a la percepción de la planificación como una herramienta integral para la gestión.

En la década de 1970, se enfatizó la importancia de inyectar organización y racionalidad en la gestión a través de la planificación. Este enfoque abarcó no solo la definición de metas, sino también la coordinación efectiva de actividades y la evaluación sistemática de resultados.

Esta perspectiva enriqueció la visión de la planificación, transformándola en una herramienta integral y multifacética para la gestión. Se reconoció que una planificación efectiva debía incorporar no solo la establecimiento de objetivos, sino también la implementación y el seguimiento continuo para asegurar el alineamiento con las metas establecidas y la capacidad de adaptarse a los cambios y desafíos emergentes. Este enfoque integral subrayó la planificación como un proceso dinámico y continuo, crucial para la gestión eficiente y el logro de los objetivos organizacionales.

De manera similar, Koontz y O'Donnell (1978) abordaron la planificación como una función administrativa que involucra la selección de objetivos, políticas y procedimientos. Destacaron la perspectiva a largo plazo y la necesidad de adaptarse al cambio. Su enfoque puso énfasis en la planificación como un proceso que debe considerar la dinámica y evolución del entorno empresarial.

Unos años después, Morrisey (1986) definió la estrategia como la dirección necesaria para cumplir con la misión de una empresa. Destacó que la planificación a largo plazo y la planificación táctica son los medios esenciales para lograr esa dirección. Su enfoque resaltó la importancia de la dirección estratégica en la toma de decisiones empresariales.

Luego, Chiavenato (1995) enfocó la atención en la planificación estratégica como un proceso global y a largo plazo. Su enfoque incluyó la evaluación exhaustiva del entorno externo e interno de la organización. Chiavenato promovió la idea de que la planificación estratégica es esencial para la adaptación y supervivencia en un entorno empresarial complejo.

Chandler (2003) se centró en la estrategia como la determinación de metas a largo plazo, acciones y asignación de recursos necesarios para alcanzar esas metas. Su contribución subrayó la importancia de la ventaja competitiva y la coherencia entre las actividades de la organización como elementos esenciales de la estrategia.

De otro lado, la evaluación de recursos es esencial en la planificación estratégica, permitiendo a las organizaciones tomar decisiones informadas sobre la asignación y el aprovechamiento efectivo de recursos. Esto abarca desde el capital humano hasta las capacidades distintivas. La evaluación rigurosa facilita la identificación de oportunidades y la construcción de ventajas competitivas duraderas. Expertos en gestión y estrategia destacan la importancia de esta evaluación en un planeamiento estratégico efectivo orientado hacia objetivos a largo plazo.

Drucker (1974), aborda la gestión y la planificación estratégica. Destaca la importancia de evaluar recursos organizacionales, desde el capital humano hasta los activos tangibles, como parte esencial del proceso de toma de decisiones estratégicas. Drucker argumenta que una gestión eficaz implica la asignación adecuada de recursos y la comprensión de cómo estos recursos pueden contribuir a los objetivos estratégicos de la organización.

Así mismo, Porter (1985), explora la evaluación de recursos como un componente fundamental de la obtención de ventajas competitivas sostenibles. Su enfoque se centra en identificar y utilizar eficazmente los recursos y capacidades internos de una organización para lograr un rendimiento superior en un mercado competitivo.

Hamel y Prahalad (1990) introducen el concepto de "capacidades centrales" y enfatizan la evaluación de las capacidades internas como parte esencial de la estrategia empresarial. Argumentan que las organizaciones deben identificar y aprovechar sus capacidades centrales para competir de manera efectiva en el mercado.

Más recientemente, David (2019), se centra en la gestión estratégica con un enfoque particular en la evaluación de recursos y su contribución a la formulación de estrategias competitivas en un entorno global. Explora cómo las organizaciones pueden analizar y utilizar sus recursos internos de manera efectiva para obtener ventajas competitivas

sostenibles en un mercado cada vez más globalizado. Presenta una variedad de conceptos y casos prácticos que demuestran la importancia de la evaluación de recursos en la toma de decisiones estratégicas.

- **Organización Interna**

La estructura organizativa es esencial en la organización interna de una empresa, definiendo roles y responsabilidades, facilitando la comunicación y la coordinación. Además, influye en la toma de decisiones y la adaptabilidad al entorno. Una estructura bien diseñada mejora la productividad y eficiencia, lo que es clave para alcanzar objetivos estratégicos. Por lo tanto, el diseño adecuado de la estructura es esencial para la competitividad y éxito empresarial.

Además, es importante reconocer que la elección de una estructura organizativa adecuada no solo se limita a establecer una jerarquía y asignar tareas, sino que también implica considerar cómo esta estructura se alinea con la cultura organizacional, los valores de la empresa y su estrategia a largo plazo.

En el ámbito de la gestión moderna, se ha enfatizado la necesidad de estructuras flexibles y dinámicas que puedan responder rápidamente a los cambios en el mercado y a las innovaciones tecnológicas. Esto incluye la adopción de modelos organizativos más planos, que promueven una mayor autonomía y fomentan la innovación y creatividad entre los empleados.

Asimismo, la integración efectiva de tecnologías de la información en la estructura organizativa puede potenciar la colaboración y el flujo de información, elementos cruciales en un entorno empresarial cada vez más interconectado y dependiente de datos precisos y actualizados.

Perrow (2014), ofrece un análisis crítico sobre cómo la estructura organizativa influye en organizaciones complejas y altamente interdependientes. Examina cómo las estructuras pueden afectar la capacidad de las organizaciones para gestionar situaciones de alta complejidad y riesgo. También explora cómo las estructuras burocráticas y descentralizadas pueden impactar en la capacidad de una organización para enfrentar desafíos y tomar decisiones efectivas.

Así también, Daft (2017), presenta una visión contemporánea de cómo la estructura organizativa afecta a las organizaciones. Analiza cómo las estructuras organizativas pueden influir en la eficacia, la innovación y la adaptabilidad de las organizaciones en un entorno empresarial en constante cambio. Aborda temas como la configuración de estructuras, el diseño de puestos y la importancia de la alineación entre la estrategia y la estructura. Daft también explora en detalle cómo las organizaciones pueden adaptar sus estructuras para lograr sus objetivos y enfrentar los retos actuales.

De manera similar, Jones (2018), ofrece una perspectiva contemporánea sobre la importancia de la estructura organizativa en el contexto de la teoría organizacional. Explora cómo diferentes enfoques y teorías del diseño organizativo, como la estructura funcional, divisional y matricial, pueden influir en la eficiencia y efectividad de las organizaciones. Además, aborda la importancia de adaptar la estructura a las necesidades cambiantes del entorno empresarial y cómo una estructura adecuada puede mejorar la agilidad y la toma de decisiones dentro de una organización.

De otro lado, la comunicación interna es esencial en la organización interna de una empresa al facilitar la transmisión de información y objetivos entre diferentes niveles jerárquicos. Promueve la colaboración y alineación de los empleados con la misión de la empresa, fomenta un ambiente laboral saludable y mejora la satisfacción y productividad.

Una comunicación interna eficaz fortalece la cohesión organizativa y contribuye al logro de objetivos estratégicos.

Smidts (2001), presenta una investigación en profundidad sobre cómo la comunicación interna influye en la identificación de los empleados con la organización y cómo su percepción de prestigio externo puede ser un factor clave.

Argenti (2004), resalta cómo la comunicación interna se ha vuelto aún más crucial en la era digital, ya que la rápida transmisión de información y la gestión de datos pueden afectar la cohesión organizativa y la colaboración.

Welch (2007), analiza detalladamente el enfoque de partes interesadas internas en la comunicación interna y su relevancia para la gestión de la reputación organizacional.

Kliem (2016), explora en detalle cómo la comunicación interna fomenta la creatividad y la innovación en equipos y organizaciones, brindando ejemplos de estrategias efectivas.

Deetz (2017), ofrece un análisis exhaustivo de la influencia de la comunicación interna en la cultura organizacional, y cómo esta dinámica afecta la experiencia laboral de los empleados.

- **Calidad de los Servicios de Atención Médica**

La satisfacción del cliente es un aspecto crítico en la calidad de los servicios de atención médica, ya que refleja la percepción positiva de los pacientes sobre su experiencia de atención. Más allá de la excelencia clínica, abarca la calidad de la interacción humana, la empatía y la capacidad de los servicios de salud para atender las necesidades y expectativas de los pacientes. Un paciente satisfecho tiende a ser más adherente al tratamiento y contribuye a una mejor imagen institucional, promoviendo la lealtad hacia el proveedor de

servicios médicos. En este sentido, la satisfacción del cliente es un objetivo primordial para mejorar la calidad de los servicios de atención médica y garantizar el bienestar del paciente.

En el contexto de esta premisa, es esencial considerar que la satisfacción del cliente en el sector de la atención médica no se limita únicamente a la respuesta inmediata del paciente a un servicio o tratamiento específico. Incluye una evaluación más amplia y profunda que abarca el espectro completo de la experiencia del paciente, desde el primer contacto con el sistema de salud hasta el seguimiento post-tratamiento.

Esto implica que las instituciones de salud deben implementar sistemas de retroalimentación y evaluación continua que les permitan capturar y analizar las opiniones y experiencias de los pacientes de manera sistemática.

Además, la satisfacción del cliente en la atención médica está intrínsecamente ligada a la calidad y eficacia de la comunicación entre el paciente y los proveedores de servicios de salud. La habilidad de los profesionales para comunicarse de manera efectiva y compasiva, personalizando la atención y demostrando comprensión hacia las preocupaciones y circunstancias individuales de cada paciente, juega un papel crucial en la percepción general de la calidad del servicio.

Por tanto, la formación en habilidades de comunicación y enfoques centrados en el paciente debería ser una parte integral de la educación y el desarrollo profesional continuo en el campo de la salud.

Crosby (1979), popularizó la noción de que la calidad no es un gasto adicional, sino una inversión que finalmente conduce a la satisfacción del cliente y a la rentabilidad de la empresa. Su enfoque se centró en prevenir defectos y errores en lugar de corregirlos, promoviendo la cultura de "hacerlo bien la primera vez". También introdujo el concepto de "cero defectos", que enfatiza la importancia de eliminar problemas en lugar de conformarse con estándares mínimos aceptables.

Hacia finales de la década de 1970, se consolidó la perspectiva de que la calidad no debería ser vista como un gasto adicional, sino más bien como una inversión estratégica que conduce a la satisfacción del cliente y a la rentabilidad empresarial. Este enfoque cambió el paradigma de la gestión de calidad, poniendo énfasis en la prevención de defectos y errores, en lugar de centrarse únicamente en su corrección.

Se promovió la cultura de 'hacerlo bien la primera vez', instando a las organizaciones a adoptar prácticas que garanticen la calidad desde el inicio del proceso productivo o de servicio. Adicionalmente, se introdujo el concepto de 'cero defectos', subrayando la importancia de eliminar completamente los problemas en lugar de simplemente cumplir con estándares mínimos aceptables.

Este enfoque innovador en la gestión de calidad propuso un cambio radical, orientando a las empresas hacia la búsqueda de la excelencia y la eficiencia operativa como pilares fundamentales para el éxito y la competitividad en el mercado.

De manera similar, Peters y Waterman (1982), realizaron un estudio en el que identificaron a empresas excelentes y destacaron los principios que las hicieron exitosas. Su investigación demostró que la calidad y la satisfacción del cliente eran elementos fundamentales para alcanzar la excelencia empresarial. Destacaron la importancia de empoderar a los empleados, fomentar la innovación y enfocarse en superar las expectativas del cliente.

Este estudio puso de manifiesto que la atención al detalle en productos y servicios, junto con una alta consideración hacia las necesidades y expectativas de los consumidores, eran aspectos centrales para alcanzar un alto nivel de rendimiento corporativo. Se destacó, además, la relevancia de brindar autonomía a los trabajadores, incentivando su participación activa en los procesos de toma de decisiones.

Este enfoque se complementaba con un fuerte énfasis en la creatividad y el desarrollo de nuevas ideas, subrayando un compromiso constante con la mejora continua y la adaptación a las cambiantes demandas del mercado. Estos elementos se identificaron como factores determinantes en la construcción de una cultura organizacional dinámica y orientada hacia la superación de estándares convencionales de desempeño y servicio al cliente.

También, Juran (1999), se enfocó en la gestión de la calidad y enfatizó la importancia en la satisfacción del cliente. Abogó por la planificación, el control y la mejora de la calidad para garantizar que los productos y servicios cumplan con las expectativas del cliente. Su trabajo ha influyó en la adopción de prácticas de calidad en muchas organizaciones.

De otro lado, el cumplimiento de estándares de calidad es esencial en la atención médica, asegurando que los servicios cumplan con normativas y mejores prácticas. Esto garantiza atención consistente y segura, basada en evidencia, beneficiando tanto a pacientes como a proveedores de atención. Además, la acreditación y certificación de instituciones médicas se apoyan en el cumplimiento de estos estándares, lo que aumenta la confianza del público y mejora la calidad general de los servicios de salud. Por lo tanto, el respeto de los estándares de calidad es fundamental para la gestión de la calidad en la atención médica.

Crosby (1979), enfatiza que el cumplimiento de estándares de calidad es esencial para reducir costos y mejorar la satisfacción del cliente. Crosby sostiene que la calidad es una inversión rentable, ya que el incumplimiento de estándares y la presencia de defectos resultan en gastos adicionales para la organización y pueden conducir a la pérdida de clientes. Promueve la noción de que prevenir problemas de calidad desde el principio es fundamental y puede ahorrar recursos significativos.

Así también, Deming (1986), subraya la importancia de la mejora continua para el cumplimiento de estándares de calidad. Propone un enfoque basado en el ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act) como un método efectivo para lograr una calidad superior y satisfacer las

necesidades del cliente. Argumenta que la gestión de la calidad debe ser un proceso continuo y que el liderazgo es esencial para crear una cultura de mejora constante en una organización.

De manera similar, Juran (1992) hace hincapié en la planificación como un medio para garantizar el cumplimiento de estándares de calidad. Argumenta que la planificación estratégica y la mejora continua son fundamentales para lograr una calidad consistente en productos y servicios. Proporciona un marco para la planificación de calidad que se centra en establecer estándares, medir el rendimiento actual y tomar medidas correctivas para lograr la conformidad con esos estándares.

- **Recopilación, Almacenamiento y Acceso a la Información**

La recopilación de datos es un proceso fundamental que proporciona información precisa y sistemática. Esto es esencial para tomar decisiones objetivas, evaluar el rendimiento, identificar tendencias y medir el impacto de las acciones. Además, la recopilación de datos contribuye a la construcción de bases de conocimiento sólidas, mejorando la eficiencia y efectividad en la gestión de operaciones y servicios, lo que fomenta la búsqueda constante de la mejora organizacional.

En el contexto específico de la implementación de la Historia Clínica Electrónica Única (HCEU), la recopilación de datos adquiere una dimensión aún más crítica. La eficacia de la HCEU depende en gran medida de la calidad y coherencia de los datos recogidos, lo que requiere protocolos rigurosos y estandarizados para la entrada de información.

La precisión en la recopilación de datos en la HCEU no solo mejora la eficiencia en la gestión de operaciones y servicios de salud, sino que también juega un papel vital en la atención al paciente, asegurando que los profesionales de la salud tengan acceso a información completa y actualizada.

Esto facilita un diagnóstico más preciso, una planificación de tratamiento más efectiva y una mejor coordinación entre diferentes proveedores de atención médica. Además, los datos recopilados a través de la HCEU pueden ser utilizados para investigaciones clínicas y estudios epidemiológicos, contribuyendo así a la construcción de un conocimiento médico más profundo y a la mejora continua de la calidad del cuidado de la salud.

Besterfield (2013), enfatiza que la recopilación de datos desempeña un rol fundamental en la gestión de calidad de servicios. Explica que la recopilación de datos proporciona información clave sobre el desempeño de los procesos de servicios, lo que permite la toma de decisiones basadas en datos para la mejora continua. Subraya que la recopilación de datos también es esencial para medir el impacto de las acciones de mejora y garantizar que los servicios cumplan con los estándares de calidad deseados.

Goetsch y Davis (2014), hacen hincapié en que la recopilación de datos es un componente esencial para medir y mejorar la calidad de los servicios. Argumentan que la recopilación de datos permite a las organizaciones evaluar el desempeño actual, identificar áreas de mejora y tomar decisiones basadas en datos para lograr la excelencia en la calidad de los servicios. Además, resaltan que la recopilación de datos precisa y oportuna es clave para la toma de decisiones informadas en la gestión de calidad.

Hoyle (2015), pone de relieve que la recopilación de datos es esencial en la gestión de calidad, particularmente en el contexto de cumplimiento de normativas y estándares como ISO 9000. Argumenta que la recopilación de datos es necesaria para evaluar el cumplimiento de estándares de calidad, identificar áreas de no conformidad y tomar medidas correctivas. Destaca que la recopilación de datos sistemática y precisa es crucial para garantizar que los servicios cumplan con los requisitos de calidad establecidos.

De otro lado, la capacidad de almacenar datos de manera segura y eficiente es fundamental para preservar la información histórica y asegurar su disponibilidad. El

almacenamiento adecuado facilita el acceso a datos pasados, análisis retrospectivos y el seguimiento de tendencias. También garantiza la seguridad de los datos y el cumplimiento de regulaciones de privacidad, lo que es esencial en la protección de la información actual. Así, el almacenamiento de datos es crucial para la gestión de la información, la toma de decisiones y la mejora continua de las operaciones.

Harrington (1991), aborda la importancia de la gestión de la calidad en servicios y cómo el almacenamiento eficiente de datos es esencial para evaluar y mejorar continuamente los procesos de servicio. Destaca que el almacenamiento adecuado permite llevar un registro histórico de datos críticos, lo que es fundamental para la gestión de la calidad.

Wang (1996), se enfoca en la relevancia del almacenamiento adecuado de datos de alta calidad en la gestión de la calidad de servicios. Argumenta que un sistema eficiente de almacenamiento de datos permite un acceso rápido y preciso a la información necesaria para tomar decisiones informadas y mejorar la satisfacción del cliente en una variedad de sectores de servicios.

Juran (1999), enfatiza la relevancia del almacenamiento de datos en el sector de servicios. Sostiene que el almacenamiento eficaz de datos es crucial para analizar y mejorar la calidad y el desempeño del servicio, y que una buena gestión de datos contribuye a la toma de decisiones informadas y a la satisfacción del cliente.

2.2.2.1 Modelos teóricos.

Rosander (1994), se enfoca en la aplicación de los catorce principios propuestos por W. Edwards Deming a las empresas de servicios. Desvela cómo es posible lograr una ventaja competitiva en el sector de servicios mediante el énfasis en la calidad del servicio,

particularmente haciendo hincapié en aspectos como la seguridad y la reducción de errores para mejorar la prestación de servicios.

Se adentra en cada uno de los catorce puntos establecidos por Deming, proporcionando una guía introductoria para la implementación de métodos estadísticos en este contexto específico. Algunos de los temas clave abordados incluyen la importancia de mantener una constante intención de mejorar tanto productos como servicios, el análisis de la demanda de los clientes, la evaluación de la fuerza laboral, la detección y prevención de errores, la reducción de demoras y tiempos muertos, y la garantía de la seguridad en los procesos.

Estos catorce puntos resumidos promueven un enfoque estratégico en la planificación, destacando la colaboración, la mejora continua de procesos y la eliminación de prácticas de inspección masiva. También enfatizan la toma de decisiones basada en costos a largo plazo, el liderazgo efectivo y la eliminación del miedo en el trabajo. Se abogan por la eliminación de barreras entre departamentos, la educación y el auto-mejoramiento, y la participación de toda la organización en la búsqueda de mejora continua de la calidad.

Ofrece una serie de recursos y recomendaciones para la aplicación de los catorce puntos de Deming en el contexto de los servicios de salud. Estos incluyen la clarificación de la misión, visión y valores del servicio, diagnóstico de la calidad, planificación estratégica de calidad, definición de indicadores y estándares, medición de resultados y satisfacción, así como la resolución de problemas utilizando el ciclo PDCA y herramientas estadísticas como el control de procesos, análisis de causas raíz, el diagrama de Pareto y el diagrama de Ishikawa. También se enfatiza la formación de equipos multidisciplinarios, el reconocimiento y la recompensa de buenas prácticas en el ámbito de la atención médica.

Sangüesa et al. (2019) destacan varios conceptos de importancia en el contexto de la gestión de la calidad. En primer lugar, la "gestión de la calidad" se describe como un enfoque

directivo centrado en la mejora continua de productos, servicios y procesos organizacionales con el fin de aumentar la satisfacción de los clientes y lograr objetivos de la entidad. La "definición de calidad" refiere a la capacidad de un objeto de satisfacer necesidades implícitas y explícitas a través del cumplimiento de requisitos, reconociendo su naturaleza subjetiva, influenciada por factores individuales y culturales.

Por otro lado, el "ciclo de vida del producto" se refiere a las distintas fases por las que atraviesa un producto desde su concepción hasta su eventual retirada del mercado. Estas etapas típicamente comprenden el diseño, desarrollo, fabricación, distribución, uso y mantenimiento, así como el reciclaje o eliminación del producto. En lo que respecta a la "gestión de la calidad," se pueden identificar tres niveles fundamentales: el nivel del sistema, el nivel del proceso y el nivel del producto, los cuales desempeñan roles diferenciados en la implementación de prácticas de calidad en una organización.

La implementación de la Historia Clínica Electrónica Única (HCEU) en EsSalud, guiada por los principios y requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2015, representará un paso significativo hacia la mejora de la gestión de calidad en los servicios de salud. Este enfoque permitirá una integración efectiva de los procesos, asegurará la coherencia en la prestación de servicios y mejorará la satisfacción de los pacientes, alineándose con el compromiso de EsSalud de ofrecer atención médica de alta calidad.

Orientación al Cliente: La ISO 9001:2015 pone un fuerte énfasis en la satisfacción del cliente, lo cual se alinea con el objetivo principal de la HCEU de mejorar la experiencia del paciente. Al centralizar y digitalizar los registros médicos, EsSalud puede ofrecer un acceso más rápido y seguro a la información del paciente, lo cual reduce los tiempos de espera y aumenta la eficiencia en la atención al paciente.

Liderazgo: Para la exitosa implementación de la HCEU, es crucial el compromiso y el liderazgo de la alta dirección de EsSalud. Esto incluye proporcionar visión, dirección y

recursos para el proyecto, así como fomentar una cultura organizacional que valore la mejora continua y la innovación en la prestación de servicios de salud.

Enfoque a Procesos: La implementación de la HCEU permite la estandarización de procesos en toda la organización, facilitando la gestión y el acceso uniforme a la información del paciente. Esto mejora la calidad y la coherencia de la atención al paciente, al mismo tiempo que facilita la identificación y la mejora continua de los procesos clínicos y administrativos.

Mejora: La HCEU es una herramienta clave para la mejora continua, permitiendo el análisis de datos en tiempo real para identificar tendencias, problemas y oportunidades de mejora en la atención al paciente. Esto se alinea con el requisito de mejora continua de la ISO 9001:2015, promoviendo la adaptabilidad y la eficacia de los servicios de salud en respuesta a las necesidades cambiantes de los pacientes y del entorno.

Toma de Decisiones Basada en Evidencia: La disponibilidad de datos completos y precisos a través de la HCEU apoya la toma de decisiones basada en evidencia. Esto mejora la calidad de la atención al paciente, al permitir a los profesionales de la salud tomar decisiones informadas sobre el tratamiento, basadas en el historial completo del paciente.

Gestión de Relaciones: La HCEU facilita una mejor comunicación y coordinación entre diferentes profesionales y departamentos de salud dentro de EsSalud, así como con proveedores externos de servicios de salud. Esto mejora la gestión de relaciones, asegurando que todos los involucrados en la atención al paciente trabajen de manera cohesiva y orientada a la calidad.

Así, la implementación de la Historia Clínica Electrónica Única en EsSalud, siguiendo los principios y requisitos de la ISO 9001:2015, ofrecerá una oportunidad única para mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios de salud. Este enfoque no solo beneficiará a los pacientes, mediante la mejora de la accesibilidad y la calidad de la atención,

sino que también optimizará los procesos internos y promoverá una cultura de mejora continua y excelencia en la gestión de la calidad.

De manera similar, el Modelo de Excelencia en la Gestión del Centro de Desarrollo Industrial de la Sociedad Nacional de Industrias indica que la gestión de la calidad puede conceptualizarse como un enfoque sistemático y estructurado que busca la mejora continua de los procesos y servicios, con el fin de satisfacer o superar las expectativas y necesidades de todas las partes interesadas.

En este marco, el Modelo de Excelencia en la Gestión proporciona un esquema integral que permite evaluar el desempeño organizacional a través de criterios específicos y bien definidos, promoviendo prácticas de gestión avanzadas y sostenibles.

Figura 1: *Marco General del Modelo de Excelencia en la Gestión: Una perspectiva de sistema*

Nota. Sociedad Nacional de Industrias - Modelo de Excelencia en la Gestión 2024 (pp. 19)

Aplicado al contexto de EsSalud y enfocado en la implementación de la HCEU, el modelo se convierte en una herramienta clave para mejorar la gestión de la calidad. La HCEU, al ser una plataforma que centraliza y digitaliza los registros médicos de los pacientes, facilita un acceso rápido y seguro a la información de salud, lo que repercute directamente en la calidad del servicio ofrecido.

La implementación de este sistema en EsSalud, guiada por los principios del Modelo de Excelencia en la Gestión, permitiría optimizar los procesos de atención médica, desde el

diagnóstico hasta el tratamiento, asegurando una mayor precisión en las intervenciones médicas y reduciendo los riesgos de errores. Además, contribuiría a una mejor coordinación entre los diferentes niveles de atención, favoreciendo la continuidad del cuidado y la integración de los servicios de salud.

Este enfoque de gestión de la calidad, centrado en la innovación tecnológica y en la mejora continua de los procesos, no solo aumentaría la eficiencia operativa de EsSalud, sino que también mejoraría la experiencia del paciente, al ofrecer servicios más ágiles, seguros y personalizados. De esta manera, la historia clínica electrónica única se convierte en un pilar fundamental para avanzar hacia una excelencia en la gestión de la calidad en el ámbito de la salud pública, alineada con los estándares internacionales y las expectativas de la sociedad.

2.3. Definición de términos

Calidad de los Servicios de Atención Médica: La medida en que los servicios médicos cumplen con los estándares de calidad. Fuente: Goetsch y Davis, 2014.

Comunicación Interna: La transferencia de información dentro de una organización de atención médica. Fuente: Deetz, 2017.

EMR (Electronic Medical Record - Registro Médico Electrónico): Similar a la EHR, pero se enfoca específicamente en la información médica del paciente dentro de una institución de atención médica. Fuente: Stanhope y Matthews, 2019.

EHR (Electronic Health Record - Historia Clínica Electrónica): Un registro digital de la información de salud de un paciente, que incluye historiales médicos, tratamientos, resultados de pruebas y más. Fuente: Stanhope y Matthews, 2019.

Estándares de Calidad: Criterios y normas que definen la calidad de la atención médica. Fuente: Juran, 1992.

Estructura Organizativa: La forma en que se organiza una institución de atención médica. Fuente: Chandler, 2003.

FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources - Recursos de Interoperabilidad para Atención Médica Rápida): son un estándar de datos de atención médica con una interfaz de programación de aplicaciones (API) para representar e intercambiar registros de salud electrónicos (HCE). FHIR es una red de información que te permite vincular datos entre sistemas y una red de comunicación que te permite intercambiar datos entre sistemas.

Historia Clínica Electrónica (HCE): Un sistema digital para el registro y almacenamiento de información médica de pacientes. Fuente: Cros et al., 2020.

IAFA: Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud. Son responsables de la captación y administración de los recursos destinados al financiamiento de las prestaciones de salud y la cobertura de riesgos de los asegurados. Entre estas entidades se incluyen el Seguro Integral de Salud (SIS), EsSalud, los sistemas de salud de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), los seguros prepagos, los autoseguros, las compañías de seguros y los Afocats.

LIC (Low-Income Country - País de Bajos Ingresos): Se refiere a una nación o país cuya economía se caracteriza por tener un bajo ingreso per cápita y recursos limitados. En el contexto de la atención médica, esto puede influir en la disponibilidad de recursos y la implementación de sistemas de salud electrónicos. Fuente: Woldemariam y Jimma, 2023.

Planificación Estratégica: El proceso de establecer metas y objetivos a largo plazo para una institución de atención médica. Fuente: Ander, 1970.

Recopilación de Datos Clínicos: La recolección de información médica relevante de los pacientes. Fuente: Gutiérrez, 2021.

Registros Médicos Electrónicos: Documentación médica en formato digital. Fuente: Stanhope y Matthews, 2019.

Satisfacción del Paciente: El grado de satisfacción de un paciente con la atención médica recibida. Fuente: Adaptado de Encuesta de Satisfacción del Paciente.

SIHCE (Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas): Un sistema utilizado para gestionar historias clínicas electrónicas en instituciones médicas. Fuente: Condori y Rivera, 2021.

e-Qhali: Una plataforma de historia clínica electrónica que utiliza tecnología blockchain. Fuente: Fernández y Huarac, 2021.

CAPITULO III: METODOLOGÍA

En el tercer capítulo, se describe detalladamente el diseño metodológico de la investigación, incluyendo el enfoque cuantitativo utilizado y la justificación de la selección de este. Se detalla el proceso de selección de la muestra, que incluye personal administrativo y de salud de un establecimiento de EsSalud, así como los instrumentos de recolección de datos, principalmente encuestas validadas por expertos y pruebas piloto. Además, se explican los procedimientos de análisis de datos y las técnicas estadísticas empleadas para contrastar las hipótesis de investigación, garantizando la validez y confiabilidad de los resultados.

3.1. Diseño metodológico

El diseño metodológico es un componente esencial en cualquier investigación, ya que determina cómo se recogerán y analizarán los datos para abordar el problema de investigación. Este estudio sigue un enfoque cuantitativo, el cual se centra en la recolección y análisis de datos numéricos con el objetivo de identificar patrones y establecer relaciones causales entre variables. Según autores como Bryman (2016) y Creswell y Creswell (2017), el enfoque cuantitativo es especialmente adecuado para investigaciones que buscan medir fenómenos y probar hipótesis de manera objetiva. En este contexto, el enfoque cuantitativo permite explorar cómo la implementación de la Historia Clínica Electrónica Única (HCEU) afecta la toma de decisiones en EsSalud, ofreciendo una visión clara y fundamentada en datos empíricos.

3.1.1 Enfoque de Investigación

El enfoque de investigación utilizado en este estudio se inscribe dentro del paradigma positivista, el cual sostiene que el conocimiento se obtiene a través de la observación y medición de fenómenos objetivos y cuantificables (Muijs, 2010). La investigación se centra en la medición precisa de variables como la eficiencia en la toma de decisiones y la calidad de la atención médica, que son factores clave en la implementación de la HCEU. Este paradigma es particularmente relevante para investigaciones que buscan explicar fenómenos complejos en contextos de salud pública, permitiendo un análisis sistemático y objetivo que puede ser replicado y generalizado a otros contextos similares.

3.1.2 Tipo de Investigación

La investigación se clasifica como básica y de alcance explicativo o causal, ya que busca entender las causas y efectos subyacentes a la implementación de la HCEU en EsSalud. La investigación básica se caracteriza por su enfoque en la generación de conocimiento teórico que puede ser utilizado para futuras investigaciones aplicadas (Neuman, 2014). En este caso, el estudio busca no solo describir los efectos de la HCEU, sino también explicar las relaciones causales entre esta implementación y la toma de decisiones en el sistema de salud, proporcionando una base sólida para la comprensión y mejora de la gestión de la salud pública.

3.1.3 Nivel de Investigación

El nivel de investigación es explicativo, lo que implica un análisis profundo de las causas que determinan los fenómenos observados. Como destacan Babbie (2015) y Saunders et al. (2016), la investigación explicativa es fundamental para identificar las relaciones causales entre variables, permitiendo a los investigadores comprender no solo cómo suceden los fenómenos, sino por qué ocurren de esa manera. En el caso de este estudio, se pretende explicar cómo la implementación de la HCEU impacta la toma de decisiones en EsSalud, ofreciendo una comprensión integral de los factores que influyen en la eficiencia y efectividad de las decisiones clínicas y administrativas.

3.1.4 Diseño de Investigación

El diseño de esta investigación es no experimental y transversal. Un diseño no experimental es adecuado cuando el investigador no manipula las variables independientes, sino que observa las relaciones tal como ocurren naturalmente (Shadish et al., 2002). La elección de un diseño transversal, que implica la recolección de datos en un único punto en el tiempo, permite captar una "instantánea" de la implementación de la HCEU y su impacto en la toma de decisiones en EsSalud. Este enfoque es útil para obtener una visión general y establecer una base para estudios futuros que podrían adoptar un diseño longitudinal.

3.1.5 Temporalidad

La temporalidad de la investigación es transversal, lo que significa que los datos se recogen en un solo momento en el tiempo, permitiendo evaluar el impacto inmediato de la

HCEU en la toma de decisiones dentro de EsSalud. Aunque este enfoque limita la capacidad de observar cambios a lo largo del tiempo, es ideal para estudios que buscan establecer una correlación entre variables en un momento específico. Este tipo de diseño es particularmente útil en contextos donde la implementación de nuevas tecnologías, como la HCEU, puede tener efectos inmediatos que son críticos para la toma de decisiones y la planificación futura (Trochim et al., 2015).

3.2. Variables y operacionalización

Variable independiente: Historia Clínica Electrónica Única.

Variable	Definición conceptual	Dimensiones	Indicadores
Historia Clínica Electrónica Única (HCEU)	Proceso sistemático y planificado por el cual una organización de salud integra y estandariza la gestión de información de pacientes a través de soluciones digitales. Este proceso implica la transición de registros médicos y documentación clínica a un formato electrónico centralizado, con el objetivo de mejorar la accesibilidad, calidad, seguridad y eficiencia de la información sanitaria. Al alinearse con los principios de	**Planificación y Desarrollo:** conjunto de actividades orientadas a establecer objetivos claros, asignar los recursos necesarios y definir las etapas para la implementación efectiva de un sistema electrónico unificado de historias clínicas (**Norma ISO 9001:2015**).	Existencia de un plan de proyecto detallado para la implementación de la HCEU. Recursos asignados (humanos, técnicos, financieros) para la implementación de la HCEU.
		Capacitación y Soporte: conjunto de estrategias y acciones dedicadas a proporcionar al personal los conocimientos y habilidades necesarios para el uso eficaz del sistema de historia clínica electrónica (**Norma ISO 9001:2015**).	Programas de capacitación para el personal sobre el uso de la HCEU. Disponibilidad de soporte técnico para resolver dudas y problemas.

Variable	Definición conceptual	Dimensiones	Indicadores
	la **Norma ISO 9001:2015,** enfatiza el enfoque al cliente, asegurando que las necesidades y expectativas de pacientes y partes interesadas sean plenamente satisfechas. Además, promueve la mejora continua de los procesos clínicos y administrativos, facilita la toma de decisiones basada en evidencia y fortalece la gestión de riesgos y oportunidades relacionadas con la seguridad de la información y la privacidad de los pacientes.	**Funcionalidad y Usabilidad:** capacidad del sistema electrónico de historias clínicas para satisfacer las necesidades específicas de gestión de información de salud, tanto en términos de cobertura de las funciones requeridas como de facilidad de uso para todos los usuarios (**Norma ISO 9001:2015**).	Integración de la HCEU con otros sistemas existentes. Facilidad de uso y navegación dentro de la HCEU.
		Impacto y Efectividad: evaluación del éxito del sistema en alcanzar los objetivos previstos, mejorando la calidad y eficiencia de los servicios de salud (**Norma ISO 9001:2015**).	Mejoras observadas en la eficiencia de los procesos clínicos y administrativos. Satisfacción de los usuarios con la HCEU.

Variable dependiente: Gestión de la Calidad.

Variable	Definición conceptual	Dimensiones	Indicadores
Gestión de la Calidad	Enfoque sistemático para dirigir y controlar una organización con el objetivo de mejorar continuamente su eficacia y eficiencia en la entrega de productos y servicios. Se basa en principios clave como el enfoque al cliente, el liderazgo, la participación del personal, el enfoque a procesos, la mejora continua, la toma de decisiones basada en evidencia y la gestión de relaciones, todo ello con el fin de satisfacer los requisitos del cliente y aumentar su satisfacción (**Norma ISO 9001:2015**).	**Planificación:** proceso de establecer objetivos de calidad y determinar los medios necesarios para alcanzarlos, enfatizando en la mejora continua y en la gestión de riesgos y oportunidades (**Norma ISO 9001:2015**)	Existencia de un plan estratégico de recursos y servicios de atención médica. Frecuencia de actualización del plan estratégico de recursos y servicios de atención médica.
		Organización: entidad o estructura que define y gestiona sistemas y procesos para cumplir objetivos de calidad, satisfaciendo así las necesidades y expectativas de sus clientes y otras partes interesadas (**Norma ISO 9001:2015**).	Jerarquía en la estructura organizativa. Efectividad de la comunicación interna.
		Garantía y mejoramiento de los servicios: se conceptualizan conjuntamente como el compromiso y las acciones continuas de una organización para asegurar que se cumplen los requisitos de calidad y para optimizar sistemáticamente los procesos, elevando así la eficacia y satisfacción del cliente (**Norma ISO 9001:2015**).	Nivel de satisfacción con la atención médica. Nivel de cumplimiento de los estándares de calidad.
		Idoneidad de la información: datos y conocimientos pertinentes que una organización utiliza y gestiona para apoyar sus procesos y mejorar continuamente la calidad de sus productos o servicios (**Norma ISO 9001:2015**).	Nivel de recopilación de datos clínicos. Nivel de seguridad de los registros médicos.

El funcionamiento exitoso de la Historia Clínica Electrónica Única (HCEU) en EsSalud requiere una comprensión exhaustiva y detallada de las perspectivas de los grupos clave involucrados. En este contexto, el presente estudio se enfoca en analizar las expectativas, preocupaciones y necesidades del personal de salud y del personal administrativo. La inclusión de estas perspectivas es fundamental para comprender el impacto potencial de la HCEU y para asegurar un funcionamiento efectivo que se ajuste a las necesidades reales de estos usuarios clave.

En el marco de esta investigación, que busca evaluar la influencia de la Historia Clínica Electrónica Única en la gestión de la calidad de un hospital de EsSalud, se han definido meticulosamente las técnicas e instrumentos de recolección de datos para asegurar la obtención de información precisa y relevante para cada indicador establecido. Para medir los indicadores de la variable dependiente 'Gestión de la Calidad', se utilizará principalmente un cuestionario estructurado, el cual ha sido cuidadosamente diseñado para abarcar las diversas dimensiones de esta variable, incluyendo Planificación, Organización, Garantía y Mejoramiento de los Servicios, e Idoneidad de la Información.

Cada sección del cuestionario está alineada con indicadores específicos, tales como la eficiencia de la planificación estratégica, la efectividad de la comunicación interna, el nivel de satisfacción con la atención médica y la seguridad en la gestión de registros médicos, entre otros. Este instrumento será aplicado al personal administrativo y al personal de salud, permitiendo así una comparación multidimensional de las percepciones y experiencias relacionadas con la influencia de la HCEU.

Para garantizar la validez y fiabilidad del cuestionario, se realizó una prueba piloto con un grupo selecto de participantes de cada categoría de interés. Los resultados de la prueba piloto fueron analizados para hacer ajustes necesarios en el diseño del cuestionario, asegurando que las preguntas fueran claras, pertinentes y no sesgadas.

Al evaluar detalladamente las opiniones y actitudes de estos grupos mediante un cuestionario estructurado, este estudio aspira a proporcionar recomendaciones valiosas para la planificación y ejecución de la HCEU, garantizando que sus beneficios sean plenamente aprovechados y que sus posibles desafíos sean abordados de manera proactiva y eficiente.

3.3. Población y muestra

La población objeto de estudio estubo constituida por 437 empleados de una institución de salud perteneciente a EsSalud, de acuerdo con la información proporcionada directamente por la institución y refrendada por la presentación "Acreditación para la garantía de la calidad en la atención de salud" del 29 de septiembre durante la Semana de la Calidad en Salud (MINSA 2023), que incluye tanto al personal de salud como al personal administrativo. La unidad de análisis correspondió a cada empleado individualmente, mientras que el elemento de análisis se refiere a las respuestas obtenidas mediante un cuestionario.

Para determinar el tamaño de la muestra, se utilizó la fórmula de Cochran para poblaciones infinitas:

$$n_0 = \frac{Z^2 * p * q}{e^2}$$

Donde:

- Z es el valor de la distribución normal estándar correspondiente al nivel de confianza deseado (1.96 para un nivel de confianza del 95%).
- p es la proporción estimada de la población (0.5, que maximiza la variabilidad).
- q = 1 − p (0.5).
- e es el margen de error aceptable (0.05 o 5%).

Sustituyendo los valores:

$$n_0 = \frac{(1.96)^2 * (0.5) * (0.5)}{(0.05)^2} = \frac{3.8416 \ * 0.25}{0.0025} = 384.16$$

Este valor n_0 representa el tamaño de muestra inicial para una población infinita. Sin embargo, dado que la población es finita, se ajusta el tamaño de la muestra utilizando la fórmula de Cochran para poblaciones finitas:

$$n = \frac{n_0}{1 + (\frac{n_0 - 1}{N})}$$

Donde N es el tamaño de la población (437).

$$n = \frac{384.16}{1 + (\frac{384.16 - 1}{437})} = \frac{384.16}{1 + 0.8774} = \frac{384.16}{1.8774} \cong 204.62$$

Redondeando, el tamaño de muestra ideal fue de 205 participantes. Sin embargo, debido a las limitaciones en la recolección de datos, solo se obtuvieron 144 respuestas válidas.

Dado que el tamaño de la muestra efectiva es inferior al calculado inicialmente, se realizaron ajustes metodológicos. Estos ajustes implican recalcular el margen de error y nivel de confianza:

Margen de error ajustado ($e_{ajustado}$):

$$e_{ajustado} = Z * \sqrt{\frac{p * q}{n}} = 1.96 * \sqrt{\frac{0.5 * 0.5}{144}} \cong 0.0818 \ o \ 8.18\%$$

Con esta muestra de 144, el margen de error ajustado fue aproximadamente del 8.18%, lo cual sigue siendo aceptable para los propósitos del estudio.

Cabe recalcar que el tamaño de la muestra obtenido, aunque fue menor que el calculado, siguió siendo suficiente para el análisis, dado que la tasa de respuesta reflejó un porcentaje aceptable de la población total (32.95%). Es importante reconocer que el uso de una muestra más pequeña podría afectar la generalización de los resultados, pero los métodos

estadísticos aplicados permitieron un análisis riguroso y fiable de los datos obtenidos (Hair et al., 2021; Creswell & Creswell, 2017).

El muestreo probabilístico empleado aseguró que cada miembro de la población tuviese una probabilidad conocida y no nula de ser seleccionado, lo que fortaleció la representatividad de los resultados y minimizó los sesgos (Kumar, 2019).

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

El proceso de recolección de datos en esta investigación se llevó a cabo de manera meticulosa, incorporando métodos tanto del nivel teórico como del nivel empírico. Siguiendo la recomendación de Creswell y Creswell (2017), la selección de las técnicas se realizó cuidadosamente para garantizar su idoneidad en la resolución del problema de investigación. Únicamente se empleó el cuestionario como instrumento de recolección de datos, el cual fue presentado detalladamente en una ficha técnica, respaldando este enfoque por Hernández et al. (2018), lo cual permitió una presentación transparente y exhaustiva del instrumento utilizado, contribuyendo a la robustez de los resultados.

El procedimiento de recolección de datos se llevó a cabo de manera remota, mediante el envío electrónico del instrumento de investigación a los participantes. Se siguió cuidadosamente las pautas de Leedy y Ormrod (2019) para detallar las acciones durante la aplicación del instrumento, asegurando así la consistencia y validez de los datos recopilados.

Es importante recalcar que el único instrumento de recolección de datos utilizado fue el cuestionario, el cual fue administrado de manera electrónica. El enlace para completar el cuestionario se envió a través de los correos electrónicos del personal administrativo y de salud. Este enfoque electrónico proporcionó una mayor conveniencia y accesibilidad para los

participantes, así como una eficiencia en términos de tiempo y recursos para la recolección de datos.

Al adoptar esta estrategia de recolección de datos, se buscó obtener información precisa y relevante que respaldara el análisis exhaustivo de la relación entre la Historia Clínica Electrónica Única y la gestión de la calidad en EsSalud.

A continuación se presenta la ficha técnica correspondiente:

Ficha Técnica del Cuestionario

Nombre del Instrumento: Cuestionario sobre la Influencia de la Historia Clínica Electrónica Única en la gestión de la calidad de un hospital de EsSalud.

Autoría: El cuestionario ha sido desarrollado por Sergio Isaías de Jesús Esparza Morgan.

Contexto de Origen: Este instrumento ha sido diseñado específicamente para evaluar las percepciones y expectativas de diferentes grupos de interés (personal administrativo y personal de salud) en relación con la influencia de la Historia Clínica Electrónica Única (HCEU) en EsSalud.

Construcción y Diseño:

- Los ítems del cuestionario se basan en una extensa revisión de literatura sobre sistemas de historia clínica electrónica y gestión de calidad en el ámbito de la salud.
- Se han incluido consultas preliminares con expertos en gestión sanitaria y tecnologías de la información en salud para la validación del contenido.

Validación:

- Implementación de una prueba piloto del cuestionario con un grupo pequeño y diverso representativo de cada segmento de interés.
- Análisis posterior de los resultados de la prueba piloto para realizar ajustes en términos de claridad, comprensión y secuenciación de las preguntas.

Confiabilidad:

- Evaluación de la consistencia interna utilizando el coeficiente alfa de Cronbach tras la prueba piloto.
- Análisis de la estabilidad temporal a través de una aplicación repetida del cuestionario a un subgrupo seleccionado de la muestra.

Estructura del Cuestionario:

- El cuestionario en cuestión consta de un total de 16 preguntas, diseñadas para abordar diferentes dimensiones tanto de la variable independiente como de la variable dependiente. Estas preguntas están distribuidas de manera equitativa entre las dos variables, con 8 preguntas dirigidas a explorar las dimensiones de la variable independiente y las restantes 8 preguntas enfocadas en las dimensiones de la variable dependiente. Este diseño permite una evaluación integral de la gestión de calidad en el contexto específico del estudio, abarcando una variedad de aspectos relevantes para el análisis y la interpretación de los resultados.

- Uso de una escala de Likert de 5 puntos para todas las preguntas cerradas, facilitando la cuantificación y análisis de las respuestas.

3.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos

Para desarrollar el proceso de procesamiento y análisis de datos, es crucial seguir un conjunto de procedimientos rigurosos que aseguren la calidad y validez de los resultados obtenidos. En este sentido, se implementarán las recomendaciones de expertos en la metodología de investigación.

En términos de coordinaciones previas, conforme a las recomendaciones de Creswell y Creswell (2017), se enfatiza la importancia de una planificación detallada antes de la aplicación del cuestionario electrónico. Además, se establecerán protocolos para la presentación y aplicación del Consentimiento Informado, siguiendo las pautas éticas propuestas por diversos investigadores (Hernández et al., 2018; Arias, 2016). Es fundamental que estas medidas se implementen de manera rigurosa para garantizar el cumplimiento de los estándares éticos y la integridad de la investigación.

La descripción del proceso de procesamiento y análisis de datos se realizará de manera detallada y clara, siguiendo las recomendaciones de Leedy y Ormrod (2019). En el nivel descriptivo, se utilizarán estadísticas descriptivas para resumir y presentar las características fundamentales de los datos recopilados. Se emplearán medidas de tendencia central y dispersión, permitiendo una comprensión profunda de la distribución de los datos (Creswell y Creswell, 2017).

A nivel inferencial, se seleccionarán las pruebas estadísticas más apropiadas para analizar las relaciones entre las variables de interés. Este proceso seguirá las pautas establecidas por Hernández et al. (2018), quienes enfatizan la importancia de elegir pruebas

que se alineen con la naturaleza de los datos y los objetivos de investigación. Además, se especificará el nivel de significancia (α) con el que se evaluarán las hipótesis, siguiendo estándares convencionales (Arias, 2016).

Al adoptar estas estrategias, se garantizará un procesamiento y análisis de datos robusto y confiable, permitiendo obtener conclusiones significativas que contribuirán al avance del conocimiento en el área de estudio.

3.6. Aspectos éticos

La ética en la investigación es esencial para garantizar el respeto a los derechos de los participantes, mantener la integridad académica mediante el reconocimiento adecuado de contribuciones y preservar la privacidad de la información recolectada. Su adherencia rigurosa fortalece la credibilidad y calidad de los trabajos de investigación.

En ese sentido, es fundamental asegurar el cumplimiento estricto de regulaciones nacionales e internacionales, así como garantizar la integridad y ética en cada etapa del proceso. Al respecto, diversos expertos en metodología de investigación ofrecen directrices clave que orientan la conducta ética del investigador.

En línea con las regulaciones establecidas, se seguirán los principios éticos propuestos por Hernández et al. (2018), quienes subrayan la importancia de respetar los derechos de autor y mantener un uso adecuado de citas y referencias bibliográficas. Este enfoque respalda la integridad académica al reconocer la contribución intelectual de otros autores y evitar el plagio.

En cuanto a la privacidad y confidencialidad de la información recolectada, se adoptarán medidas rigurosas para proteger los datos de los participantes, siguiendo las recomendaciones de Arias (2016) y Leedy y Ormrod (2019). Estos expertos acentúan la

necesidad de salvaguardar la identidad y detalles personales de los sujetos de estudio, garantizando la confidencialidad de la información recopilada durante el proceso de recolección de datos.

Adicionalmente, se enfatizará la aplicación del Consentimiento Informado, asegurando que los participantes estén plenamente informados sobre los objetivos de la investigación, los procedimientos y cualquier riesgo potencial. Este enfoque ético se alinea con las pautas sugeridas por Creswell y Creswell (2017), quienes destacan la importancia de obtener el consentimiento voluntario y consciente de los participantes.

CAPITULO IV: RESULTADOS

El cuarto capítulo presenta los hallazgos obtenidos de la recolección y análisis de datos. Se incluyen tablas y gráficos que ilustran las respuestas del personal encuestado sobre diversos aspectos del funcionamiento de la HCEU. Los resultados revelan tanto los beneficios percibidos, como la mejora en la eficiencia y satisfacción del usuario, como los desafíos enfrentados, tales como la necesidad de más capacitación y mejor soporte técnico. Este capítulo ofrece una visión clara de cómo la HCEU está siendo recibida y utilizada dentro del contexto de EsSalud, y evalúa la efectividad del sistema en la práctica diaria.

4.1. Contexto en el que se realizó el estudio, datos de control

El presente capítulo tiene como propósito central presentar los resultados obtenidos en la investigación, enfocándose específicamente en el proceso de validación de los ítems (preguntas del cuestionario) diseñados para evaluar el funcionamiento de la Historia Clínica Electrónica Única en EsSalud y su impacto en la gestión de la calidad de los servicios de atención médica en el año 2024. Dicha validación se llevó a cabo mediante la consulta a un panel de expertos en el campo de la salud, la gestión de la calidad y la gestión de proyectos. Los criterios utilizados para evaluar los ítems del cuestionario fueron Actualidad, Comprensión, Consistencia, Finalidad, Imparcialidad, Metodología, Organización, Relevancia, Suficiencia y Transparencia, fundamentales para asegurar la calidad y pertinencia de las herramientas de recolección de datos en estudios de esta naturaleza.

Para cada criterio mencionado, se empleó una escala de puntuación que varió de 1 a 5, donde 1 indica que el conjunto de ítems obtuvo una valoración deficiente (0%-20%) en el criterio evaluado, 2 sugiere una valoración regular (21%-40%), 3 indica una valoración buena

(41%-60%), 4 refleja una valoración muy buena (61%-80%) y 5 una valoración excelente (81%-100%). Esta escala permitió una evaluación detallada y matizada de las preguntas del cuestionario, facilitando así la identificación de áreas de mejora y asegurando que los ítems contribuyeran efectivamente a los objetivos de la investigación.

Posteriormente, para determinar la aceptación final de los ítems del cuestionario y garantizar la validez de contenido de la herramienta, se aplicó la V de Aiken, una medida estadística ampliamente reconocida en la investigación científica para evaluar la validez de contenido de ítems en instrumentos de medición. La aplicación de la V de Aiken permitió cuantificar el grado de acuerdo entre los expertos respecto a la pertinencia y calidad de los ítems, asegurando así que el instrumento de recolección de datos fuera robusto, confiable y adecuado para evaluar el funcionamiento de la Historia Clínica Electrónica Única en EsSalud en el contexto específico de este estudio.

Esta fase de validación fue crucial para el desarrollo de la investigación, ya que garantizó que el cuestionario fuera una herramienta efectiva y precisa para la recolección de datos, lo cual fue indispensable para alcanzar los objetivos planteados y proporcionar resultados fiables y de relevancia para la mejora de la gestión de la calidad en EsSalud.

Una vez que los ítems fueron validados y aceptados en base a la calificación de los expertos y tras la rigurosa aplicación de la V de Aiken, se procedió a realizar una prueba piloto del cuestionario. Esta etapa fue esencial, ya que permitió evaluar la fiabilidad y consistencia interna del instrumento de medición en condiciones similares a las del estudio definitivo. Para ello, se empleó el coeficiente Alfa de Cronbach, un estadístico muy utilizado en la investigación para medir la consistencia interna de las escalas.

La aplicación de esta prueba piloto y su posterior evaluación mediante el Alfa de Cronbach brindaron información valiosa sobre la coherencia de las respuestas a los ítems y la homogeneidad del cuestionario. Este proceso aseguró no solo la validez sino también la

fiabilidad del instrumento, fortaleciendo la calidad metodológica de la investigación y contribuyendo a la obtención de resultados confiables y replicables. Este paso constituye una fase crítica en el desarrollo de estudios de esta índole, ya que garantiza la eficacia de la técnica de la encuesta y del cuestionario como herramienta de recolección de datos y permite ajustes necesarios antes de su aplicación en el contexto de la investigación principal.

En el contexto de esta investigación la elección de técnicas e instrumentos de recolección, procesamiento y análisis de datos obedeció al propósito de evaluar de manera objetiva y sistemática el funcionamiento de la Historia Clínica Electrónica Única en EsSalud, así como su impacto en la gestión de la calidad de los servicios de atención médica en el año 2024. Este enfoque cuantitativo facilitó la generación de datos numéricos, permitiendo una interpretación estadística rigurosa de los resultados.

Para la recolección de datos, se elaboró un cuestionario estructurado el cual fue diseñado para incluir una serie de ítems que abarcaran las dimensiones críticas de la investigación, tales como la eficiencia operativa, la satisfacción del usuario y los estándares de calidad en la atención médica. La decisión de emplear un cuestionario se justificó por su eficacia en la obtención de datos cuantitativos de forma estandarizada, lo cual fue indispensable para el análisis estadístico posterior. Además, esta herramienta permitió alcanzar a una amplia población de estudio, asegurando la representatividad y la generalización de los hallazgos.

En el mencionado cuestionario, adicional a los ocho ítems para cada una de las variables, se incluyó ítems relacionado con información demográfica, tales como edad, género, ocupación y el tiempo de trabajo para EsSalud.

Para el procesamiento y análisis de los datos recogidos mediante el cuestionario, se recurrió al uso del software estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Esta herramienta tecnológica es reconocida y utilizada en el ámbito de la investigación social

y de salud por su capacidad para realizar un análisis detallado y multifacético de los datos cuantitativos. El SPSS facilita desde la ejecución de estadísticas descriptivas básicas hasta la aplicación de técnicas de análisis inferencial más complejas, como pruebas de hipótesis, análisis de varianza, análisis de correlación y regresión lineal, entre otros.

La elección del SPSS como herramienta de soporte para el análisis de los datos se justifica por varias razones. Primero, su interfaz intuitiva y su amplia funcionalidad hacen posible que investigadores de diversos niveles de expertise puedan llevar a cabo análisis estadísticos rigurosos. Segundo, el SPSS ofrece opciones de manejo y limpieza de datos, lo cual es crucial para asegurar la calidad de los datos antes de su análisis. Finalmente, la capacidad del SPSS para manejar grandes volúmenes de datos y su flexibilidad en la generación de tablas y gráficos facilitan la interpretación y presentación de los resultados de manera clara y comprensible.

De esta manera, la metodología cuantitativa adoptada en este estudio, mediante el uso de cuestionarios estructurados y el análisis estadístico con el SPSS, permitió una evaluación objetiva y confiable del funcionamiento de la Historia Clínica Electrónica Única en EsSalud. Este enfoque metodológico aseguró la obtención de datos cuantitativos precisos y la generación de conclusiones basadas en evidencia, contribuyendo de manera significativa al cuerpo de conocimiento sobre la gestión de la calidad en los servicios de atención médica.

Es primordial abordar con detalle las actividades realizadas para garantizar la preparación y calidad de los datos recolectados, fundamentales para el análisis cuantitativo del funcionamiento de la Historia Clínica Electrónica Única en EsSalud y su impacto en la gestión de la calidad. La meticulosa preparación de datos constituye un paso crítico en la investigación cuantitativa, asegurando que el análisis posterior se base en información precisa, completa y confiable.

Inicialmente, la preparación de los datos comenzó con la recolección sistemática a través del cuestionario estructurado mencionado anteriormente, diseñado para capturar la variedad de dimensiones relevantes al estudio. Tras la recolección, se procedió a la limpieza de datos, una fase esencial que implicó la revisión minuciosa de las respuestas para identificar y corregir posibles errores o inconsistencias, tales como valores perdidos, atípicos o fuera de rango. Esta etapa fue crucial para minimizar cualquier distorsión en el análisis estadístico posterior.

Posteriormente, se realizó la codificación de los datos, transformando las respuestas cualitativas en valores numéricos estandarizados, facilitando así su tratamiento estadístico en SPSS. Esta codificación se llevó a cabo siguiendo un esquema predefinido que aseguró la coherencia y permitió un análisis eficiente de los datos. La estandarización de los datos mediante su codificación permitió agrupar las respuestas de manera que reflejaran de forma fidedigna las variables e indicadores definidos en la fase de diseño de la investigación.

Una vez codificados, se procedió a la validación de los datos, empleando técnicas estadísticas para verificar su fiabilidad y validez. Esta etapa incluyó la verificación de la normalidad de la distribución, la homogeneidad de las varianzas y la independencia de las observaciones. Estos tests estadísticos proporcionaron una base sólida para la selección de las pruebas estadísticas más adecuadas para el análisis de datos, asegurando así la validez de las inferencias realizadas.

Finalmente, se efectuó un análisis exploratorio de los datos, lo cual permitió obtener una visión preliminar de las tendencias, patrones y posibles relaciones entre las variables estudiadas. Este análisis exploratorio fue fundamental para guiar el análisis estadístico más detallado, permitiendo identificar aspectos críticos a investigar y ajustar las hipótesis de estudio según fuera necesario.

En conjunto, estas actividades de preparación y aseguramiento de la calidad de los datos constituyeron la columna vertebral sobre la cual se sustentaron los resultados de la investigación. La rigurosidad en cada una de estas etapas garantizó que los hallazgos y conclusiones del estudio fueran el reflejo fiel de la realidad investigada, proporcionando insights valiosos para la mejora de la gestión de la calidad en EsSalud a través del funcionamiento de la Historia Clínica Electrónica Única. La claridad y solvencia con la que se ha descrito y se ejecutaron estas actividades reforzaron la confiabilidad y la credibilidad de los resultados obtenidos, fundamentales para la toma de decisiones basadas en evidencia en el ámbito de la gestión sanitaria.

A continuación, se detalla la codificación de los ítems del cuestionario estructurado para cada una de las variables:

Tabla 2: *Codificación de los Ítems del cuestionario para la Variable Independiente, Historia Clínica Electrónica Única*.

Código	Ítem
P01	La institución cuenta con un plan de proyecto integral que permite un adecuado funcionamiento de la Historia Clínica Electrónica Única.
P02	La institución cuenta con los recursos (humanos, técnicos y financieros) suficientes que garantizan el adecuado funcionamiento de la Historia Clínica Electrónica Única.
P03	La institución otorga capacitaciones oportunas a los colaboradores sobre el uso adecuado de la Historia Clínica Electrónica Única.
P04	La institución cuenta con un adecuado soporte técnico para solucionar cualquier inconveniente respecto al funcionamiento de la Historia Clínica Electrónica Única.
P05	La Historia Clínica Electrónica Única se integra adecuadamente con los demás sistemas informáticos de la Institución.
P06	La Historia Clínica Electrónica Única es amigable en su uso y funcionamiento.
P07	El uso de la Historia Clínica Electrónica Única contribuye a la mejora en la eficiencia de los procesos clínicos y administrativos.
P08	El uso de la Historia Clínica Electrónica Única contribuye al incremento de la satisfacción general de los usuarios.

Nota. Elaboración propia.

Tabla 3: *Codificación de los Ítems del cuestionario para la Variable Dependiente, Gestión de la Calidad*.

Código	Ítem
P09	La institución cuenta con un adecuado plan estratégico de recursos y servicios de atención médica.
P10	La institución actualiza su plan estratégico de recursos y servicios de atención médica.
P11	Las actividades que realiza cada colaborador están claramente definidas en la institución.
P12	Los colaboradores de la institución se comunican y actúan coordinadamente para el cumplimiento de las metas.
P13	La institución realiza de manera constante acciones adecuadas para mejorar la calidad en los servicios de salud.
P14	La institución cuenta con la capacidad y recursos para optimizar la calidad de atención.
P15	La institución cuenta con un adecuado sistema de recopilación de datos clínicos.
P16	La institución cuenta con un adecuado sistema que permite la seguridad de los registros médicos.

Nota. Elaboración propia.

4.2. Análisis de confiabilidad

El paso previo al análisis de confiabilidad fue garantizar la validez del instrumento mediante el juicio de expertos, para lo cual se extendieron invitaciones a seis profesionales con una vasta experiencia en la gestión de la calidad y en la administración de proyectos. Como resultado, se recibieron cuatro respuestas, las cuales fueron utilizadas para llevar a cabo, siguiendo dos métodos, los cálculos requeridos para obtener la V de Aiken. Los detalles de dichos cálculos se presentan a continuación.

Tabla 4: *Cálculo de la V de Aiken, método 1, en base a la validación por juicio de expertos, variable independiente*.

N°	Criterio	EXPERTO 1	EXPERTO 2	EXPERTO 3	EXPERTO 4
1	RELEVANCIA	5	5	4	5
2	CONSISTENCIA	5	4	4	5
3	FINALIDAD	5	5	4	5
4	ACTUALIDAD	5	5	3	5
5	IMPARCIALIDAD	5	4	4	5
6	TRANSPARENCIA	5	4	4	5
7	METODOLOGÍA	5	4	4	5
8	ORGANIZACIÓN	5	5	4	5
9	COMPRENSIÓN	5	5	4	5
10	SUFICIENCIA	5	5	4	5

N°	Criterio	EXPERTO 1	EXPERTO 2	EXPERTO 3	EXPERTO 4
1	RELEVANCIA	1	1	0.75	1
2	CONSISTENCIA	1	0.75	0.75	1
3	FINALIDAD	1	1	0.75	1
4	ACTUALIDAD	1	1	0.5	1
5	IMPARCIALIDAD	1	0.75	0.75	1
6	TRANSPARENCIA	1	0.75	0.75	1
7	METODOLOGÍA	1	0.75	0.75	1
8	ORGANIZACIÓN	1	1	0.75	1
9	COMPRENSIÓN	1	1	0.75	1
10	SUFICIENCIA	1	1	0.75	1

Menor categoría	1	Restar 1
Número de categorías -1	4	Dividir entre 4
Promedio (V de Aiken)	**0.90625**	

Nota. Elaboración propia.

Tabla 5: *Cálculo de la V de Aiken, método 1, en base a la validación por juicio de expertos, variable dependiente*.

N°	Criterio	EXPERTO 1	EXPERTO 2	EXPERTO 3	EXPERTO 4
1	RELEVANCIA	5	5	4	5
2	CONSISTENCIA	5	4	4	5
3	FINALIDAD	5	5	4	5
4	ACTUALIDAD	5	5	3	5
5	IMPARCIALIDAD	5	4	4	5
6	TRANSPARENCIA	5	4	4	5
7	METODOLOGÍA	5	4	4	5
8	ORGANIZACIÓN	5	5	4	5
9	COMPRENSIÓN	5	5	4	5
10	SUFICIENCIA	5	5	4	5

N°	Criterio	EXPERTO 1	EXPERTO 2	EXPERTO 3	EXPERTO 4
1	RELEVANCIA	1	1	0.75	1
2	CONSISTENCIA	1	0.75	0.75	1
3	FINALIDAD	1	1	0.75	1
4	ACTUALIDAD	1	1	0.5	1
5	IMPARCIALIDAD	1	0.75	0.75	1
6	TRANSPARENCIA	1	0.75	0.75	1
7	METODOLOGÍA	1	0.75	0.75	1
8	ORGANIZACIÓN	1	1	0.75	1
9	COMPRENSIÓN	1	1	0.75	1
10	SUFICIENCIA	1	1	0.75	1

Menor categoría	1	Restar 1
Número de categorías -1	4	Dividir entre 4
Promedio (V de Aiken)	**0.90625**	

Nota. Elaboración propia.

Tabla 6: *Cálculo de la V de Aiken, método 2, en base a la validación por juicio de expertos, variable independiente.*

	Relevancia	Consistencia	Finalidad	Actualidad	Imparcialidad	Transparencia	Metodología	Organización	Comprensión	Suficiencia
Experto 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Experto 2	5	4	5	5	4	4	4	5	5	5
Experto 3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
Experto 4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
TOTAL	19	18	19	18	18	18	18	19	19	19
V de Aiken	0.95	0.90	0.95	0.90	0.90	0.90	0.90	0.95	0.95	0.95
V de Aiken Total	**0.93**									

Nota. Elaboración propia.

Tabla 7: *Cálculo de la V de Aiken, método 2, en base a la validación por juicio de expertos, variable dependiente.*

	Relevancia	Consistencia	Finalidad	Actualidad	Imparcialidad	Transparencia	Metodología	Organización	Comprensión	Suficiencia
Experto 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Experto 2	5	4	5	5	4	4	4	5	5	5
Experto 3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
Experto 4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
TOTAL	19	18	19	18	18	18	18	19	19	19
V de Aiken	0.95	0.90	0.95	0.90	0.90	0.90	0.90	0.95	0.95	0.95
V de Aiken Total	**0.93**									

Nota. Elaboración propia.

$$v = \frac{S}{n(c-1)}$$

Donde:
S: sumatoria de las respuestas o de los expertos por cada ítem.
n: número de expertos.
c: número de valores
c=6, escala de valores: 0,1,2,3,4 y 5.

Tabla de valoración:

V Aiken	Interpretación
0,00 – 0,79	Débil
0,80 – 0,89	Aceptable
0,90 – 1,00	Fuerte

El valor obtenido para el coeficiente V de Aiken con el primer método, 0.90625 para los ítems de ambas variables, permite concluir que los mismos presentan una alta validez.

De manera similar, el valor obtenido con el segundo método, 0.93, confirmó que los ítems de ambas variables eran altamente válidos.

Después de completar el proceso de validación por juicio de expertos, se procedió a dar inicio a la etapa de análisis de confiabilidad mediante la aplicación del cuestionario a través de una prueba piloto. En esta fase, se empleó la plataforma gratuita de encuestas en línea "Formularios de Google" (Google Forms), a través de la cual se distribuyó el enlace al cuestionario a personal médico y administrativo de EsSalud. Como resultado, se recibieron un total de diecisiete respuestas por parte de los participantes.

Las diecisiete respuestas fueron exportadas a una hoja de cálculo en MS Excel para su adecuación según los requisitos del software SPSS, utilizado para realizar el análisis de confiabilidad mediante la prueba Alfa de Cronbach.

Esta adecuación de los datos implicó asignar valores numéricos del 1 al 5 a las respuestas obtenidas a través del formulario, las cuales estaban en la Escala de Likert y se presentaban en los siguientes términos:

- Totalmente en desacuerdo
- En desacuerdo

- Ni de acuerdo ni en desacuerdo

- De acuerdo

- Totalmente de acuerdo.

La asignación de valores numéricos a las respuestas se realizó según la siguiente correspondencia: "Totalmente en desacuerdo" se le asignó el valor 1, "En desacuerdo" el valor 2, "Ni de acuerdo ni en desacuerdo" el valor 3, "De acuerdo" el valor 4, y "Totalmente de acuerdo" el valor 5. Tal como se muestra a continuación.

Tabla 8: *Resultados de la Prueba Piloto - Adecuación de respuestas en Escala de Likert a valores numéricos del 1 al 5 (ejemplo en base a los dos primeros ítems de la variable independiente).*

Ítems	
P01	P02
2	3
5	3
3	3
3	3
1	4
4	5
3	2
5	4
3	4
4	5
4	2
3	3
2	2
4	2
2	2
1	4
4	4

Nota: Elaboración Propia

Posteriormente, los datos fueron ingresados al software SPSS para llevar a cabo el análisis mediante la prueba Alfa de Cronbach, de la cual se obtuvieron los siguientes resultados.

Tabla 9: *Resultados SPSS, Alfa de Cronbach para los ítems de la variable independiente, Historia Clínica Electrónica Única.*

Estadísticas de fiabilidad	
Alf de Cronbach	N° de elementos
0,752	8

Nota: Elaboración Propia

Tabla 10: *Resultados SPSS, Alfa de Cronbach para los ítems de la variable dependiente, Gestión de la Calidad.*

Estadísticas de fiabilidad	
Alfa de Cronbach	N° de elementos
0,824	8

Nota: Elaboración Propia

Tras analizar los resultados obtenidos, 0.752 para la variables independiente y 0.824 para la variable dependiente, y tomando en consideración los valores de la Tabla 11, se determinó que los ítems presentaban una alta fiabilidad, lo que permitió proceder con la aplicación del cuestionario al total de la muestra seleccionada para el estudio.

Tabla 11: *Consistencia interna por rangos del Alfa de Cronbach.*

Alpha	Consistencia interna
$\alpha \geq 0.8$	Muy alta
$0.6 \leq \alpha < 0.8$	Alta
$0.4 \leq \alpha < 0.6$	Moderada
$0.2 \leq \alpha < 0.4$	Baja
$0 \leq \alpha < 0.2$	Muy baja

Nota: Elaboración propia. Adaptado de Corral (2009)

4.3. Análisis de los resultados

Una vez validado el instrumento mediante el criterio de expertos y corroborada su fiabilidad, se llevó a cabo la administración del cuestionario entre los 437 empleados, incluyendo tanto al personal sanitario como administrativo, pertenecientes a la institución de EsSalud objeto de estudio. De este grupo, se recibieron 144 respuestas, lo que equivale al 32.95% del total de la población laboral. Posteriormente, se analizaron los resultados obtenidos, los cuales se detallan a continuación:

Respuestas a las preguntas asociadas a las dimensiones de la variable independiente “Historia Clínica Electrónica Única”:

P01: El 71.53% de los encuestados indicaron estar "de acuerdo" o "totalmente de acuerdo" con la afirmación: "La institución cuenta con un plan de proyecto integral que permite un adecuado funcionamiento de la Historia Clínica Electrónica Única.".

P02: El 70.80% de los encuestados indicaron estar "ni de acuerdo ni en desacuerdo" o "de acuerdo" con la afirmación: "La institución cuenta con los recursos (humanos, técnicos y financieros) suficientes que garantizan el adecuado funcionamiento de la Historia Clínica Electrónica Única.".

P03: El 70.80% de los encuestados indicaron estar "de acuerdo" o "totalmente de acuerdo" con la afirmación: "La institución otorga capacitaciones oportunas a los colaboradores sobre el uso adecuado de la Historia Clínica Electrónica Única.".

P04: El 71.53% de los encuestados indicaron estar "ni de acuerdo ni en desacuerdo" o "de acuerdo" con la afirmación: "La institución cuenta con un adecuado soporte técnico para solucionar cualquier inconveniente respecto al funcionamiento de la Historia Clínica Electrónica Única.".

P05: El 67.36% de los encuestados indicaron estar "de acuerdo" o "ni de acuerdo ni en desacuerdo" con la afirmación: "La Historia Clínica Electrónica Única se integra adecuadamente con los demás sistemas informáticos de la Institución.".

P06: El 77.08% de los encuestados indicaron estar "de acuerdo" o "totalmente de acuerdo" con la afirmación: "La Historia Clínica Electrónica Única es amigable en su uso y funcionamiento.".

P07: El 77.08% de los encuestados indicaron estar "de acuerdo" o "totalmente de acuerdo" con la afirmación: "El uso de la Historia Clínica Electrónica Única contribuye a la mejora en la eficiencia de los procesos clínicos y administrativos.".

P08: El 76.39% de los encuestados indicaron estar "de acuerdo" o "totalmente de acuerdo" con la afirmación: "El uso de la Historia Clínica Electrónica Única contribuye al incremento de la satisfacción general de los usuarios.".

Los resultados obtenidos respecto a las percepciones de los encuestados sobre la Historia Clínica Electrónica Única (HCEU) evidencian un consenso general positivo sobre su impacto en la gestión de la calidad en EsSalud. Un análisis detallado de cada dimensión asociada a la variable independiente revela puntos clave que contribuyen a la comprensión del funcionamiento y efectividad del sistema.

En primer lugar, el 71.53% de los encuestados señalaron estar "de acuerdo" o "totalmente de acuerdo" con que la institución cuenta con un plan de proyecto integral que asegura el adecuado funcionamiento de la HCEU (P01). Este hallazgo sugiere que los esfuerzos institucionales para estructurar y formalizar la HCEU han sido percibidos como efectivos, garantizando una base sólida para su operación.

No obstante, al evaluar los recursos disponibles para garantizar el funcionamiento continuo del sistema, el 70.80% de los encuestados se posicionaron entre "ni de acuerdo ni en desacuerdo" o "de acuerdo" respecto a la suficiencia de los recursos humanos, técnicos y financieros (P02). Este resultado destaca una percepción de incertidumbre o insuficiencia en términos de los recursos asignados, lo que podría representar una barrera potencial para el éxito sostenible de la HCEU.

En cuanto a la capacitación del personal, el 70.80% de los encuestados manifestaron estar "de acuerdo" o "totalmente de acuerdo" en que la institución brinda capacitaciones oportunas para asegurar un uso adecuado del sistema (P03). Este dato indica que, a pesar de la percepción moderada sobre los recursos, la capacitación del personal sigue siendo prioritaria, lo que contribuye al uso efectivo de la HCEU.

Respecto al soporte técnico ofrecido por la institución, el 71.53% de los encuestados reportaron estar "ni de acuerdo ni en desacuerdo" o "de acuerdo" con la afirmación de que la institución provee un soporte adecuado para resolver problemas técnicos relacionados con la HCEU (P04). Esto sugiere que, aunque la mayoría percibe positivamente la disponibilidad de soporte, existe un margen de mejora para ofrecer soluciones más efectivas y rápidas ante inconvenientes técnicos.

En cuanto a la integración de la HCEU con otros sistemas informáticos, el 67.36% de los encuestados indicaron estar "de acuerdo" o "ni de acuerdo ni en desacuerdo" (P05). Este resultado refleja una percepción menos positiva en comparación con otras dimensiones, lo que puede sugerir que la interoperabilidad entre sistemas aún presenta desafíos que requieren atención.

Por otro lado, el 77.08% de los encuestados señalaron que la HCEU es amigable en su uso y funcionamiento (P06), lo que demuestra una alta aceptación del sistema entre los usuarios, facilitando su adopción diaria. Este factor es fundamental para asegurar la eficiencia operativa y reducir la resistencia al cambio tecnológico.

Asimismo, un 77.08% de los encuestados afirmaron que la HCEU contribuye a la mejora en la eficiencia de los procesos clínicos y administrativos (P07), lo que respalda la hipótesis de que su funcionamiento tiene un efecto directo en la optimización de las actividades dentro de EsSalud. La automatización y centralización de los registros clínicos ha permitido reducir tiempos y errores en la gestión de información, mejorando así el flujo de trabajo.

Finalmente, el 76.39% de los encuestados consideraron que la HCEU contribuye al incremento de la satisfacción de los usuarios (P08), lo que sugiere que la percepción general sobre la calidad de los servicios de salud ha mejorado gracias al funcionamiento del sistema.

La facilidad de acceso a los datos, combinada con la agilidad en los procesos clínicos, ha generado un entorno más favorable para los pacientes y el personal de salud.

Así, los resultados indican que la HCEU ha sido percibida mayoritariamente de manera positiva, aunque persisten áreas que requieren mejoras, como la integración con otros sistemas y la disponibilidad de recursos suficientes. Estos resultados proporcionan una base sólida para continuar optimizando el sistema, asegurando que se mantenga como una herramienta clave en la mejora de la gestión de la calidad en EsSalud.

Respuestas a las preguntas asociadas a las dimensiones de la variable dependiente “Gestión de la Calidad”:

P09: El 84.72% de los encuestados indicaron estar "de acuerdo" o "totalmente de acuerdo" con la afirmación: "La institución cuenta con un adecuado plan estratégico de recursos y servicios de atención médica.".

P10: El 84.72% de los encuestados indicaron estar "de acuerdo" o "totalmente de acuerdo" con la afirmación: "La institución actualiza su plan estratégico de recursos y servicios de atención médica.".

P11: El 84.72% de los encuestados indicaron estar "de acuerdo" o "totalmente de acuerdo" con la afirmación: "Las actividades que realiza cada colaborador están claramente definidas en la institución.".

P12: El 84.72% de los encuestados indicaron estar "de acuerdo" o "totalmente de acuerdo" con la afirmación: "Los colaboradores de la institución se comunican y actúan coordinadamente para el cumplimiento de las metas.".

P13: El 84.72% de los encuestados indicaron estar "de acuerdo" o "totalmente de acuerdo" con la afirmación: "La institución realiza de manera constante acciones adecuadas para mejorar la calidad en los servicios de salud.".

P14: El 84.72% de los encuestados indicaron estar "de acuerdo" o "totalmente de acuerdo" con la afirmación: "La institución cuenta con la capacidad y recursos para optimizar la calidad de atención.".

P15: El 84.72% de los encuestados indicaron estar "de acuerdo" o "totalmente de acuerdo" con la afirmación: "La institución cuenta con un adecuado sistema de recopilación de datos clínicos.".

P16: El 84.72% de los encuestados indicaron estar "de acuerdo" o "totalmente de acuerdo" con la afirmación: "La institución cuenta con un adecuado sistema que permite la seguridad de los registros médicos.".

Los resultados relacionados con la percepción de los encuestados sobre la Gestión de la Calidad en EsSalud reflejan un consenso altamente positivo, lo que indica que la institución ha establecido prácticas sólidas para garantizar la calidad de los servicios de salud. Cada dimensión evaluada presenta altos porcentajes de aprobación, lo que destaca la confianza de los colaboradores en la capacidad institucional para gestionar de manera eficiente los recursos y servicios.

El 84.72% de los encuestados manifestó estar "de acuerdo" o "totalmente de acuerdo" con que la institución cuenta con un adecuado plan estratégico de recursos y servicios de atención médica (P09). Este dato evidencia que EsSalud ha desarrollado un enfoque claro y estructurado para la planificación estratégica, lo que asegura que los recursos sean asignados de manera eficiente y que los servicios de atención médica se presten con altos estándares de calidad. La planificación estratégica se presenta como un pilar fundamental para la gestión eficiente en la institución.

Asimismo, el 84.72% de los encuestados también indicó que la institución actualiza su plan estratégico de recursos y servicios de atención médica de forma regular (P10). La actualización continua del plan estratégico es esencial para adaptarse a las cambiantes

demandas del entorno de salud, y este resultado sugiere que EsSalud mantiene una actitud proactiva en la gestión de sus recursos, lo que permite un ajuste constante a las nuevas necesidades del sistema y a los avances tecnológicos.

En cuanto a la definición de las actividades del personal, el 84.72% de los encuestados coincidió en que las actividades de cada colaborador están claramente definidas (P11). La claridad en los roles y responsabilidades es un elemento crucial para garantizar la eficiencia operativa en cualquier institución, ya que permite a los colaboradores entender sus funciones y enfocarse en el cumplimiento de los objetivos institucionales. Este hallazgo resalta una adecuada gestión interna de EsSalud, lo que favorece un ambiente de trabajo organizado y orientado a resultados.

Un resultado igualmente positivo se observa en la coordinación entre colaboradores, donde el 84.72% de los encuestados señaló que existe una buena comunicación y coordinación para el cumplimiento de las metas (P12). Este aspecto es esencial para una gestión de calidad, ya que la coordinación eficaz entre los equipos de trabajo garantiza que los objetivos institucionales se logren de manera eficiente y colaborativa. La capacidad de los colaboradores para actuar en conjunto es un indicador de que EsSalud ha desarrollado un sistema organizacional que promueve el trabajo en equipo y la consecución de metas compartidas.

Otro aspecto clave que obtuvo un alto nivel de aprobación fue el relacionado con las acciones de mejora continua en la calidad de los servicios de salud, donde el 84.72% de los encuestados indicó que la institución realiza constantemente acciones para mejorar la calidad (P13). Este resultado refleja un compromiso institucional con la mejora continua, asegurando que se implementen medidas correctivas y preventivas que contribuyan a elevar la calidad de la atención brindada a los pacientes.

Además, el 84.72% de los encuestados consideró que la institución cuenta con capacidad y recursos suficientes para optimizar la calidad de la atención (P14). Este resultado sugiere que EsSalud dispone de los medios necesarios, tanto en términos de infraestructura como de personal, para llevar a cabo las acciones que garanticen una atención de calidad. Sin embargo, es importante que este recurso siga siendo gestionado adecuadamente para mantener la confianza de los colaboradores y asegurar que se sigan alcanzando los estándares de calidad establecidos.

En relación con los sistemas de recopilación de datos clínicos, el 84.72% de los encuestados estuvo de acuerdo con que la institución cuenta con un sistema adecuado para la recopilación de esta información (P15). Este hallazgo es significativo, ya que la recopilación precisa y eficiente de datos clínicos es fundamental para la gestión de la calidad en los servicios de salud. Un sistema adecuado de recolección de datos no solo mejora la toma de decisiones clínicas, sino que también permite una evaluación más precisa de los procesos asistenciales.

Finalmente, el 84.72% de los encuestados también señaló que la institución cuenta con un sistema adecuado que garantiza la seguridad de los registros médicos (P16). La seguridad de los datos clínicos es una preocupación primordial en el entorno sanitario actual, dado el creciente uso de sistemas digitales para el almacenamiento de información sensible. La alta aprobación en este aspecto sugiere que EsSalud ha implementado medidas efectivas para proteger la confidencialidad y seguridad de los registros médicos de sus pacientes, lo que refuerza la confianza en el sistema.

De esta forma, los resultados obtenidos muestran que la Gestión de la Calidad en EsSalud es percibida de manera altamente positiva por los encuestados, lo que indica un alto nivel de confianza en las prácticas institucionales relacionadas con la planificación

estratégica, la coordinación interna, la mejora continua y la seguridad de los datos. Estos elementos son clave para asegurar una atención de calidad y eficiente en el sistema de salud.

4.3.1. Prueba de Normalidad

Se llevó a cabo esta evaluación con el propósito de establecer la naturaleza de la distribución de los datos recopilados en la investigación, con el fin de decidir la pertinencia de emplear pruebas estadísticas paramétricas o no paramétricas para contrastar las hipótesis planteadas. A continuación, se describen los procedimientos seguidos para tal fin:

Paso 1: Formulación de la hipótesis nula (H_0) y de la hipótesis alterna (H_1).

Para la Variable 1: Historia Clínica Electrónica Única

H_0: Los datos cuentan con distribución normal.

$p >= 0.05$

H_1: Los datos no cuentan con distribución normal.

$p < 0.05$

Para la Variable 2: Gestión de la Calidad

H_0: Los datos cuentan con distribución normal.

$p >= 0.05$

H_1: Los datos no cuentan con distribución normal.

$p < 0.05$

Paso 2: Nivel de significancia.

Es de 5% con una confianza de 95%

Paso 3: Estadístico de Prueba.

Se usó a Kolmogorov - Smirnov para evaluar los datos recopilados a través del cuestionario, por contar con una muestra mayor a n=50.

Paso 4: Formulación de la Regla de Decisión.

H_0: p >= 0.05 presenta Datos Normales

H_1: p < 0.05 presenta Datos No Normales

Paso 5: Resultados de la aplicación de la prueba de normalidad

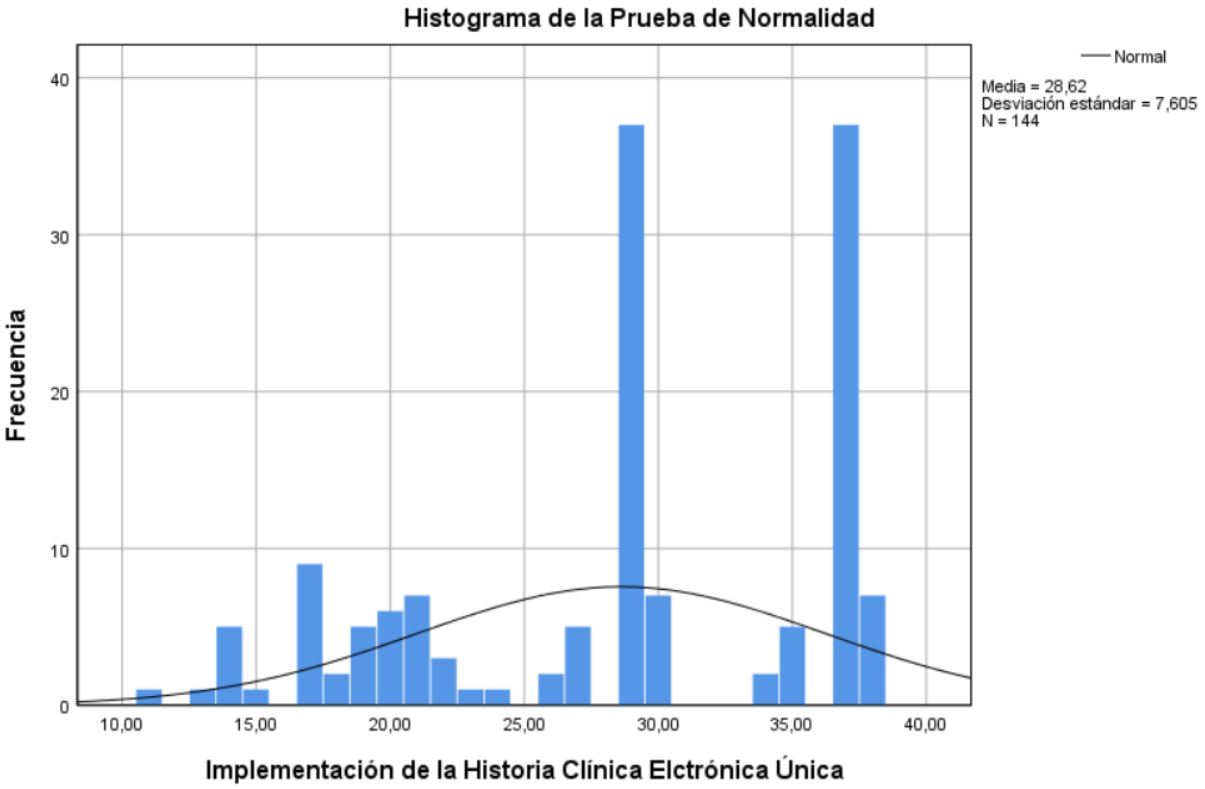
Los resultados del análisis de normalidad de las dos variables se muestran en la tabla siguiente.

Tabla 12: *Prueba de Normalidad de las Variables. Resultados del SPSS.*

Variables	Kolmogorov - Smirnov		
	Estadístico	gl	Sig.
X = Historia Clínica Electrónica Única	0,180	144	0,000
Y = Gestión de la Calidad	0,271	144	0,000

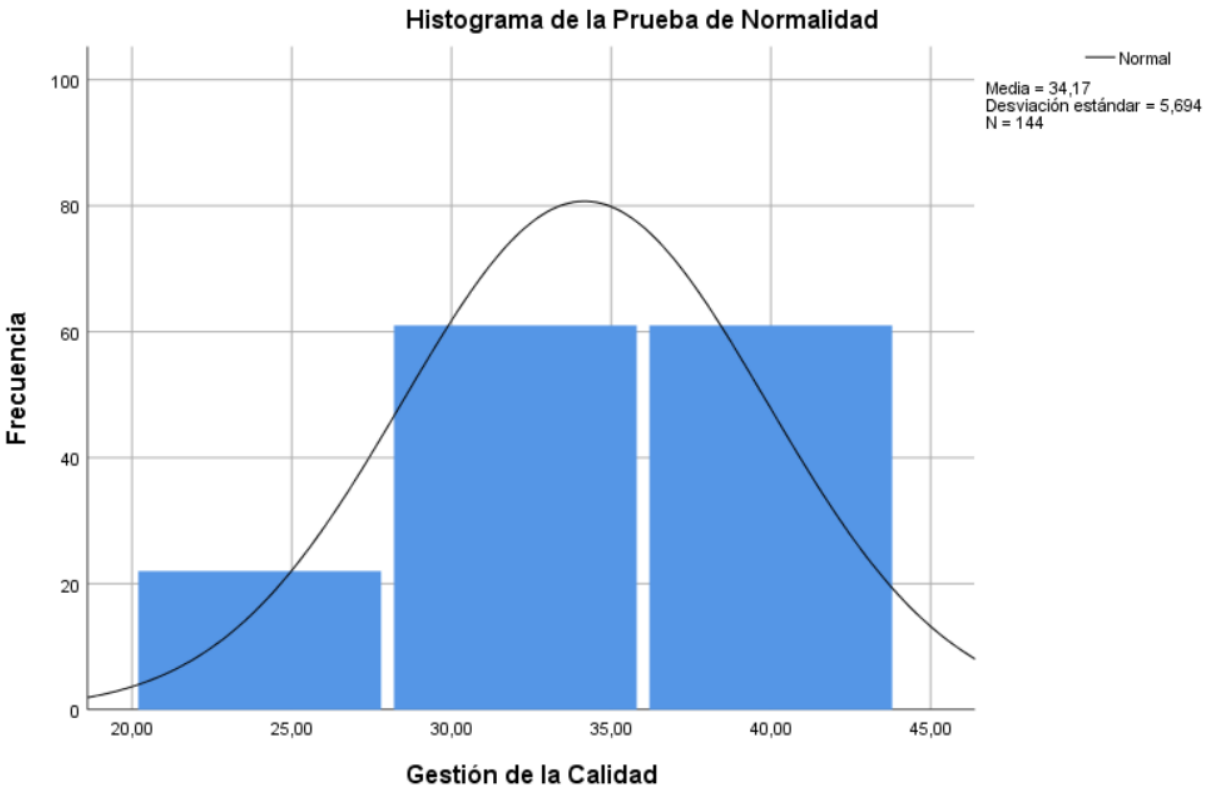
Nota: Elaboración Propia.

Figura 2: *Histograma de la Prueba de Normalidad de la Variable Independiente Historia Clínica Electrónica Única – Resultado SPSS.*



Nota: Elaboración Propia

Figura 3: *Histograma de la Prueba de Normalidad de la Variable Dependiente Gestión de la Calidad – Resultado SPSS.*



Nota: Elaboración Propia

Dado que el nivel de significancia para la Variable "Historia Clínica Electrónica Única" así como para la Variable "Gestión de la Calidad" es inferior a 0.05, se infiere que ambas variables exhiben una distribución no normal.

4.3.2. Contrastación de Hipótesis

Basándose en lo expuesto anteriormente, se aplicará la prueba de correlación de Spearman para llevar a cabo el análisis de correlación.

A. Contrastación de la Hipótesis General.

La Historia Clínica Electrónica Única tiene una influencia positiva y significativa en la gestión de la calidad de un hospital de EsSalud, 2024.

Se llevaron a cabo las siguientes etapas para la realización de la prueba del coeficiente de correlación Rho de Spearman:

Paso 1: Formulación de las hipótesis nula (H_0) y alternativa (H_1).

H_0: La Historia Clínica Electrónica Única no tiene una influencia positiva y significativa en la gestión de la calidad de un hospital de EsSalud, 2024.

H_1: La Historia Clínica Electrónica Única tiene una influencia positiva y significativa en la gestión de la calidad de un hospital de EsSalud, 2024.

Paso 2: Nivel de significancia.

Se empleó un nivel de significancia (alfa) $\alpha = 5\%$ y un nivel de confianza del 95%.

Paso 3: Estadístico de prueba.

Se aplicó el estadístico de prueba no paramétrico y se calculó la correlación de Rho de Spearman.

Paso 4: Formulación de la Regla de Decisión.

H_0: $p >= 0.05$ (No existe correlación).

H_1: $p < 0.05$ (Existe correlación).

Paso 5: Determinación de la correlación de Rho de Spearman utilizando el software SPSS.

Tabla 13: *Determinación de la correlación de Rho de Spearman utilizando el software SPSS. Variable Independiente y Variable Dependiente.*

	Correlación		X = HCEU	Y = Gestión de la Calidad
Rho de Spearman	X = HCEU	Coeficiente de correlación	1,000	0,723
		Sig. (bilateral)	.	0,000
		N	144	144
	Y = Gestión de la Calidad	Coeficiente de correlación	0,723	1,000
		Sig. (bilateral)	0,000	.
		N	144	144

Nota: Elaboración Propia.

Paso 6: Proceso de toma de decisión.

En este análisis, se observa que el nivel de significancia asintótica bilateral asociado al estadístico de Rho de Spearman es p=0,000, un valor inferior a p=0,050. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula. Se infiere que la Historia Clínica Electrónica Única tiene una influencia positiva y significativa en la gestión de la calidad de un hospital de EsSalud, 2024.

Asimismo, según la escala de interpretación de la correlación de Rho de Spearman, el valor obtenido de Rho=0,723 se sitúa dentro del intervalo de 0,6 a 0,8, lo cual indica una buena correlación positiva entre las variables Historia Clínica Electrónica Única y Gestión de la Calidad.

El análisis de Regresión Lineal arrojó los siguientes resultados:

Tabla 14: *Resumen del modelo de regresión lineal simple utilizando el software SPSS. Variable Independiente y Variable Dependiente.*

R	R cuadrado	R cuadrado ajustado	Error estándar de la estimación
0,720	0,518	0,514	3,96813

Nota: Elaboración Propia.

De la información del resumen del modelo de regresión lineal simple se infiere que la HCEU explica el 51.8% de la variabilidad en la Gestión de la Calidad, lo que sugiere una relación significativa entre ambas variables.

Tabla 15: *Análisis de varianza del modelo de regresión lineal simple utilizando el software SPSS. Variable Independiente y Variable Dependiente.*

ANOVA					
	Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	Sig.
Regresión	2400,064	1	2400,064	152,423	0,000
Residuo	2235,936	142	15,746		
Total	4636,0000	143			

Nota: Elaboración Propia.

El análisis ANOVA muestra que la HCEU tiene una influencia significativa en la Gestión de la Calidad, con un valor de F de 152.423 y un nivel de significancia de 0,000 ($p < 0.001$). Este resultado indica que es muy poco probable que la relación observada entre la HCEU y la Gestión de la Calidad sea producto del azar, lo que respalda la existencia de una relación estadísticamente significativa entre estas variables.

Tabla 16: *Análisis de coeficientes del modelo de regresión lineal simple utilizando el software SPSS. Variable Independiente y Variable Dependiente.*

Coeficientes					
	Coeficientes no estandarizados		Coeficientes estandarizados		
	B	Desv. Error	Beta	t	Sig.
Constante	18,750	1,292		14,515	0,000
X = HCEU	0,539	0,044	0,720	12,346	0,000

Nota: Elaboración Propia.

Finalmente, el análisis de los coeficientes de la regresión lineal revela que la variable independiente, HCEU, tiene un coeficiente B de 0,539, lo que indica que por cada unidad adicional en la HCEU, se espera un aumento de 0,539 unidades en la Gestión de la Calidad. Este efecto positivo y significativo se refleja en un valor t de 12,346 con una significancia estadística de 0,000 ($p < 0,001$), lo cual confirma que la HCEU es un predictor sólido y relevante para la mejora en la Gestión de la Calidad. La constante B de 18,750 sugiere que, incluso en ausencia de la HCEU, la Gestión de la calidad mantendría un valor base positivo.

La ecuación de la recta del modelo de regresión lineal simple tiene la siguiente forma:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 * X$$

Donde:

β_0 = 18,750

β_1 = 0,539

Así, la ecuación del modelo de regresión lineal para las variables HCEU (independiente) y Gestión de la Calidad (dependiente) es:

$$Y = 18{,}750 + 0{,}539 * X$$

B. Contrastación de las Hipótesis Específicas.

a) Hipótesis Específica 1.

La Historia Clínica Electrónica Única tiene una influencia positiva y significativa en la planificación de un hospital de EsSalud, 2024.

Se llevaron a cabo las siguientes etapas para la realización de la prueba del coeficiente de correlación Rho de Spearman:

Paso 1: Formulación de las hipótesis nula (H_0) y alternativa (H_1).

H_0: La Historia Clínica Electrónica Única no tiene una influencia positiva y significativa en la planificación de un hospital de EsSalud, 2024.

H_1: La Historia Clínica Electrónica Única tiene una influencia positiva y significativa en la planificación de un hospital de EsSalud, 2024.

Paso 2: Nivel de significancia.

Se empleó un nivel de significancia (alfa) $\alpha = 5\%$ y un nivel de confianza del 95%.

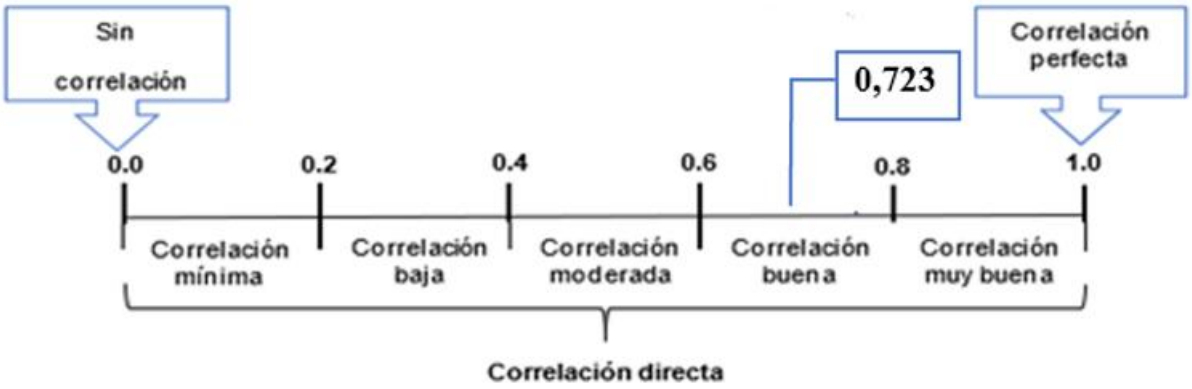
Paso 3: Estadístico de prueba.

Se aplicó el estadístico de prueba no paramétrico y se calculó la correlación de Rho de Spearman.

Paso 4: Formulación de la Regla de Decisión.

H_0: $p >= 0.05$ (No existe correlación).

H_1: $p < 0.05$ (Existe correlación).



Paso 5: Determinación de la correlación de Rho de Spearman utilizando el software SPSS.

Tabla 17: *Determinación de la correlación de Rho de Spearman utilizando el software SPSS. Variable Independiente y Dimensión Planificación de la Variable Dependiente*.

	Correlación		X = HCEU	Y = Planificación
Rho de Spearman	X = HCEU	Coeficiente de correlación	1,000	0,723
		Sig. (bilateral)	.	0,000
		N	144	144
	Y = Planificación	Coeficiente de correlación	0,723	1,000
		Sig. (bilateral)	0,000	.
		N	144	144

Nota: Elaboración Propia.

Paso 6: Proceso de toma de decisión.

En este análisis, se observa que el nivel de significancia asintótica bilateral asociado al estadístico de Rho de Spearman es p=0,000, un valor inferior a p=0,050. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula. Se infiere que la Historia Clínica Electrónica Única tiene una influencia positiva y significativa en la planificación de un hospital de EsSalud, 2024.

Asimismo, según la escala de interpretación de la correlación de Rho de Spearman, el valor obtenido de Rho=0,723 se sitúa dentro del intervalo de 0,6 a 0,8, lo cual indica una buena correlación positiva entre la variable Historia Clínica Electrónica Única y la dimensión Planificación de la variable Gestión de la Calidad.

El análisis de Regresión Lineal arrojó los siguientes resultados:

Tabla 18: *Resumen del modelo de regresión lineal simple utilizando el software SPSS. Variable Independiente y dimensión Planificación de la Variable Dependiente*.

R	R cuadrado	R cuadrado ajustado	Error estándar de la estimación
0,720	0,518	0,514	0,99203

Nota: Elaboración Propia.

De la información del resumen del modelo de regresión lineal simple se infiere que la HCEU explica el 51.8% de la variabilidad en la dimensión Planificación de Gestión de la Calidad, lo que sugiere una relación significativa entre ambas variables.

Tabla 19: *Análisis de varianza del modelo de regresión lineal simple utilizando el software SPSS. Variable Independiente y la dimensión Planificación de la Variable Dependiente*

ANOVA					
	Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	Sig.
Regresión	150,004	1	150,004	152,423	0,000
Residuo	139,746	142	0,984		
Total	289,750	143			

Nota: Elaboración Propia.

El análisis ANOVA muestra que la HCEU tiene un efecto significativo en la dimensión Planificación de Gestión de la Calidad, con un valor de F de 152.423 y un nivel de significancia de 0,000 ($p < 0.001$). Este resultado indica que es muy poco probable que la relación observada entre la HCEU y la dimensión Planificación de Gestión de la Calidad sea producto del azar, lo que respalda la existencia de una relación estadísticamente significativa entre estas variables.

Tabla 20: *Análisis de coeficientes del modelo de regresión lineal simple utilizando el software SPSS. Variable Independiente y la dimensión Planificación de la Variable Dependiente*.

Coeficientes					
	Coeficientes no estandarizados		Coeficientes estandarizados		
	B	Desv. Error	Beta	t	Sig.
Constante	4,687	0,323		14,515	0,000
X = HCEU	0,135	0,011	0,720	12,346	0,000

Nota: Elaboración Propia.

Finalmente, el análisis de los coeficientes de la regresión lineal revela que la variable independiente, HCEU, tiene un coeficiente B de 0,135, lo que indica que por cada unidad adicional en la HCEU, se espera un aumento de 0,135 unidades en la dimensión Planificación de Gestión de la Calidad. Este efecto positivo y significativo se refleja en un valor t de 12,346 con una significancia estadística de 0,000 ($p < 0,001$), lo cual confirma que la HCEU es un predictor sólido y relevante para la dimensión Planificación de Gestión de la Calidad. La constante B de 4,687 sugiere que, incluso en ausencia de la HCEU, la dimensión Planificación de Gestión de la calidad mantendría un valor base positivo.

La ecuación de la recta del modelo de regresión lineal simple tiene la siguiente forma:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 * X$$

Donde:

β_0 = 4,687

β_1 = 0,135

Así, la ecuación del modelo de regresión lineal para las variables HCEU (independiente) y la dimensión Planificación de Gestión de la Calidad (dependiente) es:

$$Y = 4{,}687 + 0{,}135 * X$$

b) Hipótesis Específica 2.

La Historia Clínica Electrónica Única tiene una influencia positiva y significativa en la organización de un hospital de EsSalud, 2024.

Se llevaron a cabo las siguientes etapas para la realización de la prueba del coeficiente de correlación Rho de Spearman:

Paso 1: Formulación de las hipótesis nula (H_0) y alternativa (H_1).

H_0: La Historia Clínica Electrónica Única no tiene una influencia positiva y significativa en la organización de un hospital de EsSalud, 2024.

H_1: La Historia Clínica Electrónica Única tiene una influencia positiva y significativa en la organización de un hospital de EsSalud, 2024.

Paso 2: Nivel de significancia.

Se empleó un nivel de significancia (alfa) α = 5% y un nivel de confianza del 95%.

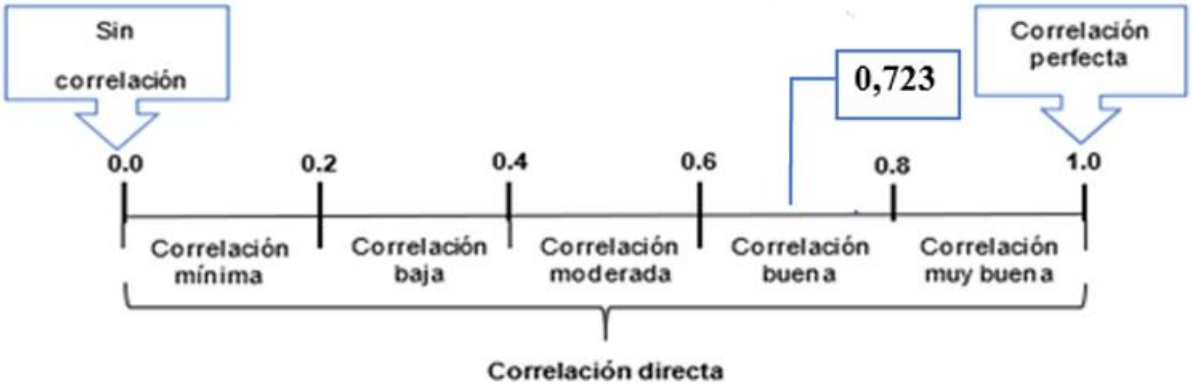
Paso 3: Estadístico de prueba.

Se aplicó el estadístico de prueba no paramétrico y se calculó la correlación de Rho de Spearman.

Paso 4: Formulación de la Regla de Decisión.

H_0: p >= 0.05 (No existe correlación).

H_1: p < 0.05 (Existe correlación).



Paso 5: Determinación de la correlación de Rho de Spearman utilizando el software SPSS.

Tabla 21: *Determinación de la correlación de Rho de Spearman utilizando el software SPSS. Variable Independiente y Dimensión Organización de la Variable Dependiente*.

	Correlación		X = HCEU	Y = Organización
Rho de Spearman	X = HCEU	Coeficiente de correlación	1,000	0,723
		Sig. (bilateral)	.	0,000
		N	144	144
	Y = Organización	Coeficiente de correlación	0,723	1,000
		Sig. (bilateral)	0,000	.
		N	144	144

Nota: Elaboración Propia.

Paso 6: Proceso de toma de decisión.

En este análisis, se observa que el nivel de significancia asintótica bilateral asociado al estadístico de Rho de Spearman es p=0,000, un valor inferior a p=0,050. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula. Se infiere que la Historia Clínica Electrónica Única tiene una influencia positiva y significativa en la organización de un hospital de EsSalud, 2024.

Asimismo, según la escala de interpretación de la correlación de Rho de Spearman, el valor obtenido de Rho=0,723 se sitúa dentro del intervalo de 0,6 a 0,8, lo cual indica una buena correlación positiva entre la variable Historia Clínica Electrónica Única y la dimensión Organización de la variable Gestión de la Calidad.

El análisis de Regresión Lineal arrojó los siguientes resultados:

Tabla 22: *Resumen del modelo de regresión lineal simple utilizando el software SPSS. Variable Independiente y dimensión Organización de la Variable Dependiente*.

R	R cuadrado	R cuadrado ajustado	Error estándar de la estimación
0,720	0,518	0,514	0,99203

Nota: Elaboración Propia.

De la información del resumen del modelo de regresión lineal simple se infiere que la HCEU explica el 51.8% de la variabilidad en la dimensión Organización de Gestión de la Calidad, lo que sugiere una relación significativa entre ambas variables.

Tabla 23: *Análisis de varianza del modelo de regresión lineal simple utilizando el software SPSS. Variable Independiente y la dimensión Organización de la Variable Dependiente*.

ANOVA					
	Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	Sig.
Regresión	150,004	1	150,004	152,423	0,000
Residuo	139,746	142	0,984		
Total	289,750	143			

Nota: Elaboración Propia.

El análisis ANOVA muestra que la HCEU tiene una influencia significativa en la dimensión Organización de Gestión de la Calidad, con un valor de F de 152.423 y un nivel de

significancia de 0,000 ($p < 0.001$). Este resultado indica que es muy poco probable que la relación observada entre la HCEU y la dimensión Organización de Gestión de la Calidad sea producto del azar, lo que respalda la existencia de una relación estadísticamente significativa entre estas variables.

Tabla 24: *Análisis de coeficientes del modelo de regresión lineal simple utilizando el software SPSS. Variable Independiente y la dimensión Organización de la Variable Dependiente*.

Coeficientes					
	Coeficientes no estandarizados		Coeficientes estandarizados		
	B	Desv. Error	Beta	t	Sig.
Constante	4,687	0,323		14,515	0,000
X = HCEU	0,135	0,011	0,720	12,346	0,000

Nota: Elaboración Propia.

Finalmente, el análisis de los coeficientes de la regresión lineal revela que la variable independiente, HCEU, tiene un coeficiente B de 0,135, lo que indica que por cada unidad adicional en la HCEU, se espera un aumento de 0,135 unidades en la dimensión Organización de Gestión de la Calidad. Este efecto positivo y significativo se refleja en un valor t de 12,346 con una significancia estadística de 0,000 ($p < 0,001$), lo cual confirma que la HCEU es un predictor sólido y relevante para la dimensión Organización de Gestión de la Calidad. La constante B de 4,687 sugiere que, incluso en ausencia de la HCEU, la dimensión Organización de Gestión de la calidad mantendría un valor base positivo.

La ecuación de la recta del modelo de regresión lineal simple tiene la siguiente forma:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 * X$$

Donde:

β_0 = 4,687

β_1 = 0,135

Así, la ecuación del modelo de regresión lineal para las variables HCEU (independiente) y la dimensión Organización de Gestión de la Calidad (dependiente) es:

$$Y = 4{,}687 + 0{,}135 * X$$

c) Hipótesis Específica 3.

La Historia Clínica Electrónica Única tiene una influencia positiva y significativa en la garantía y mejoramiento de los servicios de un hospital de EsSalud, 2024.

Se llevaron a cabo las siguientes etapas para la realización de la prueba del coeficiente de correlación Rho de Spearman:

Paso 1: Formulación de las hipótesis nula (H_0) y alternativa (H_1).

H_0: La Historia Clínica Electrónica Única no tiene una influencia positiva y significativa en la garantía y mejoramiento de los servicios de un hospital de EsSalud, 2024.

H_1: La Historia Clínica Electrónica Única tiene una influencia positiva y significativa en la garantía y mejoramiento de los servicios de un hospital de EsSalud, 2024.

Paso 2: Nivel de significancia.

Se empleó un nivel de significancia (alfa) $\alpha = 5\%$ y un nivel de confianza del 95%.

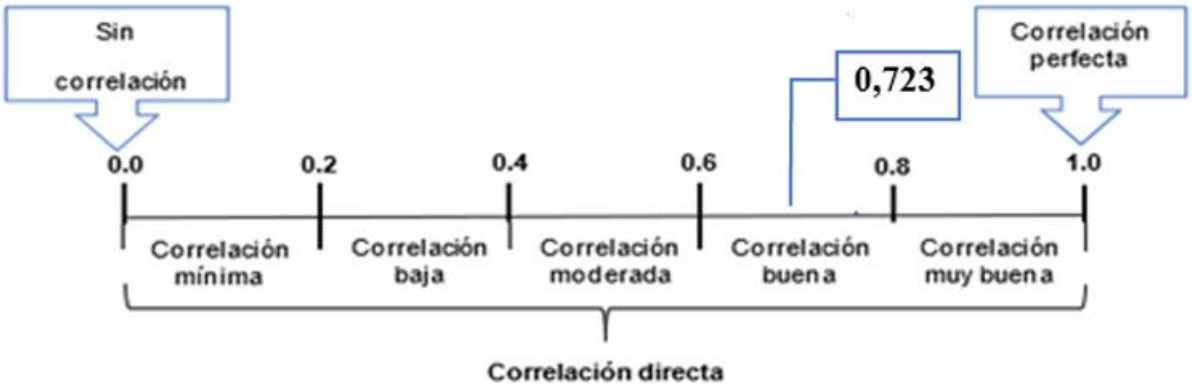
Paso 3: Estadístico de prueba.

Se aplicó el estadístico de prueba no paramétrico y se calculó la correlación de Rho de Spearman.

Paso 4: Formulación de la Regla de Decisión.

H_0: $p >= 0.05$ (No existe correlación).

H_1: $p < 0.05$ (Existe correlación).



Paso 5: Determinación de la correlación de Rho de Spearman utilizando el software SPSS.

Tabla 25: *Determinación de la correlación de Rho de Spearman utilizando el software SPSS. Variable Independiente y Dimensión Garantía y Mejoramiento de los Servicios de la Variable Dependiente*.

	Correlación		X = HCEU	Y = Garantía y Mejoramiento de los Servicios
Rho de Spearman	X = HCEU	Coeficiente de correlación	1,000	0,723
		Sig. (bilateral)	.	0,000
		N	144	144
	Y = Garantía y Mejoramiento de los Servicios	Coeficiente de correlación	0,723	1,000
		Sig. (bilateral)	0,000	.
		N	144	144

Nota: Elaboración Propia.

Paso 6: Proceso de toma de decisión.

En este análisis, se observa que el nivel de significancia asintótica bilateral asociado al estadístico de Rho de Spearman es p=0,000, un valor inferior a p=0,050. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula. Se infiere que la Historia Clínica Electrónica Única tiene una influencia positiva y significativa en la garantía y mejoramiento de los servicios de un hospital de EsSalud, 2024.

Asimismo, según la escala de interpretación de la correlación de Rho de Spearman, el valor obtenido de Rho=0,723 se sitúa dentro del intervalo de 0,6 a 0,8, lo cual indica una buena correlación positiva entre la variable Historia Clínica Electrónica Única y la dimensión Garantía y Mejoramiento de los Servicios de la variable Gestión de la Calidad.

El análisis de Regresión Lineal arrojó los siguientes resultados:

Tabla 26: *Resumen del modelo de regresión lineal simple utilizando el software SPSS. Variable Independiente y dimensión Garantía y Mejoramiento de los Servicios de la Variable Dependiente*.

R	R cuadrado	R cuadrado ajustado	Error estándar de la estimación
0,720	0,518	0,514	0,99203

Nota: Elaboración Propia.

De la información del resumen del modelo de regresión lineal simple se infiere que la HCEU explica el 51.8% de la variabilidad en la dimensión Garantía y Mejoramiento de los Servicios de Gestión de la Calidad, lo que sugiere una relación significativa entre ambas variables.

Tabla 27: *Análisis de varianza del modelo de regresión lineal simple utilizando el software SPSS. Variable Independiente y la dimensión Garantía y Mejoramiento de los Servicios de la Variable Dependiente*

ANOVA					
	Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	Sig.
Regresión	150,004	1	150,004	152,423	0,000
Residuo	139,746	142	0,984		
Total	289,750	143			

Nota: Elaboración Propia.

El análisis ANOVA muestra que la HCEU tiene un efecto significativo en la dimensión Garantía y Mejoramiento de los Servicios de Gestión de la Calidad, con un valor de F de 152.423 y un nivel de significancia de 0,000 ($p < 0.001$). Este resultado indica que es muy poco probable que la relación observada entre la HCEU y la dimensión Garantía y Mejoramiento de los Servicios de Gestión de la Calidad sea producto del azar, lo que respalda la existencia de una relación estadísticamente significativa entre estas variables.

Tabla 28: *Análisis de coeficientes del modelo de regresión lineal simple utilizando el software SPSS. Variable Independiente y la dimensión Garantía y Mejoramiento de los Servicios de la Variable Dependiente.*

Coeficientes					
	Coeficientes no estandarizados		Coeficientes estandarizados		
	B	Desv. Error	Beta	t	Sig.
Constante	4,687	0,323		14,515	0,000
X = HCEU	0,135	0,011	0,720	12,346	0,000

Nota: Elaboración Propia.

Finalmente, el análisis de los coeficientes de la regresión lineal revela que la variable independiente, HCEU, tiene un coeficiente B de 0,135, lo que indica que por cada unidad adicional en la HCEU, se espera un aumento de 0,135 unidades en la dimensión Garantía y Mejoramiento de los Servicios de Gestión de la Calidad. Este efecto positivo y significativo se refleja en un valor t de 12,346 con una significancia estadística de 0,000 ($p < 0,001$), lo cual confirma que la HCEU es un predictor sólido y relevante para la dimensión Garantía y Mejoramiento de los Servicios de Gestión de la Calidad. La constante B de 4,687 sugiere que, incluso en ausencia de la HCEU, la dimensión Garantía y Mejoramiento de los Servicios de Gestión de la calidad mantendría un valor base positivo.

La ecuación de la recta del modelo de regresión lineal simple tiene la siguiente forma:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 * X$$

Donde:

β_0 = 4,687

β_1 = 0,135

Así, la ecuación del modelo de regresión lineal para las variables HCEU (independiente) y la dimensión Garantía y Mejoramiento de los Servicios de Gestión de la Calidad (dependiente) es:

$$Y = 4{,}687 + 0{,}135 * X$$

d) Hipótesis Específica 4.

La Historia Clínica Electrónica Única tiene una influencia positiva y significativa en la idoneidad de la información de un hospital de EsSalud, 2024.

Se llevaron a cabo las siguientes etapas para la realización de la prueba del coeficiente de correlación Rho de Spearman:

Paso 1: Formulación de las hipótesis nula (H_0) y alternativa (H_1).

H_0: La Historia Clínica Electrónica Única no tiene una influencia positiva y significativa en la idoneidad de la información de un hospital de EsSalud, 2024.

H_1: La Historia Clínica Electrónica Única tiene una influencia positiva y significativa en la idoneidad de la información de un hospital de EsSalud, 2024.

Paso 2: Nivel de significancia.

Se empleó un nivel de significancia (alfa) $\alpha = 5\%$ y un nivel de confianza del 95%.

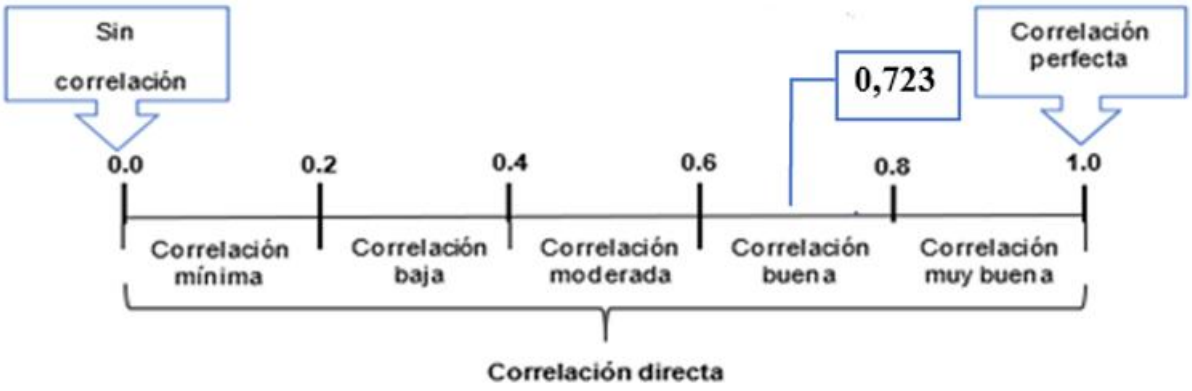
Paso 3: Estadístico de prueba.

Se aplicó el estadístico de prueba no paramétrico y se calculó la correlación de Rho de Spearman.

Paso 4: Formulación de la Regla de Decisión.

H_0: $p >= 0.05$ (No existe correlación).

H_1: $p < 0.05$ (Existe correlación).



Paso 5: Determinación de la correlación de Rho de Spearman utilizando el software SPSS.

Tabla 29: *Determinación de la correlación de Rho de Spearman utilizando el software SPSS. Variable Independiente y Dimensión Idoneidad de la Información de la Variable Dependiente*.

	Correlación		X = HCEU	Y = idoneidad de la información
Rho de Spearman	X = HCEU	Coeficiente de correlación	1,000	0,723
		Sig. (bilateral)	.	0,000
		N	144	144
	Y = idoneidad de la información	Coeficiente de correlación	0,723	1,000
		Sig. (bilateral)	0,000	.
		N	144	144

Nota: Elaboración Propia.

Paso 6: Proceso de toma de decisión.

En este análisis, se observa que el nivel de significancia asintótica bilateral asociado al estadístico de Rho de Spearman es p=0,000, un valor inferior a p=0,050. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula. Se infiere que la Historia Clínica Electrónica Única tiene una influencia positiva y significativa en la idoneidad de la información de un hospital de EsSalud, 2024.

Asimismo, según la escala de interpretación de la correlación de Rho de Spearman, el valor obtenido de Rho=0,723 se sitúa dentro del intervalo de 0,6 a 0,8, lo cual indica una buena correlación positiva entre la variable Historia Clínica Electrónica Única y la dimensión Idoneidad de la Información de la variable Gestión de la Calidad.

El análisis de Regresión Lineal arrojó los siguientes resultados:

Tabla 30: *Resumen del modelo de regresión lineal simple utilizando el software SPSS. Variable Independiente y dimensión Idoneidad de la Información de la Variable Dependiente*.

R	R cuadrado	R cuadrado ajustado	Error estándar de la estimación
0,720	0,518	0,514	0,99203

Nota: Elaboración Propia.

De la información del resumen del modelo de regresión lineal simple se infiere que la HCEU explica el 51.8% de la variabilidad en la dimensión Idoneidad de la Información de Gestión de la Calidad, lo que sugiere una relación significativa entre ambas variables.

Tabla 31: *Análisis de varianza del modelo de regresión lineal simple utilizando el software SPSS. Variable Independiente y la dimensión Idoneidad de la Información de la Variable Dependiente*.

ANOVA					
	Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	Sig.
Regresión	150,004	1	150,004	152,423	0,000
Residuo	139,746	142	0,984		
Total	289,750	143			

Nota: Elaboración Propia.

El análisis ANOVA muestra que la HCEU tiene una influencia significativa en la dimensión Idoneidad de la Información de Gestión de la Calidad, con un valor de F de 152.423 y un nivel de significancia de 0,000 ($p < 0.001$). Este resultado indica que es muy poco probable que la relación observada entre la HCEU y la dimensión Idoneidad de la Información de Gestión de la Calidad sea producto del azar, lo que respalda la existencia de una relación estadísticamente significativa entre estas variables.

Tabla 32: *Análisis de coeficientes del modelo de regresión lineal simple utilizando el software SPSS. Variable Independiente y la dimensión Idoneidad de la Información de la Variable Dependiente.*

Coeficientes					
	Coeficientes no estandarizados		Coeficientes estandarizados		
	B	Desv. Error	Beta	t	Sig.
Constante	4,687	0,323		14,515	0,000
X = HCEU	0,135	0,011	0,720	12,346	0,000

Nota: Elaboración Propia.

Finalmente, el análisis de los coeficientes de la regresión lineal revela que la variable independiente, HCEU, tiene un coeficiente B de 0,135, lo que indica que por cada unidad adicional en la HCEU, se espera un aumento de 0,135 unidades en la dimensión Idoneidad de la Información de Gestión de la Calidad. Este efecto positivo y significativo se refleja en un valor t de 12,346 con una significancia estadística de 0,000 ($p < 0,001$), lo cual confirma que la HCEU es un predictor sólido y relevante para la dimensión Idoneidad de la Información de Gestión de la Calidad. La constante B de 4,687 sugiere que, incluso en ausencia de la HCEU, la dimensión Idoneidad de la Información de Gestión de la calidad mantendría un valor base positivo.

La ecuación de la recta del modelo de regresión lineal simple tiene la siguiente forma:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 * X$$

Donde:

β_0 = 4,687

β_1 = 0,135

Así, la ecuación del modelo de regresión lineal para las variables HCEU (independiente) y la dimensión Idoneidad de la Información de Gestión de la Calidad (dependiente) es:

$$Y = 4{,}687 + 0{,}135 * X$$

CAPITULO V: DISCUSIÓN

En este capítulo, se analizó, comparó e interpretó los resultados obtenidos en relación con las bases teóricas previamente establecidas, los criterios del investigador y los aportes de otros autores citados en el marco teórico y los antecedentes de la investigación. Se puso especial énfasis en los aspectos novedosos del estudio, destacando la Historia Clínica Electrónica Única (HCEU) en EsSalud como una herramienta clave en la gestión de la calidad en la atención médica. A lo largo de esta discusión, se evitó la repetición de datos presentados en los capítulos anteriores, enfocándose en la interpretación y valoración crítica de los hallazgos. Además, se examinó la calidad de los resultados, comparando estos con investigaciones previas que abordaron los mismos constructos, para identificar similitudes y diferencias. Asimismo, se discutieron las hipótesis, el muestreo, las técnicas estadísticas empleadas, y los valores de los indicadores de ajuste, aportando una visión integral de la relevancia y validez de los resultados obtenidos en este estudio.

5.1.Proposición del objetivo

El objetivo principal de esta investigación fue analizar de manera detallada la influencia de la Historia Clínica Electrónica Única (HCEU) en la gestión de la calidad de los servicios de salud de un hospital de EsSalud. Este objetivo se fundamentó en la necesidad crítica de modernizar los sistemas de información en salud, especialmente en el contexto de la atención médica peruana, donde los desafíos en la gestión de datos clínicos y la planificación estratégica han afectado la eficiencia y la calidad del servicio. La HCEU se presentó como una solución integral que centralizó la información clínica, facilitando un

acceso rápido y seguro a los registros médicos, lo que impactó directamente en la toma de decisiones y la satisfacción del personal médico y administrativo.

Este objetivo no solo guió el desarrollo de las fases de la investigación, sino que también permitió evaluar de manera rigurosa cómo la HCEU influyó en dimensiones clave de la gestión de la calidad: la planificación, organización, garantía y mejoramiento de los servicios, así como la idoneidad de la información. A partir de estos elementos, se plantearon objetivos específicos que desglosaron y analizaron las implicaciones prácticas y teóricas de la HCEU, tales como la mejora en la coordinación interdepartamental, la optimización de los procesos clínicos y administrativos, y la reducción de errores en el manejo de la información.

Este estudio no solo proporcionó una base empírica para futuros desarrollos en el ámbito de la salud digital en Perú, sino que también contribuyó al cuerpo teórico existente, examinando cómo la HCEU fue un pilar fundamental en la transformación digital del sector salud. Al abordar las brechas identificadas en investigaciones previas, esta investigación ofreció una contribución significativa al campo, proporcionando evidencia robusta sobre los beneficios y desafíos de la HCEU y proponiendo recomendaciones basadas en los hallazgos.

5.2. Validez interna y externa

La validez interna de esta investigación se garantizó mediante el uso de procedimientos rigurosos y coherentes que permitieron asegurar que los resultados fueran precisos y sólidos dentro del contexto específico de EsSalud. Los instrumentos de recolección de datos, que incluían cuestionarios validados, fueron sometidos a una evaluación exhaustiva por expertos en gestión de la calidad y sistemas de información en salud. Además, se realizó una prueba piloto con una muestra representativa para ajustar los ítems y mejorar la fiabilidad de los instrumentos. Los análisis estadísticos empleados, como la regresión lineal y la correlación de Rho de Spearman, fueron adecuados para evaluar las relaciones entre las

variables y contrastar las hipótesis planteadas, lo que permitió que las conclusiones obtenidas fueran consistentes con los objetivos de la investigación. Estos métodos aseguraron que la relación entre la HCEU y la gestión de la calidad fuera evaluada con precisión. Asimismo, se controlaron posibles fuentes de sesgo mediante la correcta operacionalización de las variables y la utilización de técnicas estadísticas apropiadas, lo que contribuyó a una interpretación confiable de los resultados.

En lo que respecta a la validez externa, los resultados de esta investigación tienen un alto potencial de generalización a otros entornos de salud, tanto dentro como fuera de Perú. La representatividad de la muestra, que abarcó personal administrativo y clínico de EsSalud involucrado en diversas áreas clave de la gestión de la calidad, fortalece la aplicabilidad de los hallazgos en instituciones que operan bajo contextos similares. Aunque EsSalud tiene características propias, los resultados obtenidos en este estudio pueden ser relevantes para otros sistemas de salud que enfrenten desafíos similares en cuanto a la digitalización y modernización de sus procesos clínicos y administrativos.

Los beneficios observados en el funcionamiento de la HCEU, como la mejora en la planificación, la organización y la garantía de la calidad de los servicios, pueden replicarse en otros entornos que busquen optimizar la gestión de la información clínica a través de sistemas electrónicos. Además, la capacidad de la HCEU para mejorar la eficiencia operativa, reducir errores y facilitar el acceso rápido a la información médica sugiere que estas mejoras pueden ser extrapoladas a otras instituciones que enfrenten desafíos en la integración de tecnologías de información en salud. Este estudio ofrece una base empírica sólida que puede servir de referencia para evaluar el impacto de la HCEU en distintos sistemas de salud, contribuyendo al avance de la digitalización en la atención médica.

A medida que más instituciones, tanto nacionales como internacionales, adopten tecnologías de información en salud, los resultados de esta investigación pueden ofrecer un

marco conceptual y práctico para implementar sistemas de registros clínicos electrónicos con éxito. Si bien cada entorno puede tener particularidades, las lecciones aprendidas en EsSalud son transferibles a instituciones que compartan el objetivo de mejorar la calidad de la atención a través de la digitalización. Esto respalda la validez externa de los hallazgos y su relevancia para futuros estudios e implementaciones en diferentes contextos.

En conclusión, la validez interna y externa de esta investigación se sustenta en la solidez de los procedimientos metodológicos empleados y en la relevancia de los hallazgos para otros contextos más allá de EsSalud. El estudio no solo proporciona resultados confiables dentro del contexto estudiado, sino que también ofrece un marco aplicable para instituciones que busquen mejorar la gestión de la calidad mediante la digitalización de la información clínica.

5.3. Implicancias teóricas y prácticas

Las implicancias teóricas y prácticas derivadas de esta investigación ofrecen aportes significativos tanto para el campo académico como para la aplicación práctica en instituciones de salud. Los resultados obtenidos permiten reflexionar sobre las teorías existentes en torno a la gestión de calidad y la digitalización en el ámbito sanitario, al tiempo que ofrecen recomendaciones concretas para mejorar el funcionamiento de sistemas de información clínica como la Historia Clínica Electrónica Única (HCEU).

En lo que respecta a las implicancias teóricas, esta investigación contribuyó al avance del conocimiento al confirmar y ampliar las teorías existentes sobre la transformación digital en los sistemas de salud. Los hallazgos respaldaron los postulados teóricos que sostienen que el uso de tecnologías de información, como la HCEU, facilita la mejora en la coordinación de procesos, la calidad de los datos y la eficiencia operativa. Este estudio refuerza las teorías de

la calidad total (TQM) aplicadas a la gestión de salud, al demostrar que la HCEU facilita la toma de decisiones basada en datos precisos y accesibles, lo que impacta positivamente en la planificación estratégica y en los resultados clínicos. Además, se amplió el marco teórico de la gestión de la información clínica al destacar que la HCEU no solo mejora la recopilación y almacenamiento de datos, sino que también contribuye a reducir los errores humanos y administrativos, lo que se alinea con estudios previos sobre la calidad de los datos en la atención médica (Wang, 1996).

Este estudio también resalta la importancia de una infraestructura tecnológica adecuada y un enfoque integral en la capacitación del personal, aspectos que ya habían sido discutidos en teorías sobre la adopción de tecnologías en salud (Torres, 2020; Tuanama, 2019). La investigación refuerza estas teorías al proporcionar evidencia empírica sobre cómo la falta de capacitación o infraestructura puede limitar los beneficios de la tecnología. Además, se introduce un nuevo enfoque al examinar el impacto de la HCEU en la percepción del personal médico y administrativo, lo cual añade una dimensión humana a las discusiones teóricas sobre la digitalización de la salud.

Desde el punto de vista de las implicancias prácticas, esta investigación ofrece una serie de recomendaciones valiosas para la adopción de la HCEU en otros contextos. En primer lugar, los resultados enfatizan la necesidad de una adopción planificada y estructurada, en la que el soporte técnico, la infraestructura tecnológica y la capacitación continua jueguen un rol crucial para maximizar los beneficios de la tecnología. En este sentido, se recomienda que las instituciones de salud que estén considerando la adopción de la HCEU desarrollen programas de capacitación específicos para el personal médico y administrativo, a fin de reducir la resistencia al cambio y aumentar la efectividad en el uso de los sistemas electrónicos.

Asimismo, la investigación sugiere que la HCEU puede integrarse de manera efectiva con otros sistemas de información existentes, facilitando la interoperabilidad y mejorando el acceso a la información clínica en tiempo real. Esta integración no solo optimizaría los procesos operativos y la planificación dentro de las instituciones de salud, sino que también contribuiría a una mejor gestión de los recursos, permitiendo que los profesionales de salud se concentren en la atención al paciente en lugar de en tareas administrativas.

Un hallazgo clave con implicancias prácticas es el impacto positivo que la HCEU puede tener en la satisfacción del paciente. Los resultados indicaron que la disponibilidad de información médica precisa y accesible contribuye a una atención más rápida y efectiva, lo que se traduce en una mejora de la calidad del servicio percibida por los usuarios. En consecuencia, las instituciones de salud que implementen la HCEU pueden esperar una mejora en los indicadores de satisfacción de los pacientes, lo que podría tener un efecto positivo en la imagen institucional y en la relación con los usuarios.

Finalmente, este estudio ofrece un marco práctico para la planificación y ejecución de proyectos de digitalización en el ámbito de la salud. Los tomadores de decisiones y gestores de instituciones de salud pueden utilizar los resultados de esta investigación para diseñar políticas que faciliten la adopción de tecnologías de información, con el fin de mejorar la calidad de la atención y la eficiencia de los procesos clínicos y administrativos. La investigación sugiere que un funcionamiento exitoso de la HCEU requiere no solo de la adopción de tecnología, sino también de un compromiso institucional para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

En conclusión, esta investigación no solo ofrece un aporte significativo al marco teórico existente sobre la digitalización en la salud, sino que también proporciona un conjunto de recomendaciones prácticas que pueden ser aplicadas en diversos entornos de salud para mejorar la calidad de la atención y la eficiencia operativa. Las implicancias teóricas y

prácticas de este estudio subrayan la importancia de una planificación cuidadosa, el fortalecimiento de las capacidades del personal y el desarrollo de infraestructuras tecnológicas adecuadas para garantizar el éxito de la HCEU en cualquier contexto.

5.4. Comparación de los resultados

Los resultados obtenidos en esta investigación fueron comparados con estudios previos sobre el funcionamiento de sistemas de Historia Clínica Electrónica (HCE) en diversas instituciones de salud, lo que permitió identificar importantes similitudes, pero también algunas diferencias que subrayaron factores contextuales y metodológicos. En términos generales, los hallazgos coinciden con la literatura existente, particularmente en lo que respecta a los beneficios de la digitalización de la información clínica y su impacto positivo en la calidad del servicio.

En el estudio de Fernández et al. (2021), se reportó que la HCE permitió mejoras en la accesibilidad a los registros médicos y en la eficiencia operativa de los servicios de salud. Estas mejoras coincidieron con los hallazgos obtenidos en EsSalud, donde la HCEU facilitó una reducción significativa en los tiempos de espera para la obtención de información clínica, optimizando tanto el flujo de trabajo administrativo como médico. Asimismo, Condori y Rivera (2021) señalaron que la adopción de la HCE en hospitales de su estudio resultó en una mayor organización y precisión en los datos clínicos, un beneficio que también se evidenció en EsSalud.

En términos de satisfacción del paciente, los resultados de EsSalud fueron consistentes con los reportados por López y Cárdenas (2020), quienes observaron una mejora en la satisfacción de los pacientes como consecuencia de una mayor accesibilidad y

confiabilidad de los datos médicos. En EsSalud, la HCEU no solo mejoró el acceso a la información, sino que también redujo significativamente los errores en la gestión de los datos clínicos, lo que tuvo un impacto positivo en la percepción de la calidad del servicio.

Sin embargo, también se observaron algunas diferencias. En el estudio de Gutiérrez (2021), se encontró que la resistencia al cambio por parte del personal fue uno de los principales desafíos durante la adopción de la HCE en el Hospital Hermilio Valdizán, lo que contrasta con los resultados obtenidos en EsSalud, donde la resistencia fue significativamente menor. Este contraste podría explicarse por las estrategias adoptadas por EsSalud, que incluyeron un programa integral de capacitación continua y soporte técnico constante, lo que facilitó una transición más fluida hacia el uso de la HCEU. Por otro lado, en el estudio de Gutiérrez, la falta de una preparación adecuada del personal fue identificada como una de las principales causas de la resistencia, lo que subraya la importancia de una planificación cuidadosa en la adopción de tecnologías de la información en salud.

Un aspecto clave donde se encontraron diferencias fue la interoperabilidad de la HCE con otros sistemas de información. Torres (2020) y Ramírez et al. (2019) reportaron dificultades considerables en la integración de la HCE con los sistemas preexistentes en sus estudios, lo que limitó los beneficios de la digitalización. Sin embargo, en EsSalud, se observó una mayor eficiencia en la interoperabilidad de la HCEU, lo que se atribuyó a la inversión previa en infraestructura tecnológica y a la planificación cuidadosa de la integración de los sistemas. Esto destaca la importancia de contar con un entorno tecnológico robusto antes de la adopción de sistemas electrónicos, ya que una preparación adecuada puede maximizar los beneficios de la digitalización.

Además, estudios como el de Morejón y González (2022) resaltaron cómo la HCE permitió una mayor fidelidad y calidad en la gestión de la información clínica, mejorando la toma de decisiones médicas y operativas. En EsSalud, estos beneficios también fueron

observados, ya que la HCEU permitió una mayor precisión y rapidez en la recuperación de la información, lo que se tradujo en un mejor manejo de los pacientes y una optimización de los recursos clínicos. Este estudio también es consistente con el de Berastain et al. (2022), quienes afirmaron que la HCE contribuyó a una mejora en la planificación estratégica y en la toma de decisiones en el ámbito de la salud.

Otro hallazgo importante fue la escala de implementación y su impacto en los resultados. En estudios como los de Pérez y Morales (2020), se observó que en contextos más pequeños, la implementación de la HCE no siempre conllevó los mismos beneficios debido a la limitada escala de adopción. En contraste, en EsSalud, la implementación fue más amplia y abarcó diversas áreas funcionales, lo que permitió una percepción más generalizada de los beneficios, tanto por parte del personal médico como de los pacientes. Esta diferencia en la escala de implementación resalta la importancia de una adopción integral para maximizar los resultados positivos.

Finalmente, los estudios revisados mostraron que, aunque muchos de los beneficios de la HCEU observados en EsSalud coinciden con los hallazgos de investigaciones previas, las diferencias en la preparación tecnológica, la capacitación del personal y el apoyo institucional pueden explicar las variaciones en los resultados. Estudios como los de Vargas et al. (2018) indicaron que la falta de recursos financieros fue un obstáculo considerable en algunas instituciones, mientras que en EsSalud, la HCEU fue respaldada por una estrategia integral de modernización tecnológica y un sólido apoyo financiero, lo que facilitó un despliegue más exitoso.

En conclusión, los resultados de este estudio confirmaron gran parte de los beneficios reportados en la literatura sobre la adopción de la HCE, pero también revelaron diferencias importantes que subrayan la importancia de factores contextuales como la infraestructura tecnológica, la capacitación del personal y el apoyo institucional. Estas comparaciones no

solo permitieron validar los hallazgos obtenidos en EsSalud, sino que también ofrecieron nuevas perspectivas sobre las condiciones que pueden favorecer o limitar el éxito de la HCE en diferentes contextos, abriendo el camino a futuras investigaciones sobre la digitalización en el sector salud.

5.5. Conclusión sobre los antecedentes

A partir de la revisión de la literatura previa, se han identificado múltiples estudios que abordan la adopción de sistemas de Historia Clínica Electrónica (HCE) en entornos de salud a nivel internacional y nacional. Los hallazgos previos destacaron los beneficios de la digitalización de los registros médicos, tales como la mejora en la accesibilidad de la información, la precisión de los datos clínicos y una mayor eficiencia en los procesos administrativos y clínicos. Investigaciones como las de Bastias-Butler y Ulrich (2019) resaltaron que la digitalización de los registros clínicos contribuyó significativamente a optimizar la toma de decisiones clínicas, además de reducir los tiempos de espera para los pacientes. Asimismo, estudios como los de Berastain et al. (2022) evidenciaron que la adopción de la HCE mejoró la capacidad de los sistemas de salud para gestionar eficientemente los recursos, gracias a la automatización y centralización de la información médica.

Sin embargo, a pesar de los avances reportados en el uso de la HCE, la revisión de los estudios también reveló desafíos recurrentes. Chá (2020) y Condori y Rivera (2021) señalaron que, aunque los beneficios de la digitalización son claros, la infraestructura tecnológica y la resistencia al cambio por parte del personal médico y administrativo han sido obstáculos clave para el funcionamiento exitoso. La falta de recursos adecuados, tanto financieros como técnicos, afectó el funcionamiento y la sostenibilidad de los sistemas

electrónicos en diversas instituciones de salud, lo que dejó un vacío crítico en la literatura sobre cómo superar estas barreras para maximizar los beneficios de la HCE en diferentes contextos.

Además, si bien las investigaciones han examinado principalmente los aspectos técnicos y operativos de la HCE, se identificó un vacío importante en cuanto a estudios que exploren su impacto integral en la gestión de la calidad en los servicios de salud. A pesar de que Fernández et al. (2021) y Morejón y González (2022) mencionaron que la HCE permitió mejoras en la calidad de la atención en algunos entornos de salud, los estudios no profundizaron en cómo estos sistemas pueden contribuir a optimizar los procesos de gestión de calidad, particularmente en el contexto de instituciones de salud en Perú. Este vacío de conocimiento justificó la necesidad de llevar a cabo una investigación que evaluara el impacto directo de la HCE en la gestión de la calidad en un contexto institucional específico.

La investigación actual se enfocó en llenar este vacío, proporcionando una evaluación detallada de cómo la HCE en EsSalud influyó en la mejora de la gestión de la calidad. Aunque los estudios previos proporcionaron valiosos marcos teóricos y conceptuales sobre los beneficios de la HCE, existía una falta de evidencia empírica sobre su impacto a nivel organizacional en la gestión de calidad en el sistema de salud peruano. Al centrarse en los beneficios y los desafíos específicos que surgieron en EsSalud, este estudio no solo buscó confirmar los hallazgos de la literatura existente, sino también ampliar el conocimiento al ofrecer recomendaciones concretas para mejorar la adopción y el uso efectivo de la HCE en instituciones similares.

En conclusión, la revisión de los antecedentes destacó tanto los logros como los retos enfrentados por instituciones de salud en la adopción de la HCE. Aunque los beneficios en términos de eficiencia y accesibilidad de la información fueron ampliamente documentados, se identificaron vacíos importantes en cuanto al impacto directo de estos sistemas en la

gestión de la calidad. Esta investigación, al abordar esos vacíos, contribuyó a ofrecer una comprensión más profunda de los factores clave que pueden favorecer o limitar el éxito de la HCE, proporcionando evidencia empírica sobre su funcionamiento en EsSalud y sus implicancias para la mejora de la calidad en los servicios de salud. Los hallazgos de este estudio pueden servir como referencia para futuras investigaciones y como base para el desarrollo de estrategias que optimicen el uso de tecnologías de información en la gestión de calidad en el sector salud.

CAPITULO VI: CONCLUSIONES

En este capítulo se presentan las conclusiones derivadas de los resultados obtenidos en la investigación, cuyo objetivo fue evaluar la influencia de la Historia Clínica Electrónica Única (HCEU) en la gestión de la calidad de un hospital de EsSalud durante el año 2024. Estas conclusiones responden de manera directa a los problemas, objetivos e hipótesis planteados, tanto generales como específicos, basándose en el análisis detallado y la discusión de los datos recolectados.

El proceso de investigación permitió identificar la influencia positiva y significativa de la HCEU en dimensiones clave de la gestión sanitaria, como la planificación, la organización, la garantía y mejoramiento de los servicios, y la idoneidad de la información. A partir de los resultados obtenidos y su interpretación, se presentan reflexiones concretas que contribuyen al conocimiento sobre la digitalización de los sistemas de salud y su papel en la mejora de la gestión de la calidad en EsSalud. De este modo, las conclusiones están alineadas con los objetivos de la investigación y se derivan exclusivamente de los hallazgos empíricos, sin caer en la repetición o el resumen de los mismos.

1. Impacto en la gestión de la calidad

La Historia Clínica Electrónica Única (HCEU) ha demostrado una influencia positiva y significativa en la gestión de la calidad en EsSalud, confirmando la hipótesis general y el cumplimiento del objetivo general de la investigación. Su adopción ha facilitado la centralización de la información clínica, permitiendo un acceso más rápido y confiable a los datos por parte de los profesionales de la salud. Esto ha mejorado significativamente la toma de decisiones clínicas y administrativas, ya que los responsables pueden contar con información completa y actualizada en tiempo real, lo cual optimiza los procesos operativos. Al mismo tiempo, se ha logrado una mayor eficiencia en el uso de los recursos al reducir la

duplicación de exámenes médicos y tratamientos, evitando errores comunes que se generaban por la falta de integración en los registros manuales.

El análisis estadístico reveló que la HCEU tiene una correlación significativa con la mejora en la calidad de los servicios de salud, lo que ha redundado en un aumento en la satisfacción tanto del personal de salud como de los pacientes. Además, el acceso rápido a los historiales clínicos ha facilitado la continuidad en los tratamientos, contribuyendo a una mayor coherencia en la atención médica. Estas mejoras responden al problema general planteado en la investigación, que se centraba en evaluar el efecto de la HCEU sobre la calidad de la gestión en EsSalud, y confirman que la digitalización de los registros médicos no solo optimiza los procesos, sino que también eleva los estándares de calidad en la atención de los pacientes.

2. Mejora en la planificación

En relación con la planificación, la HCEU ha permitido optimizar significativamente los procesos de planificación en EsSalud. Este hallazgo está en línea con el objetivo específico 1 y su respectiva hipótesis, que establecían que la HCEU tendría una influencia positiva en la planificación de los recursos y actividades. La disponibilidad de datos en tiempo real ha sido un factor determinante para mejorar la capacidad de planificación de los gestores de salud, quienes ahora pueden identificar con mayor precisión las necesidades de los diferentes departamentos y unidades.

Gracias a la HCEU, los responsables de la planificación pueden prever con más precisión las demandas asistenciales, lo que ha llevado a una asignación más eficiente de recursos humanos y materiales. Esto ha reducido significativamente los tiempos de espera para los pacientes y ha mejorado la programación de citas y procedimientos, lo que se traduce en una mayor satisfacción del usuario. Además, la adopción de esta herramienta ha facilitado la creación de planes estratégicos que no solo responden a las necesidades operativas

inmediatas, sino que también permiten anticiparse a posibles contingencias o aumentos en la demanda de servicios, especialmente en épocas de alta carga asistencial. La centralización y disponibilidad de la información han sido claves para lograr una planificación más ágil, efectiva y adaptativa, lo que confirma la hipótesis de un impacto positivo en esta dimensión.

3. Optimización de la organización

La HCEU ha tenido una influencia positiva en la organización interna de EsSalud, cumpliendo con el objetivo específico 2 y corroborando la hipótesis planteada. El sistema ha permitido una mayor coordinación entre los distintos departamentos clínicos y administrativos, lo que ha optimizado la estructura organizacional y ha mejorado la comunicación interna. La interoperabilidad entre áreas ha sido uno de los logros más importantes de la HCEU, ya que ha eliminado barreras que tradicionalmente dificultaban la transmisión de información entre los diferentes niveles de atención.

La capacidad de compartir información clínica en tiempo real entre los diversos actores del sistema ha facilitado una mejor asignación de responsabilidades y tareas, reduciendo los errores derivados de la falta de comunicación. Asimismo, la HCEU ha permitido una mayor flexibilidad en la organización del personal de salud, ya que ahora es posible asignar recursos de manera más dinámica, según las necesidades que surjan en tiempo real. Este nuevo esquema organizativo ha mejorado la eficiencia de los procesos y ha permitido una integración más eficaz de los servicios asistenciales, lo que se traduce en una atención más coordinada y eficaz para los pacientes. En conclusión, la HCEU ha facilitado la reorganización interna de EsSalud, optimizando los flujos de trabajo y mejorando la cohesión entre los diferentes departamentos, lo que cumple con el objetivo y la hipótesis sobre su impacto organizacional.

4. Garantía y mejoramiento de los Servicios

La HCEU ha sido un factor clave para mejorar los procesos de garantía y mejoramiento de los servicios en EsSalud, cumpliendo con el objetivo específico 3 y corroborando la hipótesis correspondiente. Una de las principales contribuciones de la HCEU ha sido la posibilidad de monitorear de manera más efectiva el cumplimiento de los estándares de calidad, permitiendo la identificación de áreas de mejora en tiempo real y la implementación de acciones correctivas de forma oportuna. Los resultados obtenidos muestran que la HCEU ha permitido a los responsables de calidad realizar un seguimiento constante de los indicadores clave de desempeño (KPIs), lo que ha redundado en una mayor adherencia a los protocolos clínicos y administrativos.

La HCEU ha fortalecido la capacidad de supervisión y evaluación de los servicios asistenciales, ya que permite detectar de forma más precisa cualquier desviación en los procesos, lo que posibilita la toma de decisiones correctivas de forma ágil y eficiente. Esto ha contribuido a una mayor consistencia en la prestación de los servicios y ha elevado el estándar de calidad en EsSalud. Además, la HCEU ha facilitado la retroalimentación continua entre los distintos niveles del sistema de salud, promoviendo un enfoque de mejora continua basado en datos reales y actualizados. Estos hallazgos confirman la hipótesis de que la HCEU tiene una influencia significativa en la garantía y mejoramiento de los servicios, al fortalecer los mecanismos de control y permitir una intervención más rápida y eficaz en las áreas que lo requieren.

5. Gestión de la información

En cuanto a la gestión de la información, la HCEU ha cumplido con el objetivo específico 4 y ha confirmado la hipótesis de que su adopción mejora la gestión de los datos clínicos y administrativos en EsSalud. La centralización de los datos ha permitido una estandarización de los registros clínicos, lo que ha facilitado la evaluación de los indicadores de calidad y ha permitido una mayor transparencia en la gestión de los mismos. Los

resultados de la investigación indican que la HCEU ha reducido significativamente la duplicación de registros y ha mejorado la precisión en la recopilación y análisis de la información.

La HCEU ha proporcionado a los gestores de salud una herramienta robusta para la toma de decisiones basadas en evidencia, lo que ha fortalecido la capacidad de evaluar el desempeño del sistema de salud en términos de calidad. La disponibilidad de datos confiables y actualizados ha permitido un monitoreo más preciso de los resultados clínicos, lo que ha facilitado la implementación de políticas y procedimientos que contribuyen a la mejora continua de la calidad en EsSalud. Además, la centralización de los datos ha mejorado la rendición de cuentas y ha permitido una mayor transparencia en la gestión de la calidad, lo que ha reforzado la confianza de los usuarios en el sistema de salud. Estos hallazgos confirman la hipótesis de que la HCEU tiene un impacto positivo en la gestión de la información de calidad, lo que a su vez contribuye a una mejora general en la prestación de los servicios de salud.

CAPITULO VII: RECOMENDACIONES

En este capítulo se presentan las recomendaciones basadas en los hallazgos de la investigación sobre la Influencia de la Historia Clínica Electrónica Única (HCEU) en la gestión de la calidad de un hospital de EsSalud. Estas sugerencias están orientadas tanto a la aplicación práctica de los resultados como a la identificación de futuras líneas de investigación que permitan profundizar en aspectos no abordados en este estudio. Las recomendaciones están directamente vinculadas con las conclusiones del capítulo anterior y buscan fortalecer los procesos de planificación, organización, garantía y mejoramiento de los servicios, así como la idoneidad de la información en EsSalud, asegurando que las mejoras propuestas sean viables y sostenibles.

Asimismo, se incluyen sugerencias relacionadas con el proceso de investigación y las técnicas utilizadas, con el objetivo de mejorar el diseño de futuros estudios sobre la digitalización de los sistemas de salud. Las recomendaciones se centran en optimizar el uso y gestión de la HCEU, abarcando aspectos clave como la capacitación del personal, la seguridad de los registros médicos, la infraestructura tecnológica y la coordinación interdisciplinaria. De este modo, se busca promover una adopción efectiva de la HCEU, garantizando servicios de salud de alta calidad en EsSalud y fomentando una mejora continua en la prestación de dichos servicios.

1. Aplicación práctica de la HCEU en la mejora de la gestión de la calidad

A partir de la conclusión general sobre el impacto positivo de la Historia Clínica Electrónica Única (HCEU) en la gestión de la calidad en EsSalud, se recomienda expandir su uso a otras entidades del sistema público y privado de salud en Perú. Dada su capacidad para mejorar la accesibilidad y la disponibilidad de la información clínica, se sugiere que el proceso de implementación sea acompañado de una capacitación continua del personal para

garantizar su adecuado uso. Esta expansión debe ser gestionada por las áreas de tecnología de la información, en colaboración con las unidades de calidad y administrativas, asegurando que se mantengan altos estándares de atención durante el proceso.

Es fundamental establecer un sistema de monitoreo continuo que permita evaluar el impacto de la HCEU en la calidad de los servicios de salud. Este sistema debe incluir indicadores clave como tiempos de atención, satisfacción de los pacientes y adherencia a los protocolos clínicos. La recolección de estos datos permitirá ajustar y mejorar los procesos de implementación en tiempo real, asegurando que los beneficios observados se mantengan a largo plazo.

2. Reforzar la planificación mediante el uso de la HCEU

A partir de la conclusión sobre la mejora en los procesos de planificación facilitada por la HCEU, se recomienda que EsSalud y el Ministerio de Salud desarrollen un plan estratégico nacional que formalice la HCEU como una herramienta central en la planificación de recursos y actividades. Este plan debe integrar la HCEU como un componente esencial para la asignación eficiente de recursos y la programación de actividades operativas y asistenciales, lo que permitirá una respuesta más ágil ante la creciente demanda de servicios.

También se sugiere implementar sistemas de simulación basados en los datos de la HCEU que permitan prever escenarios de alta demanda y ajustar la asignación de recursos de manera proactiva. Esta recomendación es viable dado el acceso a datos en tiempo real que proporciona la HCEU, permitiendo una planificación anticipada y eficiente. La capacitación del personal en el uso de estas herramientas también será crucial para maximizar su efectividad, y los responsables de la planificación deben recibir formación continua en análisis de datos y gestión de la información.

3. Optimización de la organización mediante la interoperabilidad

Derivado de la conclusión sobre el impacto de la HCEU en la mejora de la organización interna de EsSalud, se recomienda fortalecer la interoperabilidad entre los diferentes departamentos y unidades dentro de la institución, así como entre EsSalud y otras entidades públicas y privadas de salud. La integración de los sistemas de información de salud a nivel nacional permitirá una atención más fluida y coordinada, facilitando la continuidad de los tratamientos entre distintos niveles de atención.

Para garantizar la viabilidad de esta recomendación, el Ministerio de Salud debe desarrollar un marco regulatorio que promueva la interoperabilidad entre plataformas de registro médico, asegurando la compatibilidad y la seguridad de los datos. Este marco debe incluir estándares técnicos y protocolos de protección de la privacidad de los pacientes. Asimismo, se debe fomentar una cultura organizacional que favorezca la colaboración interdisciplinaria a través de la implementación de comités de adopción tecnológica y comités interdepartamentales.

4. Fortalecimiento de los sistemas de control de calidad con la HCEU

A partir de la conclusión sobre la mejora en la garantía y el mejoramiento continuo de la calidad, se recomienda desarrollar un sistema de control de calidad basado en los datos generados por la HCEU. Este sistema debe permitir el monitoreo en tiempo real de los indicadores clave de calidad y facilitar la identificación de problemas o desviaciones de los protocolos de manera oportuna. Es necesario que el personal encargado de la calidad reciba formación en el uso y análisis de los datos generados por la HCEU, para que puedan implementar las medidas correctivas adecuadas con rapidez.

Además, se sugiere la creación de un observatorio de calidad de la atención, que sea independiente y esté encargado de monitorear y evaluar el uso de la HCEU para mejorar continuamente los procesos de salud. Este observatorio debe estar compuesto por expertos en

tecnología de la información y gestión de la calidad, quienes pueden ofrecer recomendaciones de mejora basadas en el análisis de los datos y los resultados de la HCEU.

5. Gestión de la información de calidad

En relación con la gestión de la información de calidad, se recomienda fortalecer la infraestructura tecnológica de EsSalud para asegurar que los sistemas de almacenamiento y procesamiento de datos puedan manejar el creciente volumen de información generado por la HCEU. Esto incluye mejorar la capacidad de almacenamiento, implementar sistemas de respaldo de datos y garantizar la seguridad de la información clínica. Para asegurar que los datos sean utilizados de manera óptima, se debe crear un equipo especializado en análisis de datos que colabore con los gestores de calidad para interpretar y utilizar la información en la toma de decisiones.

Asimismo, se sugiere establecer un protocolo de auditoría interna que permita revisar periódicamente la calidad de los datos almacenados en la HCEU, asegurando su precisión e integridad. La creación de este sistema de auditoría debe estar liderada por el departamento de tecnología de la información, en coordinación con las áreas de calidad y administración. Este enfoque garantizará que los registros médicos electrónicos mantengan su fiabilidad y que puedan ser utilizados eficazmente para mejorar la gestión de la calidad en EsSalud.

6. Recomendaciones para futuras investigaciones

Dado que la presente investigación se ha centrado en el impacto de la HCEU en la gestión de la calidad en EsSalud, se recomienda realizar estudios adicionales que evalúen otros aspectos del sistema, como su impacto en la reducción de costos operativos, en la gestión del tiempo del personal médico, y en el manejo de emergencias sanitarias. También se sugiere estudiar el efecto de la HCEU en diferentes niveles de atención dentro del sistema de salud, como la atención primaria y los hospitales especializados, para verificar si los beneficios observados son consistentes en otros contextos.

Además, futuras investigaciones podrían explorar el impacto de variables mediadoras o moderadoras, como el grado de capacitación del personal o la infraestructura tecnológica, para entender mejor los mecanismos a través de los cuales la HCEU influye en la gestión de la calidad. También sería interesante realizar estudios comparativos que evalúen la adopción de la HCEU en distintos sistemas de salud, tanto públicos como privados, y en otros países, para identificar buenas prácticas que puedan ser aplicadas en el contexto peruano.

FUENTES DE INFORMACIÓN

Ander-Egg, E. (1970). Técnicas de planificación: del árbol de problemas a la programación por objetivos. Ediciones Lerner.

Argenti, P. A., & Druckenmiller, B. (2004). Effective Communication: A Challenge to Companies in the Digital Age. McGraw-Hill.

Arias, F. (2016). El proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica (7th ed.). Episteme.

Babbie, E. (2015). The Practice of Social Research (14th ed.). Cengage Learning.

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (2019). Transformación digital del sector salud en América Latina y el Caribe: La historia clínica electrónica. Recuperado de https://publications.iadb.org/es/transformacion-digital-del-sector-salud-en-america-latina-y-el-caribe-la-historia-clinica

Bastias-Butler, E., y Ulrich, A. (2019). Transformación digital del sector salud en América Latina y el Caribe: La historia clínica electrónica. Banco Interamericano de Desarrollo.

Berastain, H. H., Pérez, C. E., y Medina, C. G. (2022). Historia clínica digital única universal en el Perú: del caos al ordenamiento en información médica. Revista Scientific, 7(24), 78-95.

Besterfield, D. H. (2013). Total quality management. Pearson.

Bryman, A. (2016). Social Research Methods (5th ed.). Oxford University Press.

Campbell, D. T., & Stanley, J. C. (2015). Experimental and quasi-experimental designs for research. Ravenio Books.

Cid, C., y Marinho, M. L. (2022). Dos años de pandemia de COVID-19 en América Latina y el Caribe: reflexiones para avanzar hacia sistemas de salud y de protección social universales, integrales, sostenibles y resilientes.

Cipagauta, L. A. A., Urrego, A. X. T., y García, L. A. R. (2023). Sistema de Aseguramiento en Salud en Chile, México y Colombia; Revisión Documental. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 7(5), 8426-8444.

Chá, M. M. (2020). Historia clínica electrónica: factores de resistencia para su uso por parte de los médicos. Revista Médica de Uruguay, 36(2), 163-170. doi: 10.29193/RMU.36.2.6

Chandler, A. D. (2003). Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise. The Belknap Press of Harvard University Press.

Chiavenato, I. (1995). Gerencia de recursos humanos. McGraw-Hill Interamericana

Condori, L. A., y Rivera, Y. E. (2021). Diagnóstico situacional de la implementación del Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas (SIHCE) e-Qhali en el Centro Materno Infantil El Progreso, durante el periodo del 2019 al 2020. [Tesis de maestría, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas].

Corral, Y. (2009). Validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación para la recolección de datos. Revista Ciencias de la Educación, 19(33), 228-247. Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5362681

Corredor, M. R., y Jiménez, H. L. V. (2020). Modelo basado en ingeniería ontológica para la interoperabilidad de historias clínicas electrónicas en las instituciones prestadoras de servicios de salud. Universidad Distrital "Francisco José de Caldas". Colombia.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th ed.). Sage Publications.

Creswell, J. W., & Plano, V. L. (2018). Designing and conducting mixed methods research (3rd ed.). Sage Publications.

Crosby, P. B. (1979). Quality Is Free: The Art of Making Quality Certain. McGraw-Hill.

Daft, R. L. (2017). Organization Theory and Design. Cengage Learning.

David, F. R., & David, F. R. (2019). Strategic Management: Concepts and Cases: Competitiveness and Globalization. Pearson.

Deetz, S. (2017). Communication and Organizational Culture: A Key to Understanding Work Experiences. Routledge.

Deming, W. E. (1986). Out of the Crisis. Massachusetts Institute of Technology, Center for Advanced Engineering Study.

Drucker, P.F. (1954) The Practice of Management. Harper & Row, New York.

Drucker, P. F. (1974). Management: Tasks, Responsibilities, Practices. Harper & Row.

Eaves, D., & Lombardo, L. (2021). 2020 State of Digital Transformation. Cambridge, MA: Harvard Kennedy School.

Entzeridou, E., Markopoulou, E., & Mollaki, V. (2019). Public and physician's expectations and ethical concerns about electronic health record: Benefits outweigh risks except for information security. International Journal of Medical Informatics.

Fayol, H. (1916) General and Industrial Management. Institute of Electrical and Electronics Engineering, Paris.

Fernández, A. L., Agostinelli, M. S., Arias López, M. del P., Urrutia, M. A., y Maestri, W. (2021). La experiencia de implementar una historia clínica electrónica en siete centros

en menos de un año. Revista Metro Ciencia, 29(3), 32-38. https://doi.org/10.47464/MetroCiencia/vol29/3/2021/32-38

Fernández, L. I., y Huarac, Y. M. (2021). Plan de negocio para integrar a las IPRESS con una plataforma de historia clínica electrónica (HCE) utilizando tecnología blockchain. [Tesis de maestría, Universidad ESAN].

Fernández, L. E. M. (2022). Desarrollo de un sistema Web de historias clínicas electrónicas para mejorar la gestión en el proceso de consultas ambulatorias del Hospital Belén de Lambayeque.

Garrafa, V. (2023). Bioética y el derecho de acceso a los cuidados de salud. Salud Colectiva, 19, e4491.

Goetsch, D. L., & Davis, S. B. (2014). Quality management for organizational excellence. Pearson.

González, J. (2019). La producción científica latinoamericana sobre historia clínica digital: un análisis desde Scopus. Revista Cubana de Salud Pública, 45(3), e1312. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es_ES

Gutiérrez, U. M. (2021). Implementación de historia clínica electrónica en la mejora de la calidad de atención del servicio de odontología del Hospital Hermilio Valdizán Lima – Perú. [Tesis de maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos].

Hagström, J., Blease, C., Haage, B., & Scandurra, I. (2023). Views, Use, and Experiences of Web-Based Access to Pediatric Electronic Health Records for Children, Adolescents, and Parents: Scoping Review. Journal of Medical Internet Research.

Hair, J. F., Page, M., & Brunsveld, N. (2021). Essentials of Business Research Methods (5th ed.). Routledge.

Hamel, G., & Prahalad, C. K. (1990). The Core Competence of the Corporation. Harvard Business Review, 68(3), 79-91.

Harrington, H. J. (1991). Business Process Improvement. McGraw-Hill.

Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2018). Metodología de la investigación (7th ed.). McGraw-Hill Education.

Hoyle, D. (2015). ISO 9000 quality systems handbook. Routledge.

Huapaya, O., Palomino, J., Calle, C., Alvarez, G., Montesinos, R., y Taype, A. (2021). Experiencia del Complejo Hospitalario San Pablo (Perú) en la implementación de un sistema de historias clínicas electrónicas. An Fac med., 82(4), 349-354. https://doi.org/10.15381/anales.v82i4.22211

Iglesias, M. C. (2022). Herramientas digitales para la gestión pública: una aproximación acerca del uso de sistemas de información en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Sociales.

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Estadísticas sociales. Recuperado de https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/sociales/

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2023). Población peruana alcanzó las 33 millones 726 mil personas en el año 2023. Nota de Prensa. Recuperado de https://www.gob.pe/institucion/inei/noticias/795336-poblacion-peruana-alcanzo-los-33-millones-726-mil-personas-en-el-ano-2023

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Population estimates and projections. Recuperado de https://m.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/population-estimates-and-projections/

Janssen, A., Donnelly, C., Elder, E., Pathmanathan, N., & Shaw, T. (2021). Electronic medical record implementation in tertiary care: factors influencing adoption of an electronic medical record in a cancer centre. BMC Health Services Research, 21(1). https://doi.org/10.1186/s12913-020-06015-6 https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-020-06015-6

Jones, G. R. (2018). Organizational Theory, Design, and Change. Pearson.

Juran, J. M. (1992). Juran on Planning for Quality. Free Press

Juran, J. M., & DeFeo, J. A. (1999). Juran's Quality Handbook. McGraw-Hill.

Kademane, A., Kumar, P., & Chaudhary, B. (2023). Influencia de la historia clínica electrónica en la práctica de enfermería en el ámbito hospitalario. Salud, Ciencia y Tecnología, 3, 453-453.

Kliem, R. L., & Ludema, J. D. (2016). The Creative Team: Unleashing Creative Potential for Breakthrough Results. Palgrave Macmillan.

Koontz, H., & O'Donnell, C. (1978). Principles of Management: An Analysis of Managerial Functions. McGraw-Hill.

Kumar, R. (2019). Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners (5th ed.). SAGE Publications.

Leedy, P. D., & Ormrod, J. E. (2019). Practical research: Planning and design (12th ed.). Pearson.

León, J. L. (2023). Gestión por procesos y su relación con el servicio de atención al cliente. Caso Celilab. Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Llanos, Z. L. F., Castro, Q. J. A., Ortiz, F. J., y Ramírez, A. C. W. (2020). Cuando crear sinergia no siempre es Salud: Análisis y propuesta en la evolución del Sistema de Salud en Perú. Revista Médica Herediana, 31(1), 56-69

Llosas, J. B., y Sampietro-Colom, L. (2021). Salud digital: una oportunidad y un imperativo ético. Revista Diecisiete: Investigación Interdisciplinar para los Objetivos de Desarrollo Sostenible., (4), 137-144.

Macedo, A. S., Gontijo, T. L., Brito, C. J., Sanhudo, N. F., Faria, L. R., & Cavalcante, R. B. (2021). Implementation of an electronic medical record in light of the actor-network theory. Texto & Contexto Enfermagem, 30, e20200123. https://doi.org/10.1590/1980-265X-TCE-2020-0123

Maldonado, M. (2023). Comparación de la calidad del registro en las historias clínicas físicas y electrónicas del curso de Clínica Integral del Adulto V desarrollado en el Centro Dental Docente de la Facultad de Estomatología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en los años 2014 y 2023.

Mandiola, M. S., y Mery, M. D. (2021). Registro clínico electrónico (RCE) en una red privada blockchain. Universidad Andrés Bello. Chile

Marinho, M. L., Dahuabe, A., y Arenas de Mesa, A. (2023). Salud y desigualdad en América Latina y el Caribe: la centralidad de la salud para el desarrollo social inclusivo y sostenible. Número de informe LC/TS.2023/115. Santiago: CEPAL.

Mellizo, D., y Minú, J. (2020). Modelo basado en Blockchain para la implementación de una historia clínica electrónica familiar. RITI Journal, 8(16). https://doi.org/10.36825/RITI.08.16.002

Ministerio de Salud. (s. f.). XVIII Conferencia Nacional e Internacional de la Calidad en Salud. Acreditación para la Garantía de la Calidad en la Atención de Salud. Hospital II San Isidro Labrador. Recuperado de https://www.gob.pe/institucion/minsa/informes-publicaciones/4741067-xviii-conferencia-nacional-e-internacional-de-calidad-en-salud

Ministerio de Salud, Viceministerio de Salud Pública, Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. (2019). Análisis de la situación de salud del Perú 2019. Recuperado de https://www.dge.gob.pe/portal/docs/asis/Asis_peru19.pdf

Missoni, E. (2022). Elementos fundamentales del modelo de atención familiar de ESSALUD en el Perú. Programa EUROsociAL.

Morejón-Palacio, J. L., & González-Rodríguez, R. (2022). Acercamiento a la historia clínica electrónica en el contexto de la informatización en salud. Revista Médica Electrónica de la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas, 44(2), 403.

Morrisey, G.L. (1986). Creating Your Future: Personal Strategic Planning for Professionals. Accelerated Development.

Muijs, D. (2010). Doing Quantitative Research in Education with SPSS (2nd ed.). Sage Publications.

Neuman, W. L. (2014). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (7th ed.). Pearson.

Organización Internacional de Normalización (ISO). (2015). ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos.

Organización Mundial de la Salud. (2021). Estrategia mundial sobre salud digital 2020-2025 [Global strategy on digital health 2020-2025]. Ginebra. https://apps.who.int/iris/handle/10665/344540

Osborne, S. R., et al. (2020). Rapid reviews of health research issues affecting regional, rural and remote Australia. Medical Journal of Australia.

Otero, L., Wiebe, N., Niven, D. J., Ronksley, P. E., Iragorri, N., Robertson, H. L., & Quan, H. (2019). Evaluation of interventions to improve electronic health record documentation within the inpatient setting: a protocol for a systematic review. Systematic Reviews, 8(1). https://doi.org/10.1186/s13643-019-0971-2 https://systematicreviewsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13643-019-0971-2

Oviedo, A. M., y Gonzalez-Argote, J. (2022). Factores asociados con la resistencia a la implementación de la historia clínica electrónica. Revista Médica Militar, 51(4), e02202094.

Oviedo-Sarmiento, N., Álvarez, B., Pérez Alvarado, A., & Delgado Sánchez, J. L. (2020). Consideraciones respecto al uso de la historia clínica electrónica. Revista Médica del Uruguay, 36(4), 330-334.

Pérez, P. E., Valdés, J. C., Vasallo, J. C., López, R., & Ares, L. C. (2022). Previa inducción: ¿Existen diferencias en el uso e implementación de la historia clínica electrónica en relación con el nivel de formación y experiencia laboral? Salud, Ciencia y Tecnología, 2, 49. https://doi.org/10.56294/saludcyt202249

Perrow, C. (2014). Complex Organizations: A Critical Essay. McGraw-Hill Education.

Peters, T. J., & Waterman, R. H. (1982). In Search of Excellence. Harper & Row.

Plataforma única del Estado Peruano. (s.f.). Sacar una cita médica en EsSalud. Recuperado de https://www.gob.pe/277-sacar-una-cita-medica-en-essalud

Ponce de León, Z. (2021). Sistema de Salud en el Perú y el COVID-19.

Porter, M. E. (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. Free Press.

Quintero, R. S. G., Toirac, Y. G., Laffita, D. M., Rodríguez, I. G., Ruiz, R. L., y Silveira, S. A. G. (2021). Eficacia, efectividad, eficiencia y equidad en relación con la calidad en los servicios de salud. Infodir (Revista de Información para la Dirección en Salud), 17(35), 1-27.

Revuelta, M. E. G. (2023). Evolución de la historia clínica digital, retos y dificultades: Avances y desafíos en la seguridad de la historia clínica y el acceso a los datos de salud (Tesis Doctoral, Universidad de Almería).

Rodríguez, V. (2021). Gestión del manejo de las historias clínicas manuales vs las historias clínicas electrónicas. [Monografía de maestría, Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología].

Rosander, A. C. (1994). Los catorce puntos de Deming aplicados a los servicios. España: Díaz de Santos.

Sánchez, J. A., Paredes, C. V., Ramírez, M. C., & Galvis, S. (2022). Historia clínica electrónica interoperable: El caso de Colombia. Revista del Cuerpo Médico Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, 15(1), 153-154. https://doi.org/10.35434/rcmhnaaa.2022.151.1288

Sangüesa, M., Mateo, R., & Ilzarbe, L. (2019). Teoría y práctica de la calidad (2ª edición revisada y actualizada). Madrid: Paraninfo.

Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2016). Research Methods for Business Students (7th ed.). Pearson.

Seguro Social de Salud (EsSalud). (2023). Perfil de la Población Asegurada de EsSalud, I Trimestre 2023. Recuperado de https://repositorio.essalud.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12959/4201/Perfil

Shadish, W. R., Cook, T. D., & Campbell, D. T. (2002). Experimental and Quasi-Experimental Designs for Generalized Causal Inference. Houghton Mifflin Company.

Smidts, A., Pruyn, A. T. H., & Van Riel, C. B. M. (2001). The Impact of Employee Communication and Perceived External Prestige on Organizational Identification. Taylor & Francis.

Sociedad Nacional de Industrias. Comité de Gestión de la Calidad. (2024). Bases del Premio Nacional a la Calidad 2024 – Modelo de Excelencia en la Gestión.

Stanhope, V., & Matthews, E. B. (2019). Delivering person-centered care with an electronic health record. BMC Medical Informatics and Decision Making, 19(1). https://doi.org/10.1186/s12911-019-0897-6 https://bmcmedinformdecismak.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12911-019-0897-6

Superintendencia Nacional de Salud - SUSALUD. (2024). Registro Nominal de Asegurados. Recuperado de https://portal.susalud.gob.pe/wp-content/uploads/archivo/registros-afiliados/ftpqlikv/registros-afiliados/registro_afiliados_reniec/Afiliados_RENIEC_202402.pdf

Torres, C. A. (2020). Estudio e implementación de la Historia Clínica Electrónica a nivel nacional en Argentina. [Tesis de maestría, Universidad Torcuato Di Tella].

Trochim, W. M., Donnelly, J. P., & Arora, K. (2015). Research Methods: The Essential Knowledge Base (2nd ed.). Cengage Learning.

Tuanama, J. (2019). Adopción de una Historia Clínica Electrónica en Establecimientos de Salud de Primer Nivel: Una Aproximación Cualitativa a la Perspectiva del Personal de Salud. [Tesis de maestría, Universidad de Lima].

Wang, R. Y. (1996). Data Quality. The MIT Press.

Welch, M., & Jackson, P. R. (2007). Rethinking Internal Communication: A Stakeholder Approach. Routledge.

Woldemariam, M. T., & Jimma, W. (2023). Adoption of electronic health record systems to enhance the quality of healthcare in low-income countries: a systematic review. BMJ Health & Care Informatics, 30(1), e100704. https://doi.org/10.1136/bmjhci-2022-100704 https://informatics.bmj.com/content/30/1/e100704

ANEXOS

Anexo 1

MÉDICOS DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (EsSalud), SEGÚN RED ASISTENCIAL, 2013-2023	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Médicos Sede Central	484	479	515	486	521	524	558	1,093	1,454	720	642
Médicos Red Asistencial Almenara	1,726	1,871	1,990	2,028	2,099	2,105	2,139	2,133	2,308	2,005	1,928
Médicos Red Asistencial Rebagliati	2,092	2,172	2,300	2,419	2,464	2,527	2,506	2,647	2,794	2,414	2,350
Médicos Red Asistencial Sabogal	1,204	1,266	1,322	1,330	1,345	1,354	1,385	1,763	1,885	1,418	1,436
Total (1)	**5,506**	**5,788**	**6,127**	**6,263**	**6,429**	**6,510**	**6,588**	**7,636**	**8,441**	**6,557**	**6,356**
Porcentaje de población con acceso a EsSalud Lima Metropolitana (43 distritos) en porcentaje (2)	**33.33**	**34.45**	**35.01**	**34.11**	**34.83**	**32.82**	**33.07**	**30.85**	**29.50**	**28.18**	**30.93**
Cantidad de habitantes Lima Metropolitana (3)	**9,214,448**	**9,352,360**	**9,514,151**	**9,711,755**	**9,939,885**	**10,180,641**	**10,416,139**	**10,628,470**	**10,814,450**	**10,986,006**	**11,147,924**
									3,190,404	3,095,966	3,448,449
									378	472	543
										24.92%	14.91%

(1) https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/sociales/ - MÉDICOS DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (EsSalud), SEGÚN RED ASISTENCIAL, 2013-2023
(2) https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/sociales/ - POBLACIÓN AFILIADA A SEGURO SOCIAL DE SALUD - EsSalud, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2013-2023
(3) https://m.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/population-estimates-and-projections/ - Población Estimada al 30 de junio, por años calendario y sexo, según departamento, 2000-2024

Matriz de Consistencia

"Influencia de la Historia Clínica Electrónica Única en la gestión de la calidad de un hospital de EsSalud, 2024"					
Situación Problemática	**Pregunta General**	**Preguntas Específicas (PE's)**			
		PE 1	**PE 2**	**PE 3**	**PE 4**
	¿Cuál es la influencia de la Historia Clínica Electrónica Única en la gestión de la calidad de un hospital de EsSalud, 2024?	¿Cuál es la influencia de la Historia Clínica Electrónica Única en la planificación de un hospital de EsSalud, 2024?	¿Cuál es la influencia de la Historia Clínica Electrónica Única en la organización de un hospital de EsSalud, 2024?	¿Cuál es la influencia de la Historia Clínica Electrónica Única en la garantía y mejoramiento de los servicios de un hospital de EsSalud, 2024?	¿Cuál es la influencia de la Historia Clínica Electrónica Única en la idoneidad de la información de un hospital de EsSalud, 2024?
Objetivos de Investigación	**Objetivo General**	**Objetivos Específicos (OE's)**			
		OE 1	**OE 2**	**OE 3**	**OE 4**
	Determinar la influencia de la Historia Clínica Electrónica Única en la gestión de la calidad de un hospital de EsSalud, 2024.	Determinar la influencia de la Historia Clínica Electrónica Única en la planificación de un hospital de EsSalud, 2024.	Determinar la influencia de la Historia Clínica Electrónica Única en la organización de un hospital de EsSalud, 2024.	Determinar la influencia de la Historia Clínica Electrónica Única en la garantía y mejoramiento de los servicios de un hospital de EsSalud, 2024.	Determinar la influencia de la Historia Clínica Electrónica Única en la idoneidad de la información de un hospital de EsSalud, 2024.
Hipótesis de la Investigación	**Hipótesis General**	**Hipótesis Específicas (HE's)**			
		HE 1	**HE 2**	**HE 3**	**HE 4**
	La Historia Clínica Electrónica Única tiene una influencia positiva y significativa en la gestión de la calidad de un hospital de EsSalud, 2024.	La Historia Clínica Electrónica Única tiene una influencia positiva y significativa en la planificación de un hospital de EsSalud, 2024.	La Historia Clínica Electrónica Única tiene una influencia positiva y significativa en la organización de un hospital de EsSalud, 2024.	La Historia Clínica Electrónica Única tiene una influencia positiva y significativa en la garantía y mejoramiento de los servicios de un hospital de EsSalud, 2024.	La Historia Clínica Electrónica Única tiene una influencia positiva y significativa en la idoneidad de la información de un hospital de EsSalud, 2024.

Instrumentos de recopilación de datos

Cuestionario del tipo encuesta:

Variable Independiente: Historia Clínica Electrónica Única

1. La institución cuenta con un plan de proyecto integral que permite un adecuado funcionamiento de la Historia Clínica Electrónica Única.

1 = Totalmente en desacuerdo

2 = En desacuerdo

3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo

4 = De acuerdo

5 = Totalmente de acuerdo

2. La institución cuenta con los recursos (humanos, técnicos y financieros) suficientes que garantizan el adecuado funcionamiento de la Historia Clínica Electrónica Única.

1 = Totalmente en desacuerdo

2 = En desacuerdo

3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo

4 = De acuerdo

5 = Totalmente de acuerdo

3. La institución otorga capacitaciones oportunas a los colaboradores sobre el uso adecuado de la Historia Clínica Electrónica Única.

1 = Totalmente en desacuerdo

2 = En desacuerdo

3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo

4 = De acuerdo

5 = Totalmente de acuerdo

4. La institución cuenta con un adecuado soporte técnico para solucionar cualquier inconveniente respecto al funcionamiento de la Historia Clínica Electrónica Única.

1 = Totalmente en desacuerdo

2 = En desacuerdo

3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo

4 = De acuerdo

5 = Totalmente de acuerdo

5. La Historia Clínica Electrónica Única se integra adecuadamente con los demás sistemas informáticos de la Institución.

1 = Totalmente en desacuerdo

2 = En desacuerdo

3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo

4 = De acuerdo

5 = Totalmente de acuerdo

6. La Historia Clínica Electrónica Única es amigable en su uso y funcionamiento.

1 = Totalmente en desacuerdo

2 = En desacuerdo

3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo

4 = De acuerdo

5 = Totalmente de acuerdo

7. El uso de la Historia Clínica Electrónica Única contribuye a la mejora en la eficiencia de los procesos clínicos y administrativos.

1 = Totalmente en desacuerdo

2 = En desacuerdo

3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo

4 = De acuerdo

5 = Totalmente de acuerdo

8. El uso de la Historia Clínica Electrónica Única contribuye al incremento de la satisfacción general de los usuarios.

1 = Totalmente en desacuerdo

2 = En desacuerdo

3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo

4 = De acuerdo

5 = Totalmente de acuerdo

Variable dependiente: Gestión de la Calidad

1. La institución cuenta con un adecuado plan estratégico de recursos y servicios de atención médica.

1 = Totalmente en desacuerdo

2 = En desacuerdo

3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo

4 = De acuerdo

5 = Totalmente de acuerdo

2. La institución actualiza su plan estratégico de recursos y servicios de atención médica.

1 = Totalmente en desacuerdo

2 = En desacuerdo

3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo

4 = De acuerdo

5 = Totalmente de acuerdo

3. Las actividades que realiza cada colaborador están claramente definidas en la institución.

1 = Totalmente en desacuerdo

2 = En desacuerdo

3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo

4 = De acuerdo

5 = Totalmente de acuerdo

4. Los colaboradores de la institución se comunican y actúan coordinadamente para el cumplimiento de las metas.

1 = Totalmente en desacuerdo

2 = En desacuerdo

3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo

4 = De acuerdo

5 = Totalmente de acuerdo

5. La institución realiza de manera constante acciones adecuadas para mejorar la calidad en los servicios de salud.

1 = Totalmente en desacuerdo

2 = En desacuerdo

3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo

4 = De acuerdo

5 = Totalmente de acuerdo

6. La institución cuenta con la capacidad y recursos para optimizar la calidad de atención.

1 = Totalmente en desacuerdo

2 = En desacuerdo

3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo

4 = De acuerdo

5 = Totalmente de acuerdo

7. La institución cuenta con un adecuado sistema de recopilación de datos clínicos.

1 = Totalmente en desacuerdo

2 = En desacuerdo

3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo

4 = De acuerdo

5 = Totalmente de acuerdo

8. La institución cuenta con un adecuado sistema que permite la seguridad de los registros médicos.

1 = Totalmente en desacuerdo

2 = En desacuerdo

3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo

4 = De acuerdo

5 = Totalmente de acuerdo

Consentimiento informado para el uso de la información de la institución/organización

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL USO DE LA INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN

Por el presente documento, aprobamos el uso de la información de HOSPITAL II E SAN ISIDORO LABRADOR ESSALUD para que el alumno **SERGIO ISAIAS DE JESUS ESPARZA MORGAN** pueda desarrollar el trabajo de grado titulado **IMPLEMENTACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA ÚNICA PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EsSalud, 2024.** Por tal motivo, nos comprometemos a brindar las facilidades necesarias en términos de acceso a la información relacionada para el desarrollo de su trabajo de grado, así como aceptamos su utilización con fines académicos y colocación en diversas bases de datos y/o concursos nacionales e internacionales, en formato digital y/o impreso.

Se firma el presente documento en señal de conformidad:

(Firma y sello del Representante Legal de la institución/organización)

Dr. Hector H. Berastain Merino
Director
H.II Clinica Geriatrica San Isidro Labrador
RED PRESTACIONAL ALMENARA
EsSalud

Nombres y apellidos: HECTOR HELLMUTH BERASTAIN MERINO

DNI: 07537791

Correo electrónico: hector.berastain@essalud.gob.pe

Teléfono: 997415834

Fecha: 17-11-2023

Informes de validación por juicio de expertos

ESCUELA DE POSTGRADO
UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA

ANEXO 8-A: INFORME DE JUCIO DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN - PRIMERA VARIABLE

I. DATOS GENERALES:

Validado por:

1.1. Apellidos y Nombres del experto:	Cruz Bejarano Segundo Rogelio
1.2. Grado académico	Maestro ( ) Doctor (X)
1.3. Cargo e institución del experto:	Coordinador del Programa de Seguimiento y Atención Integrada e Integral del Neonato de Alto Riesgo del Instituto Nacional Materno Perinatal
1.4. Nombre del instrumento:	CUESTIONARIO VARIABLE INDEPENDIENTE "IMPLEMENTACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA ÚNICA"
1.5. Autor del instrumento:	ESPARZA MORGAN SERGIO ISAIAS DE JESUS
1.6. Tipo de validador	Interno (Docente USIL) ( ) Externo (X)
1.7. Título de la investigación	IMPLEMENTACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA ÚNICA PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EN ESSALUD, 2023

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN:

CRITERIOS	INDICADORES	Deficiente 0-20%	Regular 21-40%	Buena 41-60%	Muy buena 61-80%	Excelente 81-100%
RELEVANCIA	Los ítems son pertinentes para cumplir con el objetivo de estudio y están directamente vinculados a la temática investigada					X
CONSISTENCIA	Las preguntas son coherentes en cuanto a la estructura y contenido.					X
FINALIDAD	Las preguntas se enfocan a cumplir los objetivos de la investigación.					X
ACTUALIDAD	El instrumento está basado en información actualizada y relevante.					X
IMPARCIALIDAD	Las preguntas están libres de sesgos y prejuicios, ya que no se evidencia influencia de investigador en las respuestas de los participantes.					X
TRANSPARENCIA	Las preguntas utilizan lenguaje claro y comprensible para los participantes y, no oculta información importante.					X
METODOLOGÍA	Se evidencia que las preguntas están basadas en un marco teórico y conceptual sólido.					X
ORGANIZACIÓN	La organización del instrumento está estructurada de manera lógica y coherente.					X
COMPRENSIÓN	El instrumento es fácil de entender, pues utiliza un lenguaje claro y conciso.					X
SUFICIENCIA	Contiene preguntas o ítems adecuados y necesarios para obtener la información requerida.					X
PROMEDIO DE VALIDACIÓN		**81-100%**				

ESCUELA DE POSTGRADO
UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA

PREGUNTAS O ÍTEMS OBSERVADOS – VARIABLE 1 O INDEPENDIENTE

Pregunta observada	Observación

La evaluación se realiza de todos los ítems de la variable

III. PROMEDIO DE VALORACIÓN:____81-100%____%. V: OPINIÓN DE APLICABILIDAD:

(X) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado

( ) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado.

Fecha: 14/04/2024

DNI. Experto N°: 17839712

Firma del experto

Nombres y apellidos **Segundo Rogelio Cruz Bejarano**

Grado académico (Mg, Dr): **Doctor**

Código ORCID: **https://orcid.org/0000-0001-5249-2383**

ESCUELA DE POSTGRADO
UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA

ANEXO 8-B: INFORME DE JUCIO DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN – SEGUNDA VARIABLE

I. DATOS GENERALES:

Validado por:

1.1. Apellidos y Nombres del experto:	Cruz Bejarano Segundo Rogelio
1.2. Grado académico	Maestro ( ) Doctor (X)
1.3. Cargo e institución del experto:	Coordinador del Programa de Seguimiento y Atención Integrada e Integral del Neonato de Alto Riesgo del Instituto Nacional Materno Perinatal
1.4. Nombre del instrumento:	CUESTIONARIO VARIABLE DEPENDIENTE "GESTIÓN DE LA CALIDAD"
1.5. Autor del instrumento:	ESPARZA MORGAN SERGIO ISAIAS DE JESUS
1.6. Tipo de validador	Interno (Docente USIL) ( ) Externo (X)
1.7. Título de la investigación	IMPLEMENTACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA ÚNICA PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EN ESSALUD, 2023

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN:

CRITERIOS	INDICADORES	Deficiente 0-20%	Regular 21-40%	Buena 41-60%	Muy buena 61-80%	Excelente 81-100%
RELEVANCIA	Los ítems son pertinentes para cumplir con el objetivo de estudio y están directamente vinculados a la temática investigada					X
CONSISTENCIA	Las preguntas son coherentes en cuanto a la estructura y contenido.					X
FINALIDAD	Las preguntas se enfocan a cumplir los objetivos de la investigación.					X
ACTUALIDAD	El instrumento está basado en información actualizada y relevante.					X
IMPARCIALIDAD	Las preguntas están libres de sesgos y prejuicios, ya que no se evidencia influencia de investigador en las respuestas de los participantes.					X
TRANSPARENCIA	Las preguntas utilizan lenguaje claro y comprensible para los participantes y, no oculta información importante.					X
METODOLOGÍA	Se evidencia que las preguntas están basadas en un marco teórico y conceptual sólido.					X
ORGANIZACIÓN	La organización del instrumento está estructurada de manera lógica y coherente.					X
COMPRENSIÓN	El instrumento es fácil de entender, pues utiliza un lenguaje claro y conciso.					X
SUFICIENCIA	Contiene preguntas o ítems adecuados y necesarios para obtener la información requerida.					X
PROMEDIO DEVALIDACIÓN		**81-100%**				

ESCUELA DE POSTGRADO
UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA

PREGUNTAS O ÍTEMS OBSERVADOS – VARIABLE 2 O DEPENDIENTE

Pregunta observada	Observación

La evaluación se realiza de todos los ítems de la variable

III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 81-100% %. V: OPINIÓN DE APLICABILIDAD:

(X) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado

( ) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado.

Fecha: 14/04/2024

Firma del experto

DNI. Experto N°: 17839712

Nombres y apellidos **Segundo Rogelio Cruz Bejarano**

Grado académico (Mg, Dr): **Doctor**

Código ORCID: **https://orcid.org/0000-0001-5249-2383**

ESCUELA DE POSTGRADO
UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA

ANEXO 8-A: INFORME DE JUCIO DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN - PRIMERA VARIABLE

I. DATOS GENERALES:

Validado por:

1.1. Apellidos y Nombres del experto:	Valverde Montalva Hernán Renzo
1.2. Grado académico	Maestro (X) Doctor ( )
1.3. Cargo e institución del experto:	Profesor de Ortodoncia del Departamento Académico del Niño y Adolescente en la UPCH
1.4. Nombre del instrumento:	CUESTIONARIO VARIABLE INDEPENDIENTE "IMPLEMENTACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA ÚNICA"
1.5. Autor del instrumento:	ESPARZA MORGAN SERGIO ISAIAS DE JESUS
1.6. Tipo de validador	Interno (Docente USIL) ( ) Externo (X)
1.7. Título de la investigación	IMPLEMENTACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA ÚNICA PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EN ESSALUD, 2023

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN:

CRITERIOS	INDICADORES	Deficiente 0-20%	Regular 21-40%	Buena 41-60%	Muy buena 61-80%	Excelente 81-100%
RELEVANCIA	Los ítems son pertinentes para cumplir con el objetivo de estudio y están directamente vinculados a la temática investigada					X
CONSISTENCIA	Las preguntas son coherentes en cuanto a la estructura y contenido.					X
FINALIDAD	Las preguntas se enfocan a cumplir los objetivos de la investigación.					X
ACTUALIDAD	El instrumento está basado en información actualizada y relevante.					X
IMPARCIALIDAD	Las preguntas están libres de sesgos y prejuicios, ya que no se evidencia influencia de investigador en las respuestas de los participantes.					X
TRANSPARENCIA	Las preguntas utilizan lenguaje claro y comprensible para los participantes y, no oculta información importante.					X
METODOLOGÍA	Se evidencia que las preguntas están basadas en un marco teórico y conceptual sólido.					X
ORGANIZACIÓN	La organización del instrumento está estructurada de manera lógica y coherente.					X
COMPRENSIÓN	El instrumento es fácil de entender, pues utiliza un lenguaje claro y conciso.					X
SUFICIENCIA	Contiene preguntas o ítems adecuados y necesarios para obtener la información requerida.					X
PROMEDIO DE VALIDACIÓN		**81-100%**				

ESCUELA DE POSTGRADO
UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA

PREGUNTAS O ÍTEMS OBSERVADOS – VARIABLE 1 O INDEPENDIENTE

Pregunta observada	Observación

La evaluación se realiza de todos los ítems de la variable

III. PROMEDIO DE VALORACIÓN:____81-100%____%. V: OPINIÓN DE APLICABILIDAD:

(X) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado

( ) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado.

Fecha: 11/04/2024

DNI. Experto N°: 09388182

Firma del experto

Nombres y apellidos **Hernán Renzo Valverde Montalva**

Grado académico (Mg, Dr): **Maestro**

Código ORCID: **https://orcid.org/0000-0003-3659-5782**

ESCUELA DE POSTGRADO
UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA

ANEXO 8-B: INFORME DE JUCIO DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN – SEGUNDA VARIABLE

I. DATOS GENERALES:

Validado por:

1.1. Apellidos y Nombres del experto:	Valverde Montalva Hernán Renzo
1.2. Grado académico	Maestro (X) Doctor ( )
1.3. Cargo e institución del experto:	Profesor de Ortodoncia del Departamento Académico del Niño y Adolescente en la UPCH
1.4. Nombre del instrumento:	CUESTIONARIO VARIABLE DEPENDIENTE "GESTIÓN DE LA CALIDAD"
1.5. Autor del instrumento:	ESPARZA MORGAN SERGIO ISAIAS DE JESUS
1.6. Tipo de validador	Interno (Docente USIL) ( ) Externo (X)
1.7. Título de la investigación	IMPLEMENTACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA ÚNICA PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EN ESSALUD, 2023

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN:

CRITERIOS	INDICADORES	Deficiente 0-20%	Regular 21-40%	Buena 41-60%	Muy buena 61-80%	Excelente 81-100%
RELEVANCIA	Los ítems son pertinentes para cumplir con el objetivo de estudio y están directamente vinculados a la temática investigada					X
CONSISTENCIA	Las preguntas son coherentes en cuanto a la estructura y contenido.					X
FINALIDAD	Las preguntas se enfocan a cumplir los objetivos de la investigación.					X
ACTUALIDAD	El instrumento está basado en información actualizada y relevante.					X
IMPARCIALIDAD	Las preguntas están libres de sesgos y prejuicios, ya que no se evidencia influencia de investigador en las respuestas de los participantes.					X
TRANSPARENCIA	Las preguntas utilizan lenguaje claro y comprensible para los participantes y, no oculta información importante.					X
METODOLOGÍA	Se evidencia que las preguntas están basadas en un marco teórico y conceptual sólido.					X
ORGANIZACIÓN	La organización del instrumento está estructurada de manera lógica y coherente.					X
COMPRENSIÓN	El instrumento es fácil de entender, pues utiliza un lenguaje claro y conciso.					X
SUFICIENCIA	Contiene preguntas o ítems adecuados y necesarios para obtener la información requerida.					X
PROMEDIO DE VALIDACIÓN		**81-100%**				

ESCUELA DE POSTGRADO
UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA

PREGUNTAS O ÍTEMS OBSERVADOS – VARIABLE 2 O DEPENDIENTE

Pregunta observada	Observación

La evaluación se realiza de todos los ítems de la variable

III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 81-100% %. V: OPINIÓN DE APLICABILIDAD:

(X) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado

( ) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado.

Fecha: 11/04/2024

DNI. Experto N°: 09388182

Firma del experto

Nombres y apellidos **Hernán Renzo Valverde Montalva**

Grado académico (Mg, Dr): **Maestro**

Código ORCID: **https://orcid.org/0000-0003-3659-5782**

Diseño del cuestionario aplicado

Implementación de la Historia Clínica Electrónica Única para mejorar la gestión de la calidad en EsSalud

Estimado(a) participante,

Le invitamos a contribuir a esta encuesta como parte de un trabajo de investigación de maestría en Gestión Pública, que tiene como objetivo evaluar la implementación de la Historia Clínica Electrónica Única en EsSalud. Su participación es crucial para entender los efectos de esta implementación en la mejora de la gestión de la calidad en los servicios de salud.

Los datos recogidos serán utilizados exclusivamente para fines académicos y contribuirán a formular recomendaciones para optimizar los procesos. La encuesta es anónima y solo requerirá unos minutos para completar.

Agradecemos su tiempo y valiosa colaboración.

sesparzam@gmail.com Cambiar de cuenta

No compartido

* Indica que la pregunta es obligatoria

Edad *

- Menos de 25 años
- 25 a 34 años
- 35 a 44 años
- 45 a 54 años
- 55 a 64 años
- 65 años o más

Género *

- Femenino
- Masculino
- Otro
- Prefiero no decir

Ocupación *

- ◯ Personal médico (médicos, enfermeras)
- ◯ Personal administrativo
- ◯ Técnico de salud (laboratorio, radiología, etc.)
- ◯ Dirección/Gestión
- ◯ Prefiero no decir
- ◯ Otro: _____

¿Cuánto tiempo lleva trabajando en EsSalud? *

- ◯ Menos de 1 año
- ◯ 1 a 3 años
- ◯ 4 a 6 años
- ◯ 7 a 10 años
- ◯ Más de 10 años

La institución cuenta con un plan de proyecto integral que permite un adecuado funcionamiento de la Historia Clínica Electrónica Única. *

- ◯ Totalmente en desacuerdo.
- ◯ En desacuerdo.
- ◯ Ni de acuerdo ni en desacuerdo.
- ◯ De acuerdo.
- ◯ Totalmente de acuerdo.

La institución cuenta con los recursos (humanos, técnicos y financieros) suficientes que garantizan el adecuado funcionamiento de la Historia Clínica Electrónica Única. *

- ◯ Totalmente en desacuerdo.
- ◯ En desacuerdo.
- ◯ Ni de acuerdo ni en desacuerdo.
- ◯ De acuerdo.
- ◯ Totalmente de acuerdo.

La institución otorga capacitaciones oportunas a los colaboradores sobre el uso adecuado de la Historia Clínica Electrónica Única. *

- Totalmente en desacuerdo.
- En desacuerdo.
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo.
- De acuerdo.
- Totalmente de acuerdo.

La institución cuenta con un adecuado soporte técnico para solucionar cualquier inconveniente respecto al funcionamiento de la Historia Clínica Electrónica Única. *

- Totalmente en desacuerdo.
- En desacuerdo.
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo.
- De acuerdo.
- Totalmente de acuerdo.

La Historia Clínica Electrónica Única se integra adecuadamente con los demás sistemas informáticos de la Institución. *

- Totalmente en desacuerdo.
- En desacuerdo.
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo.
- De acuerdo.
- Totalmente de acuerdo.

La Historia Clínica Electrónica Única es amigable en su uso y funcionamiento. *

- Totalmente en desacuerdo.
- En desacuerdo.
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo.
- De acuerdo.
- Totalmente de acuerdo.

El uso de la Historia Clínica Electrónica Única contribuye a la mejora en la eficiencia de los procesos clínicos y administrativos. *

- Totalmente en desacuerdo.
- En desacuerdo.
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo.
- De acuerdo.
- Totalmente de acuerdo.

El uso de la Historia Clínica Electrónica Única contribuye al incremento de la satisfacción general de los usuarios. *

- Totalmente en desacuerdo.
- En desacuerdo.
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo.
- De acuerdo.
- Totalmente de acuerdo.

La institución cuenta con un adecuado plan estratégico de recursos y servicios de atención médica. *

- Totalmente en desacuerdo.
- En desacuerdo.
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo.
- De acuerdo.
- Totalmente de acuerdo.

La institución actualiza su plan estratégico de recursos y servicios de atención médica. *

- Totalmente en desacuerdo.
- En desacuerdo.
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo.
- De acuerdo.
- Totalmente de acuerdo.

Las actividades que realiza cada colaborador están claramente definidas en la institución. *

- Totalmente en desacuerdo.
- En desacuerdo.
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo.
- De acuerdo.
- Totalmente de acuerdo.

Los colaboradores de la institución se comunican y actúan coordinadamente para el cumplimiento de las metas. *

- Totalmente en desacuerdo.
- En desacuerdo.
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo.
- De acuerdo.
- Totalmente de acuerdo.

La institución realiza de manera constante acciones adecuadas para mejorar la calidad en los servicios de salud. *

- Totalmente en desacuerdo.
- En desacuerdo.
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo.
- De acuerdo.
- Totalmente de acuerdo.

La institución cuenta con la capacidad y recursos para optimizar la calidad de atención. *

- Totalmente en desacuerdo.
- En desacuerdo.
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo.
- De acuerdo.
- Totalmente de acuerdo.

La institución cuenta con un adecuado sistema de recopilación de datos clínicos. *

- ◯ Totalmente en desacuerdo.
- ◯ En desacuerdo.
- ◯ Ni de acuerdo ni en desacuerdo.
- ◯ De acuerdo.
- ◯ Totalmente de acuerdo.

La institución cuenta con un adecuado sistema que permite la seguridad de los registros médicos. *

- ◯ Totalmente en desacuerdo.
- ◯ En desacuerdo.
- ◯ Ni de acuerdo ni en desacuerdo.
- ◯ De acuerdo.
- ◯ Totalmente de acuerdo.

Comentario adicional

Tu respuesta

Enviar

Borrar formulario

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. Denunciar abuso - Términos del Servicio - Política de Privacidad

Google Formularios

Muestra de respuestas al cuestionario adecuadas a la escala de Likert

VARIABLE 1 (V1)								VARIABLE 2 (V2)							
Historia Clínica Electrónica Única								Gestión de la Calidad							
Planificación y Desarrollo		Capacitación y Soporte		Funcionalidad y Usabilidad		Impacto y Efectividad		Planificación		Organización		Garantía y Mejoramiento de los Servicios		Idoneidad de la Información	
La institución cuenta con un plan de proyecto integral que permite un adecuado funcionamiento de la Historia Clínica Electrónica Única.	La institución cuenta con los recursos (humanos, técnicos y financieros) suficientes que garantizan el adecuado funcionamiento de la Historia Clínica Electrónica Única.	La institución otorga capacitaciones oportunas a los colaboradores sobre el uso adecuado de la Historia Clínica Electrónica Única.	La institución cuenta con un adecuado soporte técnico para solucionar cualquier inconveniente respecto al funcionamiento de la Historia Clínica Electrónica Única.	La Historia Clínica Electrónica Única se integra adecuadamente con los demás sistemas informáticos de la Institución.	La Historia Clínica Electrónica Única es amigable en su uso y funcionamiento.	El uso de la Historia Clínica Electrónica Única contribuye a la mejora en la eficiencia de los procesos clínicos y administrativos.	El uso de la Historia Clínica Electrónica Única contribuye al incremento de la satisfacción general de los usuarios.	La institución cuenta con un adecuado plan estratégico de recursos y servicios de atención médica.	La institución actualiza su plan estratégico de recursos y servicios de atención médica.	Las actividades que realiza cada colaborador están claramente definidas en la institución.	Los colaboradores de la institución se comunican y actúan coordinadamente para el cumplimiento de las metas.	La institución realiza de manera constante acciones adecuadas para mejorar la calidad en los servicios de salud.	La institución cuenta con la capacidad y recursos para optimizar la calidad de atención.	La institución cuenta con un adecuado sistema de recopilación de datos clínicos.	La institución cuenta con un adecuado sistema que permite la seguridad de los registros médicos.
P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16
5	4	5	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	2	2	3	1	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5
4	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	5	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	5	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1	1	1	1	1	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	5	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1	1	1	1	1	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	5	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5